Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ENDOMETRIOSIS (LOCALIZACIÓN EXTRAPÉLVICA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 431

Mujer de 31 años con antecedente de cesárea hace 2 años. Consulta por la presencia de una tumoración dolorosa en la cicatriz de la cesárea, la cual aumenta de tamaño y presenta sangrado escaso de forma cíclica, coincidiendo con sus periodos menstruales.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el tratamiento de elección?

A) Endometriosis de pared abdominal; Escisión quirúrgica completa *

B) Granuloma a cuerpo extraño; Antibióticos.

C) Hernia incisional; Plastia de pared con malla.

D) Queloide infectado; Esteroides intralesionales.

Retroalimentación:

La endometriosis puede presentarse en cicatrices quirúrgicas tras procedimientos que involucran el útero. La clave diagnóstica es la "ciclicidad" de los síntomas (dolor y tumefacción durante la menstruación).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ENDOMETRIOSIS (INFERTILIDAD Y MANEJO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 432

Paciente de 28 años con endometriosis grado IV (severa) diagnosticada por laparoscopia, con presencia de múltiples adherencias firmes que distorsionan la anatomía anexial. Desea lograr un embarazo.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo principal de infertilidad en pacientes con endometriosis severa y cuál es la conducta recomendada si la cirugía conservadora falla?

A) Distorsión anatómica de las trompas y factores inflamatorios peritoneales; Fertilización In Vitro (FIV) *

B) Hiperandrogenismo; Citrato de clomifeno.

C) Atresia folicular prematura; Donación de óvulos.

D) Obstrucción cervical; Inseminación artificial.

Retroalimentación:

En estadios avanzados, la endometriosis causa adherencias que impiden la captación del óvulo por la fimbria. La FIV se convierte en la mejor opción cuando la arquitectura pélvica está muy comprometida.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (RESISTENCIA A LA INSULINA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 433

Paciente con SOP y un Índice de Masa Corporal (IMC) de 34 kg/m^2. Presenta acantosis nigricans en cuello y axilas. Sus niveles de glucosa en ayuno son de 115 mg/dL.

Pregunta 1

¿Qué fármaco sensibilizador de insulina debe añadirse al manejo para mejorar la tasa de ovulación y reducir el riesgo de progresión a DM2?

A) Metformina *

B) Glibenclamida.

C) Liraglutida.

D) Acarbosa.

Retroalimentación:

La metformina disminuye la producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad periférica a la insulina, lo cual secundariamente reduce los niveles de andrógenos y puede restaurar la ciclicidad ovulatoria en algunas pacientes.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: SOP (DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 434

Mujer de 25 años acude por datos de virilización rápida (clitoromegalia, voz grave, alopecia) e hirsutismo severo de solo 6 meses de evolución. Sus niveles de Testosterona total se reportan en 250 ng/dL (muy elevados).

Pregunta 1

¿Qué diagnóstico debe descartarse prioritariamente ante una virilización de inicio súbito y niveles de testosterona >200 ng/dL?

A) Tumor productor de andrógenos (ovárico o adrenal) *

B) Síndrome de Ovario Poliquístico.

C) Hipotiroidismo.

D) Hiperprolactinemia.

Retroalimentación:

El SOP es una patología de instauración lenta (desde la pubertad). Una virilización rápida y niveles de testosterona francamente tumorales (>200 ng/dL) obligan a realizar estudios de imagen (TAC/RM) para buscar neoplasias.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: MENOPAUSIA Y CLIMATERIO

Dificultad: Baja

Caso Clínico 435

Femenina de 52 años refiere ausencia de menstruación desde hace 14 meses. Presenta bochornos intensos que interrumpen el sueño, sequedad vaginal y labilidad emocional. No tiene antecedentes de importancia ni tabaquismo. Útero íntegro.

Pregunta 1

¿Cómo se define la menopausia y cuál es el esquema de Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) indicado para esta paciente?

A) Cese de la menstruación por 12 meses; Esquema combinado (Estrógenos + Progestágenos) *

B) Disminución de la libido; Estrógenos solos.

C) Elevación de LH; Testosterona.

D) Presencia de bochornos; Solo progesterona.

Pregunta 2

¿Por qué es obligatorio añadir un progestágeno a la terapia estrogénica en una paciente con útero?

A) Para prevenir la hiperplasia y el cáncer de endometrio *

B) Para mejorar la absorción del estrógeno.

C) Para evitar la mastopatía.

D) Para controlar los niveles de glucosa.

Retroalimentación:

La TRH es el tratamiento de elección para síntomas vasomotores. En pacientes con útero, el estrógeno "sin oposición" causaría sobrecrecimiento endometrial; la progesterona se añade para proteger el endometrio.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: OSTEOPOROSIS POSTMENOPÁUSICA

Dificultad: Media

Caso Clínico 436

Paciente de 65 años en protocolo de salud ósea. El T-score en columna lumbar es de -2.8. No ha tenido fracturas previas.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea y qué recomendación posológica es vital para evitar efectos adversos gastrointestinales?

A) Bisfonatos orales (Alendronato); Tomar en ayunas con agua simple y permanecer erguido 30 minutos *

B) Calcio y Vitamina D únicamente; Tomar antes de dormir.

C) Teriparatida; Administración subcutánea nocturna.

D) Estrógenos conjugados; Aplicación vaginal.

Retroalimentación:

Los bisfosfonatos inhiben la resorción ósea por los osteoclastos. Su principal complicación es la esofagitis erosiva, de ahí las estrictas recomendaciones de administración.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (MASTOPATÍA FIBROQUÍSTICA)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 437

Paciente de 25 años refiere dolor mamario bilateral (mastalgia) que aumenta una semana antes de su menstruación y desaparece al iniciar el sangrado. A la exploración se palpan zonas de consistencia nodular, irregulares, difusas en ambos cuadrantes superiores externos. No hay secreción por el pezón.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el manejo inicial recomendado?

A) Mastopatía fibroquística; Medidas generales (soporte firme, evitar metilxantinas/cafeína) y analgésicos *

B) Fibroadenoma; Biopsia excisional.

C) Cáncer de mama inflamatorio; Quimioterapia.

D) Mastitis granulomatosa; Esteroides.

Retroalimentación:

Es la condición benigna más frecuente de la mama. Su característica principal es la ciclicidad hormonal. No se considera una lesión premaligna.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (FIBROADENOMA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 438

Mujer de 20 años se detecta nódulo en mama derecha. A la exploración: tumoración de 2 cm, esférica, bordes regulares, consistencia firme-elástica, muy móvil y no dolorosa. No se palpan adenopatías axilares.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico y qué estudio de imagen es el de elección para esta paciente dada su edad?

A) Fibroadenoma; Ultrasonido mamario *

B) Quiste simple; Mastografía.

C) Papiloma intraductal; Galactografía.

D) Necrosis grasa; Resonancia magnética.

Retroalimentación:

El fibroadenoma es el tumor benigno más común en mujeres jóvenes. En menores de 35 años, el tejido mamario es denso, por lo que el ultrasonido es superior a la mastografía para caracterizar lesiones.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (PAPILOMA INTRADUCTAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 439

Paciente de 40 años acude por presentar telorragia (secreción hemática) por un solo poro del pezón derecho, de forma espontánea. No se palpan masas.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más frecuente de secreción hemática uniorificial y cuál es la conducta a seguir?

A) Papiloma intraductal; Resección del conducto afectado (Microdococtomía) para estudio histopatológico *

B) Ectasia ductal; Compresas calientes.

C) Cáncer ductal in situ; Mastectomía.

D) Galactorrea; Medición de prolactina.

Retroalimentación:

Aunque la mayoría de los papilomas son benignos, la telorragia siempre debe investigarse para descartar malignidad, especialmente si es uniductal y espontánea.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (CONDICIONES INFLAMATORIAS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 440

Paciente de 26 años, cursando su tercera semana de lactancia materna. Presenta dolor, eritema y calor en cuadrante superior de mama izquierda, acompañado de fiebre de 39°C y malestar general.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más común y cuál es la recomendación fundamental respecto a la lactancia?

A) Staphylococcus aureus; Continuar la lactancia o extracción manual (vaciamiento) más antibióticos *

B) Streptococcus pyogenes; Suspender la lactancia de inmediato.

C) Candida albicans; Solo antifúngicos tópicos.

D) Bacteroides; Incisión y drenaje sin antibióticos.

Retroalimentación:

La mastitis puerperal se debe al estasis de leche que favorece la proliferación bacteriana. La medida más importante es el vaciado de la mama; la leche no daña al bebé y la succión ayuda a la resolución. El antibiótico de elección suele ser Dicloxacilina.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: MENOPAUSIA Y RIESGO CARDIOVASCULAR

Dificultad: Media

Caso Clínico 441

Mujer de 53 años, fumadora crónica (IT 15), con IMC de 31 kg/m^2. Refiere que hace 2 años cesaron sus menstruaciones. Acude por bochornos severos y palpitaciones. Solicita terapia de reemplazo hormonal (TRH).

Pregunta 1

¿Cuál es la principal contraindicación para el uso de TRH oral en esta paciente y qué vía de administración sería preferible si se decide iniciar manejo hormonal?

A) Tabaquismo y riesgo de trombosis; Vía transdérmica *

B) Obesidad; Vía vaginal.

C) Edad; Vía intramuscular.

D) Menopausia establecida; No se recomienda ninguna vía.

Pregunta 2

¿Cuál es el principal cambio en el perfil de lípidos tras la instauración de la menopausia que aumenta el riesgo cardiovascular?

A) Aumento de LDL y disminución de HDL *

B) Disminución de triglicéridos.

C) Aumento de VLDL únicamente.

D) Disminución del colesterol total.

Retroalimentación:

La vía transdérmica evita el primer paso hepático, disminuyendo el riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes con factores de riesgo como el tabaquismo u obesidad. Los estrógenos tienen un efecto protector sobre el endotelio y los lípidos; su pérdida marca el aumento de riesgo cardiovascular en la mujer.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: OSTEOPOROSIS (MANEJO INTEGRAL)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 442

Paciente de 68 años con diagnóstico de osteoporosis (T-score -3.0). Tiene antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) severo con esófago de Barrett.

Pregunta 1

Debido a su patología esofágica, los bisfosfonatos orales están contraindicados. ¿Qué alternativa de tratamiento de administración anual o semestral es la más adecuada?

A) Ácido zoledrónico (IV) o Denosumab (SC) *

B) Calcio oral a dosis altas.

C) Estrógenos conjugados.

D) Raloxifeno.

Pregunta 2

¿Cuál es la ingesta diaria recomendada de calcio y vitamina D para una mujer en la postmenopausia según la NOM y GPC?

A) 1,200 mg de calcio y 800-1,000 UI de vitamina D *

B) 500 mg de calcio y 200 UI de vitamina D.

C) 2,000 mg de calcio y 5,000 UI de vitamina D.

D) No se requiere suplementación si toma sol.

Retroalimentación:

El Denosumab es un anticuerpo monoclonal contra el RANKL que inhibe la maduración de los osteoclastos. Es ideal para pacientes que no toleran la vía oral o tienen contraindicaciones esofágicas.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (ABSCESO MAMARIO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 443

Paciente de 24 años que se encuentra en la 4ta semana de lactancia. Fue diagnosticada con mastitis hace 48 horas e inició Dicloxacilina. Acude nuevamente por persistencia de fiebre, dolor exquisito y la aparición de una zona de fluctuación con eritema marcado en el cuadrante inferior de la mama derecha.

Pregunta 1

¿Cuál es la complicación más probable y cuál es el manejo terapéutico de elección?

A) Absceso mamario; Incisión, drenaje quirúrgico y continuación de antibiótico *

B) Galactocele; Aspiración con aguja fina únicamente.

C) Carcinoma inflamatorio; Biopsia de piel.

D) Mastitis recurrente; Cambio de antibiótico a Vancomicina.

Pregunta 2

¿Qué estudio de imagen es el estándar para confirmar la presencia de una colección líquida en la mama lactante?

A) Ultrasonido mamario *

B) Mastografía.

C) Resonancia magnética con contraste.

D) Termografía.

Retroalimentación:

Un absceso debe sospecharse cuando una mastitis no mejora tras 48-72 horas de tratamiento. El drenaje es obligatorio. En colecciones pequeñas, la aspiración con aguja guiada por USG puede ser opción, pero el drenaje quirúrgico sigue siendo el estándar en colecciones francas.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (ECTASIA DUCTAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 444

Mujer de 52 años, fumadora, acude por secreción por el pezón izquierdo de color verduzco y consistencia espesa. A la exploración se palpa una tumoración retroareolar alargada y retracción del pezón de larga evolución. La mastografía muestra calcificaciones groseras en "forma de puro".

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ectasia ductal *

B) Papiloma intraductal.

C) Cáncer ductal infiltrante.

D) Enfermedad de Paget.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo recomendado si la paciente presenta episodios recurrentes de infección o la secreción es muy molesta?

A) Escisión de los conductos terminales (Cirugía de Urban) *

B) Mastectomía simple.

C) Antibióticos de por vida.

D) Radioterapia local.

Retroalimentación:

La ectasia ductal ocurre por la dilatación de los conductos galactóforos principales y fibrosis periductal. Es típica de la perimenopausia y se asocia fuertemente al tabaquismo. La secreción suele ser polícroma (verde, café, negra) y multiorificial.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (CONDICIONES ESPECIALES)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 445

Femenina de 35 años que presenta una masa mamaria de crecimiento muy rápido (pasó de 2 a 8 cm en 3 meses). A la exploración es una masa firme, lobulada, no

adherida a planos profundos. La biopsia por tru-cut reporta una proliferación fibroepitelial con estroma muy celular y proyecciones en "hoja de higo".

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tumor Filodes (Phyllodes) *

B) Fibroadenoma gigante.

C) Sarcoma mamario.

D) Carcinoma medular.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para esta neoplasia, considerando su alta tasa de recurrencia local?

A) Resección quirúrgica con márgenes amplios (>1 cm) *

B) Enucleación simple.

C) Quimioterapia sistémica.

D) Observación trimestral.

Retroalimentación:

El tumor filodes puede ser benigno, borderline o maligno. Su característica principal es el rápido crecimiento y su apariencia histológica foliácea. No suele diseminarse por ganglios (vía hematógena), por lo que la linfadenectomía no está indicada de rutina.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (ESTEATONECROSIS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 446

Paciente de 40 años acude por una tumoración indurada y fija en mama izquierda, tras haber sufrido un traumatismo con el cinturón de seguridad en un accidente automovilístico hace 1 mes. En la mastografía se observa una imagen con centro radiolúcido y cáscara de huevo (quiste oleoso).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la conducta a seguir?

A) Necrosis grasa (esteatonecrosis); Manejo conservador/observación *

B) Cáncer de mama; Biopsia inmediata.

C) Hamartoma mamario; Resección.

D) Galactocele; Punción.

Retroalimentación:

La necrosis grasa simula clínicamente un cáncer por ser una masa dura y fija, pero el antecedente traumático y la imagen radiológica de "quiste oleoso" son diagnósticos. No requiere tratamiento activo.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (GINECOMASTIA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 447

Paciente masculino de 72 años en tratamiento por insuficiencia cardíaca congestiva. Acude por crecimiento mamario bilateral doloroso.

Pregunta 1

¿Qué fármaco utilizado en la falla cardíaca es el causante más frecuente de ginecomastia por su efecto antiandrogénico?

A) Espironolactona *

B) Digoxina.

C) Furosemida.

D) Enalapril.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial en este paciente?

A) Suspender o cambiar el fármaco sospechoso *

B) Realizar mastectomía bilateral.

C) Administrar testosterona.

D) Biopsia por aspiración.

Retroalimentación:

La espironolactona inhibe la síntesis de testosterona y bloquea su receptor, además de aumentar la conversión a estrógenos. La ginecomastia farmacológica suele ser reversible al retirar el agente.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (MASTALGIA)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 448

Mujer de 30 años con mastalgia cíclica severa que afecta su calidad de vida y no responde a medidas generales ni AINES.

Pregunta 1

¿Qué fármaco puede utilizarse como segunda línea para el manejo de la mastalgia severa, a pesar de sus efectos secundarios?

A) Danazol o Tamoxifeno *

B) Bromocriptina.

C) Vitamina E.

D) Aceite de prímula.

Retroalimentación:

Aunque la vitamina E y el aceite de prímula se usan mucho, la evidencia de su eficacia es baja. El danazol es efectivo pero sus efectos androgénicos limitan su uso; el tamoxifeno se reserva para casos refractarios.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CLIMATERIO (FISIOPATOLOGÍA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 449

Durante la transición a la menopausia (perimenopausia), se producen cambios hormonales característicos.

Pregunta 1

¿Cuál es el primer cambio hormonal detectable en la etapa de transición temprana?

A) Disminución de la Inhibina B y elevación discreta de FSH *

B) Aumento de la progesterona.

C) Descenso de la LH.

D) Aumento de la hormona antimülleriana.

Retroalimentación:

La Inhibina B cae al disminuir la reserva folicular, lo que libera a la FSH del retrocontrol negativo, provocando su elevación. Este es el marcador más temprano del envejecimiento ovárico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ATROFIA VULVOVAGINAL

Dificultad: Media

Caso Clínico 450

Paciente de 60 años refiere dispareunia de intrusión severa y prurito vaginal. A la exploración se observa mucosa pálida, lisa, con pérdida de los pliegues vaginales y pH de 6.0.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento de elección para la atrofia genitourinaria en pacientes que NO tienen síntomas vasomotores sistémicos?

A) Estrógenos locales (crema, anillo o tabletas vaginales) *

B) TRH oral combinada.

C) Lubricantes a base de agua únicamente.

D) Antibióticos vaginales.

Pregunta 2

¿Qué sucede con la citología vaginal en una paciente con atrofia severa?

A) Predominio de células parabasales y ausencia de células superficiales *

B) Presencia de células clave.

C) Aumento de la inflamación aguda.

D) No hay cambios.

Retroalimentación:

La falta de estrógenos provoca que el epitelio vaginal no madure, quedándose en capas profundas (parabasales). El tratamiento local es altamente efectivo y tiene mínima absorción sistémica.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: INFECCIONES VAGINALES (VAGINOSIS POR MOBILUNCUS/ATOPOBIUM)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 451

Paciente de 30 años con diagnóstico recurrente de vaginosis bacteriana. Ha recibido múltiples ciclos de metronidazol con mejoría parcial. Reporta persistencia de flujo con olor a pescado. El Gram de la secreción muestra bacilos curvos gram variables (Mobiluncus) y cocos gram positivos.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento de segunda línea recomendado por la GPC cuando falla el metronidazol o en casos de recurrencia persistente?

A) Clindamicina crema al 2% por 7 días o Tinidazol oral *

B) Doxiciclina por 14 días.

C) Ciprofloxacino oral.

D) Óvulos de nistatina.

Pregunta 2

¿Qué complicación obstétrica se asocia fuertemente a la presencia de vaginosis bacteriana durante el segundo trimestre del embarazo?

A) Ruptura prematura de membranas y parto pretérmino *

B) Diabetes gestacional.

C) Preeclampsia severa.

D) Malformaciones cardíacas.

Retroalimentación:

La vaginosis bacteriana es una entidad polimicrobiana. Mobiluncus y Atopobium vaginae a menudo son resistentes al metronidazol, por lo que la clindamicina (que inhibe la síntesis proteica bacteriana) es la alternativa de elección.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: INFECCIONES VAGINALES (CANDIDIASIS COMPLICADA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 452

Mujer de 34 años, diabética descontrolada (HbA1c 9.5%), presenta prurito vulvar intenso, edema de labios menores y fisuras en la horquilla vulvar. El flujo es escaso pero muy adherente. Ha tenido 3 episodios similares en los últimos 4 meses.

Pregunta 1

¿Cómo se clasifica este episodio de candidiasis y cuál es el manejo inicial sugerido?

A) Candidiasis complicada; Fluconazol 150 mg (dos dosis separadas por 72 horas) *

B) Candidiasis simple; Miconazol crema dosis única.

C) Vaginosis mixta; Metronidazol + Nistatina.

D) Liquen escleroso; Esteroides tópicos.

Pregunta 2

¿Cuál es la especie de hongo no-albicans que suele asociarse a resistencia al fluconazol en pacientes diabéticas?

A) Candida glabrata *

B) Candida tropicalis.

C) Candida parapsilosis.

D) Saccharomyces cerevisiae.

Retroalimentación:

La candidiasis se considera "complicada" si la paciente es inmunosuprimida (incluye DM descontrolada), si hay síntomas severos (fisuras/edema) o si es recurrente. Candida glabrata suele requerir ácido bórico intravaginal como alternativa.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VACUNACIÓN)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 453

Madre acude con su hija de 11 años a la unidad de medicina familiar para aplicación de vacunas según el Esquema Nacional de Vacunación en México.

Pregunta 1

¿Cuál es el esquema actual de vacunación contra VPH para niñas en el sistema escolarizado mexicano?

A) Dosis única (esquema de rescate/actualización) *

B) 3 dosis (0, 2 y 6 meses).

C) 2 dosis separadas por 5 años.

D) Solo se vacuna a mujeres con vida sexual activa.

Pregunta 2

¿Cuál es el principal beneficio de la vacuna nonavalente sobre la bivalente/tetravalente?

A) Protección adicional contra serotipos 31, 33, 45, 52 y 58 (alto riesgo adicional) *

B) Prevención de herpes simple.

C) Menor tasa de dolor en el sitio de aplicación.

D) Eficacia del 100% contra verrugas de las manos.

Retroalimentación:

México ha adoptado recientemente estrategias de dosis única en poblaciones específicas para maximizar cobertura. La vacuna tetravalente protege contra 6, 11 (verrugas) y 16, 18 (cáncer). La nonavalente amplía la protección contra otros tipos oncogénicos menos comunes pero relevantes.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: VPH (LESIONES CLINICAS - CONDILOMAS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 454

Varón de 22 años presenta múltiples lesiones papulares, vegetantes, con aspecto de "coliflor" en el surco balanoprepucial, no dolorosas. Su pareja femenina presenta lesiones similares en labios mayores.

Pregunta 1

¿Cuáles son los serotipos de VPH responsables del 90% de estas lesiones y cuál es el tratamiento químico de aplicación por el médico de primera elección?

A) 6 y 11; Podofilina al 25% o Ácido Tricloroacético (80-90%) *

B) 16 y 18; Imiquimod al 5%.

C) 1 y 2; Nitrógeno líquido.

D) 31 y 33; Penicilina.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento que puede aplicarse el paciente en su domicilio (autoaplicación)?

A) Imiquimod al 5% o Podofilotoxina al 0.5% *

B) Fluorouracilo al 5% únicamente.

C) Cidofovir gel.

D) No existe tratamiento de autoaplicación.

Retroalimentación:

Los condilomas acuminados son causados por tipos de VPH de bajo riesgo oncogénico. La podofilina es cáustica y debe ser aplicada con cuidado por el personal de salud para evitar quemaduras en piel sana.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EMBARAZO ECTÓPICO (DIAGNÓSTICO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 455

Mujer de 26 años con antecedente de EPI hace 1 año. Acude por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y amenorrea de 6.5 semanas. Presenta sangrado transvaginal escaso, obscuro. Al examen: dolor a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal. La fracción beta de hCG es de 2,500 mUI/ml.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo esperado en el ultrasonido transvaginal para confirmar un embarazo ectópico y qué se espera observar en el útero?

A) Masa anexial compleja y útero vacío con signo de "pseudosaco" *

B) Saco gestacional intrauterino con embrión de 5 mm.

C) Imagen en "tormenta de nieve".

D) Línea endometrial delgada (<2 mm).

Pregunta 2

¿Cuál es la localización anatómica más frecuente del embarazo ectópico?

A) Porción ampular de la trompa de Falopio *

B) Istmo de la trompa.

C) Ovario.

D) Región intersticial (cornual).

Retroalimentación:

La tríada clásica es: amenorrea, dolor abdominal y sangrado vaginal. El ultrasonido transvaginal debe identificar un saco gestacional intrauterino cuando la hCG es >1,500-2,000 mUI/ml (zona discriminatoria); si el útero está vacío, se sospecha fuertemente de ectópico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EMBARAZO ECTÓPICO (MANEJO MÉDICO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 456

Paciente con diagnóstico de embarazo ectópico no roto en trompa derecha. Se encuentra hemodinámicamente estable, el saco gestacional mide 2.5 cm, no hay actividad cardíaca embrionaria y la hCG es de 3,000 mUI/ml.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección y cuál es su mecanismo de acción?

A) Metotrexato; Antagonista del ácido fólico que inhibe la síntesis de DNA *

B) Misoprostol; Análogo de prostaglandinas que causa contracción.

C) Mifepristona; Antiprogestágeno.

D) Actinomicina D; Antibiótico antitumoral.

Pregunta 2

¿Cuál es un criterio de exclusión (contraindicación) para el manejo médico con metotrexato?

A) Presencia de actividad cardíaca fetal o saco >3.5-4 cm *

B) Antecedente de cesárea.

C) hCG de 2,000 mUI/ml.

D) Edad mayor a 35 años.

Retroalimentación:

El metotrexato es una alternativa segura a la cirugía en casos muy seleccionados. Requiere vigilancia estrecha de la hCG los días 4 y 7 post-tratamiento para asegurar el descenso de los niveles.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EMBARAZO ECTÓPICO ROTO (URGENCIA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 457

Mujer de 30 años llega a urgencias por dolor abdominal súbito e intensísimo, seguido de síncope. A su llegada: TA 80/40 mmHg, FC 125 lpm, palidez marcada y abdomen con rebote positivo (Signo de Blumberg).

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada para esta paciente?

A) Laparotomía exploradora de urgencia (Salpingectomía) *

B) Realizar ultrasonido Doppler para confirmar diagnóstico.

C) Administrar metotrexato IV.

D) Realizar culdocentesis.

Pregunta 2

En pacientes con estabilidad hemodinámica pero indicación quirúrgica (p. ej. falla a manejo médico), ¿cuál es el abordaje de elección?

A) Laparoscopia *

B) Laparotomía de Pfannenstiel.

C) Colpotomía posterior.

D) Salpingostomía por histeroscopia.

Retroalimentación:

Ante el choque hipovolémico por ectópico roto, no se debe perder tiempo en estudios de imagen; la cirugía debe ser inmediata para control del sangrado. En casos no rotos, la salpingostomía (conservar la trompa) es opción si la paciente desea fertilidad futura.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EMBARAZO ECTÓPICO (TIPOS RAROS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 458

Paciente con embarazo intersticial (cornual) diagnosticado por ultrasonido.

Pregunta 1

¿Por qué el embarazo intersticial es considerado el más peligroso de los ectópicos tubáricos?

A) Debido a que la ruptura ocurre más tarde (10-14 semanas) y causa hemorragia masiva por la cercanía a las arterias uterinas *

B) Porque se confunde con gemelar.

C) Porque no produce hCG.

D) Porque siempre es bilateral.

Pregunta 2

¿Cómo se define el embarazo heterotópico?

A) Coexistencia de un embarazo intrauterino y uno extrauterino simultáneos *

B) Embarazo en ambos ovarios.

C) Embarazo extrauterino que se implanta en el bazo.

D) Embarazo molar y ectópico a la vez.

Retroalimentación:

El embarazo heterotópico es extremadamente raro en concepción natural (1:30,000), pero su incidencia aumenta significativamente en técnicas de reproducción asistida.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA (SECUELAS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 459

Mujer de 32 años con historial de 3 episodios de EPI. Acude por dolor pélvico persistente y dificultad para concebir.

Pregunta 1

¿Cuál es la secuela anatómica más común de la EPI que predispone directamente al embarazo ectópico?

A) Daño de los cilios tubáricos y formación de bridas/adherencias *

B) Estenosis cervical.

C) Atrofia ovárica.

) Endometritis esclerosante.

Retroalimentación:

La infección (especialmente por Chlamydia) destruye el epitelio ciliar de la trompa, impidiendo el transporte normal del blastocisto hacia el útero, facilitando su implantación en la pared tubárica.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: VPH (CRITERIOS DE REFERENCIA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 460

Durante una jornada de salud, se realizan pruebas de detección de VPH (captura de híbridos) a mujeres de 35 a 65 años.

Pregunta 1

Si una paciente resulta positiva para VPH de alto riesgo (16/18) pero tiene una citología (Papanicolaou) negativa o normal, ¿cuál es la conducta a seguir?

A) Referencia a Clínica de Displasias para Colposcopia *

B) Repetir ambas pruebas en 5 años.

C) Realizar histerectomía preventiva.

D) Aplicar crioterapia a ciegas.

Retroalimentación:

La presencia de virus de alto riesgo es suficiente motivo de vigilancia estrecha o colposcopia, incluso si las células aún no muestran cambios morfológicos en la citología, debido al alto riesgo de progresión a lesiones de alto grado.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EMBARAZO ECTÓPICO (SEGUIMIENTO POS-METOTREXATO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 461

Paciente de 25 años en el 7° día post-administración de Metotrexato por embarazo ectópico no roto. La hCG del día 4 fue de 4,000 mUI/ml y la del día 7 es de 3,800 mUI/ml.

Pregunta 1

¿Cómo se interpreta este descenso del 5% en los niveles de hCG y cuál es la conducta a seguir según la GPC?

A) Fallo al tratamiento (descenso <15%); Aplicar segunda dosis de Metotrexato o considerar cirugía *

B) Respuesta adecuada; Continuar vigilancia semanal.

C) Éxito terapéutico; Alta definitiva.

D) Ruptura inminente; Laparotomía inmediata.

Pregunta 2

¿Cuál es el efecto secundario más común del Metotrexato sistémico en el tratamiento del embarazo ectópico?

A) Estomatitis y elevación de enzimas hepáticas *

B) Alopecia total.

C) Insuficiencia renal aguda.

D) Neuropatía periférica.

Retroalimentación:

Para considerar éxito del manejo médico, la hCG debe disminuir ≥15% entre el día 4 y el día 7. Si no ocurre, se debe revalorar la estabilidad de la paciente para una segunda dosis o manejo quirúrgico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EMBARAZO ECTÓPICO (LOCALIZACIÓN CERVICAL)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 462

Paciente de 32 años con antecedente de legrados uterinos múltiples. Acude por sangrado transvaginal profuso. Al examen con espejo se observa cérvix distendido, con aspecto "en barril", orificio cervical externo entreabierto con tejido purpúreo. El ultrasonido muestra saco gestacional por debajo del nivel de las arterias uterinas.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el riesgo principal de intentar un legrado en esta paciente?

A) Embarazo ectópico cervical; Hemorragia masiva incoercible *

B) Aborto en evolución; Expulsión completa.

C) Mola hidatidiforme; Embolia trofoblástica.

D) Incompetencia cervical; Desgarro del cérvix.

Retroalimentación:

El embarazo cervical es raro pero grave. El cérvix no tiene capa muscular capaz de contraerse para detener el sangrado tras un legrado, por lo que a menudo termina en histerectomía de urgencia si no se diagnostica previamente.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EMBARAZO ECTÓPICO (DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 463

Mujer con dolor en fosa ilíaca derecha, náuseas y amenorrea de 7 semanas. El ultrasonido muestra una masa anexial derecha y líquido libre en fondo de saco de Douglas (100 cc). La hCG es de 50 mUI/ml.

Pregunta 1

Dada la hCG tan baja, ¿cuál es el diagnóstico diferencial principal con un embarazo ectópico roto y cómo se diferenciarían por imagen?

A) Quiste de cuerpo lúteo hemorrágico; El cuerpo lúteo suele tener un "anillo de fuego" al Doppler pero dentro del ovario *

B) Apendicitis aguda; Presencia de fecalito.

C) Torsión ovárica; Ausencia de flujo Doppler.

D) Salpingitis; Engrosamiento de la trompa.

Retroalimentación:

El cuerpo lúteo hemorrágico es el gran simulador del ectópico. La diferencia clave es que el ectópico es una masa extraovárica, mientras que el cuerpo lúteo es intraovárico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (MOLA COMPLETA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 464

Paciente de 19 años con embarazo de 10 semanas. Acude por vómitos incoercibles (hiperemesis gravídica) y sangrado vaginal "en agua de lavar carne" con expulsión de vesículas. A la exploración: fondo uterino de 16 cm (mayor a amenorrea) y ausencia de ruidos cardíacos fetales.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo patognomónico en el ultrasonido y cuál es el cariotipo más común en la mola hidatidiforme completa?

A) Imagen en "nevada" o "tormenta de nieve"; 46, XX (origen puramente paterno) *

B) Embrión con malformaciones; 69, XXY.

C) Saco gestacional vacío; 45, X.

D) Placenta con lagunas; 46, XY.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación médica más frecuente asociada a los niveles extremadamente altos de hCG en este cuadro?

A) Hipertiroidismo secundario (por similitud de la hCG con la TSH) y preeclampsia antes de la semana 20 *

B) Diabetes gestacional.

C) Insuficiencia suprarrenal.

D) Hipoacusia.

Retroalimentación:

En la mola completa no hay tejido fetal. La hCG comparte una subunidad alfa con la TSH, LH y FSH, por lo que en niveles masivos puede estimular el tiroides y causar una crisis tirotóxica.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA (MOLA PARCIAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 465

Paciente con diagnóstico de mola parcial tras estudio histopatológico de un legrado por aborto diferido. El informe describe vellosidades hidrópicas mezcladas con tejido fetal y cariotipo triploide.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo citogenético de la mola parcial?

A) Fertilización de un óvulo normal por dos espermatozoides (dispermia) *

B) Fertilización de un óvulo vacío por un espermatozoide que se duplica.

C) No disyunción meiótica materna.

D) Mutación puntual en el gen p53.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial de elección para la evacuación de cualquier mola hidatidiforme según la GPC?

A) Legrado uterino por Aspiración Manual Endouterina (AMEU) *

B) Histerectomía total en todos los casos.

C) Inducción del parto con oxitocina.

D) Metotrexato profiláctico.

Retroalimentación:

La AMEU es preferible al legrado cortante instrumental (LUI) porque reduce el riesgo de perforación uterina y de embolismo trofoblástico hacia los pulmones.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA (SEGUIMIENTO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 466

Tras la evacuación de una mola, se inicia seguimiento con niveles de hCG semanal.

Pregunta 1

¿Qué criterio sugiere la progresión a una neoplasia trofoblástica gestacional (mola invasora o coriocarcinoma) durante el seguimiento?

A) Meseta en los niveles de hCG por 3 semanas o aumento por 2 semanas consecutivas *

B) Descenso progresivo lento.

C) Presencia de quistes tecaluteínicos que persisten 1 mes.

D) Negativización de la hCG a las 8 semanas.

Pregunta 2

¿Cuál es el sitio de metástasis más frecuente del coriocarcinoma y qué estudio de imagen es obligatorio de inicio?

A) Pulmón; Radiografía de tórax *

B) Hígado; Ecografía.

C) Cerebro; Tomografía.

D) Hueso; Gammagrama.

Retroalimentación:

El seguimiento es vital: se solicita hCG semanal hasta la negativización, luego mensual por 6 meses. Se debe asegurar anticoncepción estricta durante este periodo para no confundir un nuevo embarazo con una recaída de la mola.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (DEFINICIONES)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 467

Paciente de 8 semanas de gestación presenta sangrado transvaginal leve y dolor tipo cólico en hipogastrio. Al examen: cérvix cerrado, sin salida de líquido o tejido. El ultrasonido muestra embrión con frecuencia cardíaca presente.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico y cuál es el tratamiento inicial recomendado?

A) Amenaza de aborto; Reposo, ácido fólico y vigilancia de signos de alarma *

B) Aborto inevitable; AMEU inmediata.

C) Aborto diferido; Misoprostol.

D) Embarazo normal; Ninguna medida.

Pregunta 2

¿Cómo se define el aborto según la Norma Oficial Mexicana (NOM-007)?

A) Expulsión del producto de la concepción de menos de 22 semanas de gestación o peso menor de 500 gramos *

B) Pérdida del embarazo antes de la semana 20.

C) Muerte fetal después de la semana 25.

D) Expulsión de membranas antes de la semana 14.

Retroalimentación:

La amenaza de aborto es la única etapa potencialmente reversible. Si los niveles de progesterona son bajos, se puede considerar el uso de progesterona natural micronizada.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO DIFERIDO (HUEVO MUERTO RETENIDO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 468

Primigesta de 10 semanas acude a control. Se encuentra asintomática. Al realizar ultrasonido se observa saco gestacional con embrión de longitud coronilla-rabadilla de 12 mm, pero sin actividad cardíaca.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la conducta terapéutica si la paciente decide manejo médico?

A) Aborto diferido; Administración de Misoprostol *

B) Aborto incompleto; Legrado cortante.

C) Embarazo anembriónico; Repetir estudio en 2 semanas.

D) Aborto séptico; Antibióticos.

Pregunta 2

¿Cuál es la dosis de Misoprostol recomendada para el manejo médico del aborto de primer trimestre (<11 semanas) según la GPC mexicana?

A) 800 mcg vía vaginal o sublingual cada 3 a 12 horas (máximo 3 dosis) *

B) 200 mcg dosis única.

C) 50 mcg cada 24 horas.

D) 1000 mcg vía rectal.

Retroalimentación:

El manejo médico es una opción segura y altamente efectiva para evitar la anestesia y los riesgos quirúrgicos en abortos de primer trimestre.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO INCOMPLETO VS COMPLETO

Dificultad: Baja

Caso Clínico 469

Paciente de 9 semanas acude por dolor intenso y sangrado profuso con expulsión de tejidos. Al examen: cérvix abierto, se palpan restos en el canal cervical. El ultrasonido muestra endometrio irregular de 18 mm.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el paso a seguir?

A) Aborto incompleto; Evacuación uterina (AMEU o legrado) *

B) Aborto completo; Alta a su domicilio.

C) Aborto inevitable; Tocolisis.

D) Mola hidatidiforme; Histerectomía.

Pregunta 2

¿Qué característica clínica diferencia el aborto inevitable del aborto en evolución?

A) El inevitable presenta ruptura de membranas (amniorrexis) *

B) El en evolución presenta fiebre.

C) El inevitable tiene cérvix cerrado.

D) No hay diferencia clínica.

Retroalimentación:

El aborto completo se diagnostica cuando el útero está vacío, el cérvix se cierra y el sangrado disminuye drásticamente; el endometrio suele medir menos de 10-12 mm por ultrasonido.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO SÉPTICO

Dificultad: Alta

Caso Clínico 470

Paciente acude traída por familiares tras haber intentado una interrupción del embarazo en condiciones insalubres hace 2 días. Presenta fiebre de 39.5°C, dolor abdominal intenso, descarga vaginal purulenta fétida y ataque al estado general.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta inmediata prioritaria?

A) Hospitalización, antibióticos de amplio espectro y evacuación uterina inmediata *

B) Realizar ultrasonido de control y cita en 1 semana.

C) Dar antibióticos orales y enviar a casa.

D) Realizar solo el legrado sin antibióticos.

Pregunta 2

¿Cuál es el esquema antibiótico de elección sugerido por la GPC para aborto séptico?

A) Clindamicina + Gentamicina (o Ampicilina + Gentamicina + Metronidazol) *

B) Ceftriaxona dosis única.

C) Ciprofloxacino oral.

D) Penicilina benzatínica.

Retroalimentación:

El aborto séptico es una urgencia médica. El retraso en la evacuación del foco infeccioso (útero) puede llevar rápidamente a choque séptico, coagulación intravascular diseminada (CID) y síndrome de Mondor (gangrena gaseosa uterina por Clostridium perfringens).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (CORIOCARCINOMA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 471

Paciente de 26 años con antecedente de embarazo molar hace 8 meses. Acude por tos persistente y hemoptisis. La exploración ginecológica muestra una vagina normal, pero se palpa útero aumentado de tamaño. La hCG se encuentra en 150,000 mUI/ml. La radiografía de tórax muestra múltiples imágenes redondeadas en "suelta de globos".

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el sistema de puntuación utilizado para decidir entre monoquimioterapia o poliquimioterapia?

A) Coriocarcinoma gestacional; Puntuación de la OMS/FIGO (Score de riesgo) *

B) Mola invasora; Criterios de Quintero.

C) Cáncer de pulmón primario; Clasificación TNM.

D) Tuberculosis miliar; Criterios de Jones.

Pregunta 2

¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento en pacientes clasificadas como "bajo riesgo" (Score <7)?

A) Metotrexato (con o sin ácido folínico) *

B) Esquema EMA-CO (Etopósido, Metotrexato, Actinomicina, Ciclofosfamida, Vincristina).

C) Cisplatino y Etopósido.

D) Paclitaxel.

Retroalimentación:

El coriocarcinoma es una neoplasia altamente maligna pero extremadamente quimiosensible. La presencia de metástasis pulmonares es común (vía hematógena). El sistema de puntuación de la FIGO evalúa edad, antecedente de embarazo, meses desde el embarazo índice, niveles de hCG, tamaño del tumor y sitio de metástasis.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA (MOLA INVASORA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 472

Paciente de 30 años post-evacuación de mola hidatidiforme. Durante el seguimiento, la hCG se mantiene en meseta. Se realiza ultrasonido Doppler que muestra una masa miometrial heterogénea con alta vascularización que invade el miometrio profundo pero no sale del útero.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el manejo si la paciente presenta hemorragia uterina profusa que compromete la vida?

A) Mola invasora; Histerectomía de urgencia *

B) Coriocarcinoma; Radioterapia.

C) Tumor del sitio placentario; Metotrexato.

D) Restos ovulares simples; Nuevo legrado.

Retroalimentación:

La mola invasora (antes llamada corioadenoma destruens) se caracteriza por la invasión de vellosidades hidrópicas al miometrio. A diferencia del coriocarcinoma, conserva la estructura de vellosidad.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO RECURRENTE (SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 473

Mujer de 32 años con antecedente de 3 abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 10. No tiene hijos. Refiere antecedente de una trombosis venosa profunda hace 2 años. Pruebas de cariotipo en la pareja normales.

Pregunta 1

¿Qué estudio de laboratorio es prioritario solicitar para el abordaje de esta paciente?

A) Anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anti-beta2-glicoproteína I *

B) Perfil tiroideo y prolactina.

C) Histerosalpingografía.

D) Curva de tolerancia a la glucosa.

Pregunta 2

Si se confirma el diagnóstico de Síndrome Antifosfolípido (SAF), ¿cuál es el tratamiento de elección durante el próximo embarazo para mejorar el pronóstico gestacional?

A) Ácido acetilsalicílico (dosis baja) + Heparina de bajo peso molecular *

B) Warfarina y glucocorticoides.

C) Metformina y progesterona.

D) Reposo absoluto en cama.

Retroalimentación:

El SAF es la causa autoinmune más importante de aborto recurrente. El tratamiento antitrombótico combinado reduce significativamente la tasa de pérdidas gestacionales al prevenir infartos placentarios.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (ISOINMUNIZACIÓN RH)

Dificultad: Media

Caso Clínico 474

Paciente de 22 años, grupo sanguíneo A negativo, acude por aborto incompleto de 9 semanas. Se realiza AMEU sin complicaciones. El esposo es grupo O positivo.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta indicada para prevenir la isoinmunización Rh en futuros embarazos?

A) Administrar Inmunoglobulina anti-D (300 mcg) dentro de las primeras 72 horas post-evento *

B) Realizar prueba de Coombs indirecto cada mes.

C) Administrar la inmunoglobulina solo si el Coombs indirecto es positivo.

D) No requiere profilaxis por ser embarazo de primer trimestre.

Pregunta 2

¿En qué situación NO sería necesaria la administración de la inmunoglobulina anti-D tras un aborto?

A) Si el padre es Rh negativo confirmado *

B) Si el aborto fue de tipo diferido.

C) Si la paciente ya tiene hijos previos.

D) Si el sangrado fue escaso.

Retroalimentación:

Toda mujer Rh negativa no sensibilizada (Coombs indirecto negativo) que presente un evento obstétrico con potencial de transfusión feto-materna (aborto, ectópico, trauma, parto) debe recibir profilaxis con anti-D para evitar la formación de anticuerpos que ataquen a un futuro feto Rh positivo.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (ETIOLOGÍA GENÉTICA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 475

Se realiza estudio citogenético de los restos de un aborto espontáneo de primer trimestre.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más frecuente de aborto espontáneo de primer trimestre y qué anomalía cromosómica específica es la más habitual?

A) Anomalías cromosómicas (Aneuploidías); Trisomía 16 *

B) Infecciones por TORCH; Citomegalovirus.

C) Malformaciones uterinas; Útero septo.

D) Deficiencia de cuerpo lúteo.

Pregunta 2

¿Cuál es la única monosomía compatible con la vida que suele presentarse frecuentemente en abortos?

A) Monosomía X (Síndrome de Turner) *

B) Monosomía 21.

C) Monosomía 18.

D) Monosomía del cromosoma 1.

Retroalimentación:

Aproximadamente el 50-60% de los abortos espontáneos tempranos se deben a errores en la división celular (aneuploidías). La trisomía 16 es la más común en abortos, pero nunca llega a término. El síndrome de Turner (45, X) es una causa frecuente de aborto y de hidropesía fetal.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (FACTORES ANATÓMICOS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 476

Mujer de 29 años con antecedente de dos abortos de segundo trimestre. Se realiza una histerosalpingografía que muestra una cavidad uterina dividida por un tabique longitudinal que llega hasta el istmo.

Pregunta 1

¿Cuál es la malformación uterina (conductos de Müller) que más se asocia a pérdida gestacional y cuál es su tratamiento?

A) Útero septo; Resección del tabique por histeroscopia *

B) Útero bicorne; Cirugía de Strassman.

C) Útero didelfo; No requiere tratamiento.

D) Útero unicorne; Cerclaje cervical.

Retroalimentación:

El útero septo es la malformación mülleriana más común y con peor pronóstico reproductivo debido a que el tabique es tejido hipovascularizado, lo que impide una correcta implantación o nutrición del blastocisto.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (SÍNDROME DE ASHERMAN)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 477

Paciente de 33 años con antecedente de legrados uterinos repetidos por abortos previos. Acude ahora por amenorrea secundaria e infertilidad. La prueba de desafío con progestágenos es negativa y el ultrasonido muestra una línea endometrial discontinua.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y cuál es el procedimiento para confirmar y tratar esta condición?

A) Síndrome de Asherman (sinequias uterinas); Histeroscopia diagnóstica y terapéutica (adhesiólisis) *

B) Menopausia precoz; Medición de FSH.

C) Síndrome de ovario poliquístico; Ultrasonido.

D) Hiperprolactinemia; Resonancia magnética de silla turca.

Retroalimentación:

El síndrome de Asherman es la formación de adherencias dentro de la cavidad uterina, generalmente tras traumas (legrados agresivos) o infecciones (endometritis tuberculosa). El tratamiento busca restaurar la cavidad y prevenir nuevas adherencias con el uso de estrógenos postoperatorios o dispositivos intrauterinos temporales.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (MANEJO MÉDICO - COMPLICACIONES)

Dificultad: Media

Caso Clínico 478

Paciente de 8 semanas que optó por manejo médico con Misoprostol. Acude a las 24 horas por dolor abdominal muy intenso, sangrado mayor a dos toallas sanitarias por hora y fiebre de 38°C.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta a seguir ante el fracaso del manejo médico o presencia de hemorragia profusa?

A) Realizar evacuación quirúrgica inmediata (AMEU o LUI) *

B) Aumentar la dosis de Misoprostol.

C) Administrar antibióticos y enviar a casa.

D) Observación por 24 horas más.

Retroalimentación:

Aunque el manejo médico es seguro, un pequeño porcentaje de pacientes requerirá intervención quirúrgica de urgencia por sangrado excesivo o evacuación incompleta.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (PSICOLOGÍA Y CONSEJERÍA)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 479

Paciente que acaba de sufrir su segundo aborto espontáneo. Se encuentra muy afectada emocionalmente y pregunta cuánto tiempo debe esperar para intentar un nuevo embarazo.

Pregunta 1

Según las recomendaciones generales y la GPC, ¿qué periodo se sugiere esperar para permitir la recuperación física y emocional antes de una nueva concepción?

A) Al menos 3 meses (o esperar a que pasen 2-3 ciclos menstruales normales) *

B) Un año obligatorio.

C) Puede intentar de inmediato en el siguiente ciclo.

D) Debe esperar a cumplir 35 años.

Retroalimentación:

No existe un consenso estricto, pero se recomienda esperar al menos un par de ciclos para que el endometrio se recupere totalmente y la paciente pueda procesar el duelo de la pérdida.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (LEGRADO VS AMEU)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 480

En un hospital de segundo nivel se discute el protocolo de manejo para aborto incompleto de 10 semanas.

Pregunta 1

¿Cuál es la principal ventaja de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) sobre el Legrado Uterino Instrumental (LUI) cortante?

A) Menor riesgo de perforación uterina, menos dolor y menor pérdida hemática *

B) No requiere ningún tipo de anestesia.

C) Es más rápido de realizar.

D) Se puede realizar en embarazos de hasta 22 semanas.

Retroalimentación:

La AMEU es el método quirúrgico de elección por ser menos invasivo. El LUI se reserva para cuando la AMEU no está disponible o el volumen de restos es demasiado grande (embarazos >12 semanas).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ABORTO (COMPLICACIONES POST-LEGRADO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 481

Paciente de 24 años acude a urgencias 24 horas después de un Legrado Uterino Instrumental (LUI) por aborto incompleto. Presenta dolor abdominal intenso, fiebre de 38.8°C y signos de irritación peritoneal (rebote positivo). A la exploración, se observa escaso sangrado transvaginal.

Pregunta 1

¿Cuál es la complicación quirúrgica más probable y cuál es el estudio de imagen inicial para valorar presencia de líquido o aire libre en cavidad?

A) Perforación uterina con lesión a asa intestinal; Radiografía de abdomen de pie y decúbito *

B) Endometritis post-legrado; Ultrasonido pélvico.

C) Síndrome de Asherman agudo; Histeroscopia.

D) Restos ovulares persistentes; Fracción beta de hCG.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inmediata ante la sospecha de perforación uterina con compromiso peritoneal?

A) Laparotomía exploradora para revisión de cavidad y reparación uterina *

B) Observación y antibióticos por 48 horas.

C) Repetir el legrado para asegurar que esté limpio.

D) Colocación de DIU para evitar sinequias.

Retroalimentación:

La perforación uterina es una complicación del LUI, especialmente en úteros reblandecidos por el embarazo. Si hay sospecha de lesión a órgano vecino (intestino, vejiga) o inestabilidad, la cirugía abierta es obligatoria.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PARTO PREMATURO (PREDICCIÓN)

Dificultad: Media

Caso Clínico 482

Paciente de 28 semanas de gestación acude por presentar contracciones esporádicas. Al tacto el cérvix se encuentra formado y cerrado. Se decide realizar cervicometría por ultrasonido transvaginal.

Pregunta 1

¿Cuál es la longitud cervical que se considera como punto de corte para determinar un alto riesgo de parto pretérmino y cuál es la medida profiláctica de elección si el cérvix mide <25 mm?

A) <25 mm; Administración de progesterona vaginal micronizada *

B) <35 mm; Cerclaje de urgencia.

C) <15 mm; Reposo absoluto en cama.

D) <20 mm; Colocación de pesario únicamente.

Pregunta 2

¿En qué pacientes está indicado el cerclaje cervical profiláctico (primario) según la GPC?

A) Pacientes con antecedente de 3 o más pérdidas en segundo trimestre o partos pretérmino (Incompetencia cervical) *

B) En todas las primigestas.

C) Solo si presentan infección urinaria recurrente.

D) Si el feto es macrosómico.

Retroalimentación:

La cervicometría es la herramienta más útil para tamizaje de parto pretérmino. En pacientes con cérvix corto incidental, la progesterona ha demostrado reducir el riesgo de parto antes de las 34 semanas.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 483

Paciente de 32 semanas de gestación refiere salida de líquido claro transvaginal con olor a "cloro" hace 2 horas. Niega dolor. A la exploración con espejo estéril se observa charco de líquido en fondo de saco vaginal.

Pregunta 1

¿Cuál es el método diagnóstico clínico más sencillo para confirmar la ruptura de membranas y qué hallazgo se espera en el microscopio?

A) Prueba de Nitrazina (pH básico) y cristalografía (imagen en hojas de helecho) *

B) Prueba de la flama; Cambio de color a azul.

C) Tacto vaginal repetido; Salida de sangre.

D) Ultrasonido; Medición de fémur.

Pregunta 2

Se confirma RPM de pretérmino sin datos de infección (corioamnionitis). ¿Cuál es el manejo conservador indicado para aumentar la latencia del parto y reducir morbilidad neonatal?

A) Antibioticoterapia profiláctica (Ampicilina + Eritromicina), esteroides y vigilancia *

B) Inducción inmediata del trabajo de parto.

C) Tocolisis prolongada hasta la semana 37.

D) Cesárea de urgencia.

Retroalimentación:

El manejo conservador busca ganar tiempo para la madurez fetal. Los antibióticos en RPM pretérmino no solo previenen la infección, sino que prolongan el periodo de latencia (tiempo entre la ruptura y el parto).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DIABETES GESTACIONAL (TAMIZAJE)

Dificultad: Media

Caso Clínico 484

Paciente de 25 semanas de gestación, con IMC previo de 29 kg/m^2 y antecedente de padre con DM2. Acude a su control prenatal.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC mexicana, ¿cuál es la estrategia de tamizaje recomendada entre las semanas 24 y 28 de gestación?

A) Carga de 50g de glucosa (Test de O'Sullivan) y, si es ≥140 mg/dL, realizar Curva de Tolerancia (CTOG) *

B) Glucosa al azar en cualquier momento.

C) Hemoglobina glucosilada únicamente.

D) CTOG de 75g de un solo paso a todas las pacientes.

Pregunta 2

¿Cuáles son los valores diagnósticos para la CTOG de 75g (Criterios de IADPSG/ADA) realizados en un solo paso?

A) Ayuno ≥92, 1h ≥180, 2h ≥153 mg/dL (un solo valor alterado hace el diagnóstico) *

B) Ayuno ≥126, 2h ≥200.

C) Ayuno ≥100, 1h ≥140.

D) Todos los valores deben estar alterados.

Retroalimentación:

La diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos que inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. El diagnóstico temprano es crucial para evitar macrosomía y complicaciones neonatales.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DIABETES GESTACIONAL (MANEJO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 485

Paciente de 26 semanas con diagnóstico reciente de Diabetes Gestacional. Se inicia plan nutricional y ejercicio. Después de 2 semanas, sus automonitoreos reportan glucosas en ayuno de 105 mg/dL y postprandiales (2h) de 145 mg/dL.

Pregunta 1

¿Cuál es la meta de control glucémico en ayuno y postprandial de 2 horas según la GPC?

A) Ayuno <95 mg/dL y 2h postprandial <120 mg/dL *

B) Ayuno <110 mg/dL y 2h postprandial <140 mg/dL.

C) Ayuno <126 mg/dL y 2h postprandial <180 mg/dL.

D) No hay metas estrictas en el embarazo.

Pregunta 2

Dado que la paciente no alcanzó metas con dieta, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera elección?

A) Insulina *

B) Metformina.

C) Glibenclamida.

D) Acarbosa.

Retroalimentación:

La insulina es el estándar de oro ya que no cruza la barrera placentaria. La metformina puede ser una alternativa en casos seleccionados (pacientes que rechazan insulina o dificultad en aplicación), pero la GPC prioriza la insulina.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DIABETES PREGESTACIONAL (COMPLICACIONES)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 486

Mujer de 30 años con DM1 de 10 años de evolución, actualmente con 8 semanas de embarazo. Su última HbA1c fue de 9.8%.

Pregunta 1

¿Cuál es la malformación congénita más específica asociada a la diabetes pregestacional mal controlada durante la organogénesis?

A) Síndrome de regresión caudal *

B) Comunicación interauricular.

C) Labio leporino.

D) Pie equinovaro.

Pregunta 2

¿Qué complicación fetal es más común en la diabetes gestacional (segundo/tercer trimestre) a diferencia de la pregestacional?

A) Macrosomía fetal y distocia de hombros *

B) Malformaciones cardíacas.

C) Agenesia renal.

D) Microcefalia.

Retroalimentación:

La hiperglucemia en el primer trimestre es teratogénica (diabetes pregestacional). La hiperglucemia en la segunda mitad del embarazo causa hiperinsulinismo fetal, lo que actúa como hormona de crecimiento provocando macrosomía.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ESTADOS HIPERTENSIVOS (CLASIFICACIÓN)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 487

Paciente de 12 semanas de gestación acude a su primera cita. Se detectan cifras tensionales de 150/95 mmHg en dos tomas separadas. No refiere síntomas ni tiene proteinuria.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico de esta paciente?

A) Hipertensión crónica *

B) Preeclampsia.

C) Hipertensión gestacional.

D) Hipertensión de bata blanca.

Pregunta 2

¿Cómo se define la hipertensión gestacional?

A) Hipertensión que aparece después de la semana 20 de gestación, sin proteinuria ni datos de severidad *

B) Hipertensión con proteinuria antes de la semana 20.

C) Cifras >160/110 mmHg únicamente.

D) Presencia de convulsiones.

Retroalimentación:

Toda hipertensión diagnosticada antes de la semana 20 se considera crónica. La hipertensión gestacional aparece después de la semana 20 y suele normalizarse en el posparto (12 semanas después).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PREECLAMPSIA (CRITERIOS DE SEVERIDAD)

Dificultad: Media

Caso Clínico 488

Paciente de 34 semanas presenta TA de 165/115 mmHg, cefalea intensa y visión borrosa (fosfenos). Los laboratorios reportan proteinuria de 300 mg en 24 horas y creatinina de 1.2 mg/dL.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico preciso y qué síntoma se considera un "dato de severidad"?

A) Preeclampsia con datos de severidad; Cefalea y alteraciones visuales *

B) Preeclampsia leve; Proteinuria.

C) Eclampsia; Fosfenos.

D) Hipertensión crónica; TA elevada.

Pregunta 2

¿Cuál es el fármaco de elección para la prevención de crisis convulsivas en esta paciente?

A) Sulfato de Magnesio *

B) Fenitoína.

C) Diazepam.

D) Levetiracetam.

Retroalimentación:

La preeclampsia es un síndrome sistémico. Los datos de severidad incluyen daño a órgano blanco (cerebro, hígado, riñón, pulmón) o cifras tensionales ≥160/110 mmHg. El sulfato de magnesio es superior a los anticonvulsivantes comunes en este contexto.

[Image of preeclampsia signs and symptoms]

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: SÍNDROME DE HELLP

Dificultad: Alta

Caso Clínico 489

Paciente con preeclampsia severa presenta dolor intenso en epigastrio y cuadrante superior derecho. Los laboratorios muestran: Plaquetas 85,000, AST 150 UI/L, y

presencia de esquistocitos en frotis de sangre periférica con Bilirrubina indirecta elevada.

Pregunta 1

¿Qué significan las siglas del Síndrome de HELLP?

A) Hemólisis (H), Enzimas hepáticas elevadas (EL) y Plaquetas bajas (LP) *

B) Hipertensión (H), Edema (E), Lípidos (L), Proteinuria (P).

C) Hemorragia (H), Eclampsia (E), Leucocitos (L), Parto (P).

D) Es un epónimo sin significado de siglas.

Pregunta 2

¿Cuál es la causa del dolor en epigastrio en estas pacientes?

A) Distensión de la cápsula de Glisson por edema o hematoma hepático *

B) Gastritis asociada al estrés.

C) Pancreatitis aguda.

D) Contracciones uterinas.

Retroalimentación:

El HELLP es una variante severa de la preeclampsia con alta mortalidad. La presencia de esquistocitos confirma la anemia hemolítica microangiopática. El manejo definitivo suele ser la interrupción del embarazo.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ECLAMPSIA (MANEJO DE URGENGENCIA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 490

Paciente de 38 semanas, sin control prenatal, es traída por presentar crisis convulsiva tónico-clónica generalizada en su domicilio. A su llegada se encuentra en estado post-ictal, TA 180/120 mmHg.

Pregunta 1

¿Cuál es la prioridad en el manejo inicial de la eclampsia?

A) Asegurar vía aérea, prevenir trauma, administrar carga de Sulfato de Magnesio y control de la TA *

B) Realizar cesárea de inmediato sin estabilizar.

C) Realizar tomografía de cráneo.

D) Administrar grandes volúmenes de soluciones cristaloides.

Pregunta 2

¿Cuál es el esquema de impregnación y mantenimiento del Sulfato de Magnesio (Esquema de Zuspan)?

A) 4 g IV en 15-20 min (carga) y 1 g/h (mantenimiento) *

B) 10 g IM dosis única.

C) 1 g IV cada 8 horas.

D) 20 g en infusión para 24 horas.

Retroalimentación:

La eclampsia es la presencia de convulsiones en una paciente con preeclampsia. El tratamiento definitivo es el nacimiento, pero NO debe realizarse hasta que la paciente esté estabilizada hemodinámicamente y con control de crisis.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DIABETES GESTACIONAL (METAS Y COMPLICACIONES)

Dificultad: Media

Caso Clínico 491

Paciente de 28 semanas con Diabetes Gestacional en tratamiento con insulina NPH. Acude a revisión con su bitácora de glucosa. Presenta niveles de ayuno persistentes de 105-110 mg/dL, aunque sus niveles postprandiales están en metas (<120 mg/dL).

Pregunta 1

¿Cuál es el ajuste terapéutico más apropiado para controlar la hiperglucemia de ayuno en esta paciente?

A) Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna *

B) Aumentar la dosis de insulina rápida matutina.

C) Disminuir la ingesta de carbohidratos en la cena únicamente.

D) Agregar metformina al mediodía.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación metabólica neonatal más frecuente en hijos de madres con diabetes gestacional mal controlada en las últimas semanas?

A) Hipoglucemia neonatal *

B) Hipercalcemia.

C) Policitemia por exceso de hierro.

D) Hipobilirrubinemia.

Retroalimentación:

La insulina NPH tiene un pico de acción que, administrado por la noche, ayuda a controlar la glucemia de la mañana. La hipoglucemia neonatal ocurre porque el feto está acostumbrado a niveles altos de glucosa (y por ende tiene niveles altos de

insulina propia); al nacer y cortarse el suministro materno, su insulina elevada desploma su glucosa.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DIABETES GESTACIONAL (SEGUIMIENTO POSPARTO)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 492

Paciente de 32 años que presentó Diabetes Gestacional controlada con dieta. Cursa su segundo día de puerperio tras parto eutócico.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta recomendada respecto al monitoreo de glucosa en el puerperio inmediato para una paciente que tuvo diabetes gestacional?

A) Suspender monitoreo y dieta especial si las glucosas capilares son normales tras el parto *

B) Continuar con insulina por 6 semanas.

C) Realizar curva de tolerancia a la glucosa antes del alta hospitalaria.

D) Mantener ayuno prolongado.

Pregunta 2

¿En qué momento se debe realizar la reclasificación metabólica (CTOG 75g) de la paciente para descartar DM2 persistente?

A) Entre las 6 y 12 semanas posparto *

B) Al año del nacimiento.

C) A las 24 horas del parto.

D) No es necesario si no tiene síntomas.

Retroalimentación:

La mayoría de las pacientes con diabetes gestacional vuelven a la euglucemia tras la expulsión de la placenta (que es la fuente de las hormonas diabetogénicas). Sin embargo, tienen un riesgo 7 veces mayor de desarrollar DM2 en el futuro.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DIABETES GESTACIONAL (CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN)

Dificultad: Media

Caso Clínico 493

Paciente con 30 semanas de gestación y Diabetes Gestacional. Acude a urgencias por náuseas, dolor abdominal y malestar general. Glucosa capilar de 250 mg/dL, cetonuria (+++) y pH arterial de 7.25.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el criterio de hospitalización según la GPC?

A) Cetoacidosis diabética; Toda paciente con glucosa >200 mg/dL y datos de acidosis requiere hospitalización *

B) Hiperglucemia simple; Manejo ambulatorio con ajuste de dieta.

C) Diabetes pregestacional; Referencia a tercer nivel.

D) Infección de vías urinarias.

Pregunta 2

¿Cuál es la meta de glucosa capilar antes de las comidas para considerar un control "excelente" durante la gestación?

A) <95 mg/dL *

B) <110 mg/dL.

C) <140 mg/dL.

D) <70 mg/dL.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PREECLAMPSIA (PROFILAXIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 494

Paciente de 12 semanas de gestación con antecedentes de preeclampsia en su embarazo anterior, IMC de 32 kg/m^2 y diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico.

Pregunta 1

¿Cuál es la medida profiláctica de primera elección para reducir el riesgo de preeclampsia en esta paciente de alto riesgo?

A) Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) 100-150 mg diarios antes de dormir *

B) Suplementación con Vitamina C y E.

C) Reposo absoluto desde el primer trimestre.

D) Restricción estricta de sal en la dieta.

Pregunta 2

¿Cuál es la ventana de tiempo ideal para iniciar esta profilaxis según la GPC?

A) Antes de la semana 16 de gestación *

B) Después de la semana 20.

C) En el tercer trimestre únicamente.

D) Al momento del parto.

Retroalimentación:

La aspirina a dosis bajas inhibe la síntesis de tromboxano, mejorando el equilibrio prostaciclina/tromboxano y favoreciendo una mejor placentación. Debe iniciarse idealmente entre la semana 12 y 16.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PREECLAMPSIA (MANEJO ANTIHIPERTENSIVO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 495

Paciente de 35 semanas con Preeclampsia. Presenta TA de 170/110 mmHg. Se decide iniciar manejo farmacológico para control agudo de la presión.

Pregunta 1

¿Cuáles son los tres fármacos recomendados por la GPC mexicana para el manejo de la crisis hipertensiva en el embarazo?

A) Labetalol, Hidralazina y Nifedipino *

B) Enalapril, Losartán y Atenolol.

C) Nitroprusiato y Furosemida.

D) Alfametildopa y Clonidina.

Pregunta 2

¿Por qué están contraindicados los IECA y ARA-II durante el embarazo?

A) Por riesgo de teratogenicidad (disgenesia renal fetal y oligohidramnios) *

B) Porque causan bradicardia materna extrema.

C) Porque aumentan el riesgo de desprendimiento de placenta.

D) Porque provocan hiperglucemia.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: TOXICIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO

Dificultad: Alta

Caso Clínico 496

Paciente con preeclampsia severa en infusión de Sulfato de Magnesio. Durante la guardia, la enfermera reporta que la paciente presenta una frecuencia respiratoria de 10 rpm y ausencia de reflejo rotuliano.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta inmediata y cuál es el antídoto específico?

A) Suspender infusión y administrar Gluconato de Calcio 1g IV *

B) Aumentar la infusión de líquidos.

C) Administrar Naloxona.

D) Realizar cesárea de urgencia.

Pregunta 2

¿Cuál es la vía de eliminación del magnesio que obliga a ajustar la dosis en pacientes con falla renal?

A) Renal *

B) Hepática.

C) Sudor.

D) Exhalación.

Retroalimentación:

El magnesio tiene un margen terapéutico estrecho (4-7 mEq/L). Los signos de toxicidad aparecen en orden: 1. Pérdida de reflejos (>7 mEq/L), 2. Depresión respiratoria (>10 mEq/L), 3. Paro cardiaco (>25 mEq/L).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PREECLAMPSIA (CRITERIOS DE NACIMIENTO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 497

Paciente de 32 semanas con preeclampsia con datos de severidad. Presenta control tensional difícil a pesar de doble fármaco y sospecha de restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) con Doppler de arteria umbilical alterado (flujo ausente en diástole).

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta más apropiada respecto al momento del nacimiento?

A) Interrupción del embarazo tras esquema de maduración pulmonar y estabilización *

B) Esperar a la semana 37 bajo vigilancia.

C) Tocolisis para evitar el parto.

D) Inducción con oxitocina de inmediato sin estabilizar.

Retroalimentación:

En preeclampsia severa antes de la semana 34, se intenta estabilizar 48 horas para administrar esteroides. Sin embargo, si hay datos de compromiso fetal severo (como Doppler alterado) o deterioro materno, no se debe retrasar el nacimiento.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: HIPERTENSIÓN CRÓNICA + PREECLAMPSIA SOBREAGREGADA

Dificultad: Media

Caso Clínico 498

Paciente de 32 años con hipertensión crónica conocida. Acude a las 28 semanas de embarazo por presentar cefalea y edema marcado. Sus laboratorios previos no tenían proteinuria; el actual reporta 1.5 g de proteínas en 24 horas y elevación de ácido úrico.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico?

A) Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada *

B) Preeclampsia pura.

C) Hipertensión gestacional tardía.

D) Nefropatía lúpica.

Pregunta 2

¿Qué nivel de ácido úrico se considera un marcador de mal pronóstico y mayor riesgo de complicaciones en la preeclampsia?

A) >6 mg/dL *

B) >2 mg/dL.

C) >10 mg/dL.

D) No tiene valor clínico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PREECLAMPSIA (MANEJO POSPARTO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 499

Paciente post-cesárea por preeclampsia severa. Se encuentra en su primer día de puerperio.

Pregunta 1

¿Cuánto tiempo debe mantenerse la vigilancia y la profilaxis con Sulfato de Magnesio en el posparto?

A) Al menos 24 horas después del parto o de la última convulsión *

B) Se suspende inmediatamente al nacer el bebé.

C) Por 7 días.

D) Solo si la presión sigue alta.

Pregunta 2

¿Cuál es el riesgo de presentar eclampsia en el periodo de puerperio (eclampsia tardía)?

A) El riesgo persiste hasta las 4-6 semanas posparto *

B) Es inexistente después de 24 horas.

C) Solo ocurre en las primeras 2 horas.

D) Solo ocurre si la paciente amamanta.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PREECLAMPSIA (TEORÍAS ETIOLÓGICAS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 500

Se discute en sesión académica la fisiopatología de la preeclampsia.

Pregunta 1

¿Cuál es el evento fisiopatológico primario considerado el "disparador" de la enfermedad?

A) Fallo en la segunda oleada de invasión trofoblástica de las arterias espirales *

B) Ingesta excesiva de sodio.

C) Infección por VPH.

D) Compresión de la vena cava por el útero.

Pregunta 2

¿Qué factor angiogénico se encuentra elevado en el suero de mujeres con preeclampsia y se usa como marcador de predicción?

A) sFlt-1 (Tirosina quinasa 1 similar al Fms soluble) *

B) Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF).

C) Estrógeno.

D) Progesterona.

Retroalimentación:

Al no invadirse adecuadamente las arterias espirales, estas conservan su alta resistencia, lo que causa hipoxia placentaria y liberación de factores antiangiogénicos (como sFlt-1) a la circulación materna, dañando el endotelio sistémico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DIABETES GESTACIONAL (MALFORMACIONES Y PRONÓSTICO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 501

Paciente con DM pregestacional mal controlada (HbA1c 10.2%) que acude a ultrasonido estructural de las 20 semanas. Se detecta una anomalía cardíaca compleja.

Pregunta 1

¿Cuál es la malformación cardíaca más frecuente en hijos de madres diabéticas (aunque no sea la más específica)?

A) Comunicación Interventricular (CIV) *

B) Transposición de grandes vasos.

C) Tetralogía de Fallot.

D) Estenosis aórtica.

Pregunta 2

¿Cuál es la cardiopatía que presenta una resolución espontánea tras el nacimiento al normalizarse los niveles de insulina?

A) Miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica *

B) Persistencia del conducto arterioso.

C) Coartación de la aorta.

D) Comunicación interauricular.

Retroalimentación:

La hiperinsulinemia fetal estimula el crecimiento excesivo de las células miocárdicas, especialmente en el tabique interventricular. Una vez que el bebé nace y cesa el estímulo de la glucosa materna, la hipertrofia suele retroceder en semanas o meses.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DIABETES GESTACIONAL (INDUCCIÓN DEL PARTO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 502

Paciente con Diabetes Gestacional controlada con dieta y ejercicio. Cursa embarazo de 39 semanas. El peso fetal estimado por ultrasonido es de 3,600g.

Pregunta 1

¿Cuál es la recomendación de la GPC respecto al momento del parto en pacientes con DG bien controlada metabólicamente?

A) Inducción del parto o esperar inicio espontáneo entre la semana 39 y 40.6 *

B) Cesárea electiva obligatoria a las 38 semanas.

C) Esperar hasta la semana 42.

D) Inducción a las 37 semanas.

Pregunta 2

¿A partir de qué peso fetal estimado se recomienda la cesárea electiva para evitar la distocia de hombros en pacientes diabéticas?

A) >4,500 gramos *

B) >3,800 gramos.

C) >4,000 gramos.

D) >5,000 gramos.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PREECLAMPSIA (MANEJO AMBULATORIO VS HOSPITALARIO)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 503

Paciente de 32 semanas con TA de 145/95 mmHg, sin síntomas de severidad, laboratorios normales y bienestar fetal conservado.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta a seguir según la GPC para una preeclampsia sin datos de severidad antes de la semana 37?

A) Manejo ambulatorio con vigilancia estrecha de TA y signos de alarma 2 veces por semana *

B) Interrupción inmediata del embarazo.

C) Hospitalización con Sulfato de Magnesio profiláctico.

D) Tocolisis profiláctica.

Pregunta 2

¿En qué momento se recomienda la interrupción del embarazo en pacientes con preeclampsia sin datos de severidad?

A) Al cumplir las 37 semanas de gestación *

B) A las 40 semanas.

C) A las 34 semanas.

D) Tan pronto se haga el diagnóstico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ECLAMPSIA (DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 504

Paciente de 30 semanas con preeclampsia severa que presenta una crisis convulsiva. Tras la administración de 4g de Sulfato de Magnesio, la paciente presenta una segunda convulsión 15 minutos después.

Pregunta 1

¿Cuál es el manejo farmacológico ante una convulsión recurrente en eclampsia a pesar del sulfato de magnesio?

A) Administrar un bolo adicional de 2g de Sulfato de Magnesio *

B) Administrar Diazepam 10mg IV.

C) Iniciar carga de Fenitoína.

D) Propofol inmediato.

Pregunta 2

¿Qué estudio de imagen debe solicitarse si la paciente presenta coma persistente, focalización neurológica o convulsiones atípicas?

A) Tomografía o Resonancia Magnética de Cráneo *

B) Electroencefalograma únicamente.

C) Punción lumbar.

D) Arteriografía carotídea.

Retroalimentación:

La eclampsia puede cursar con el Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES). La imagen es necesaria para descartar hemorragia cerebral, que es la principal causa de muerte en estas pacientes.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA (DPPNI)

Dificultad: Media

Caso Clínico 505

Paciente de 36 semanas, con antecedente de preeclampsia, acude por dolor abdominal súbito, intenso, "en tabla", y sangrado transvaginal obscuro escaso. El registro cardiotocográfico muestra bradicardia fetal persistente.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el factor de riesgo más importante para esta patología?

A) DPPNI (Abruptio placentae); Hipertensión materna (Preeclampsia) *

B) Placenta previa; Multiparidad.

C) Ruptura uterina; Cesárea previa.

D) Vasa previa; Embarazo gemelar.

Pregunta 2

¿Cómo se denomina a la infiltración hemática del miometrio que puede ocurrir en un desprendimiento severo y que causa atonía uterina?

A) Útero de Couvelaire *

B) Síndrome de Asherman.

C) Acretismo placentario.

D) Inversión uterina.

Retroalimentación:

El DPPNI es una urgencia vital. El diagnóstico es CLÍNICO. El útero se siente rígido (hipertonía) y es doloroso. La ecografía puede ser negativa hasta en el 50% de los casos, por lo que no debe retrasar la cirugía si la clínica es clara.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PLACENTA PREVIA

Dificultad: Baja

Caso Clínico 506

Multípara de 34 semanas acude por sangrado transvaginal rojo rutilante, abundante, indoloro, que inició estando en reposo. El abdomen se encuentra blando, no doloroso, y los ruidos cardíacos fetales son normales.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico presuntivo y qué maniobra está ABSOLUTAMENTE contraindicada?

A) Placenta previa; Tacto vaginal *

B) DPPNI; Ultrasonido.

C) Ruptura prematura de membranas; Especuloscopia.

D) Trabajo de parto; Maniobras de Leopold.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de elección para confirmar la localización placentaria?

A) Ultrasonido transvaginal (con transductor suave) *

B) Resonancia magnética.

C) Radiografía de abdomen.

D) Amniocentesis.

Retroalimentación:

La placenta previa se caracteriza por sangrado "silencioso" (sin dolor). El tacto vaginal puede desprender más la placenta y causar una hemorragia fatal. El ultrasonido transvaginal es seguro y más preciso que el abdominal para medir la distancia al orificio cervical interno.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ACRETISMO PLACENTARIO

Dificultad: Alta

Caso Clínico 507

Paciente con antecedente de 3 cesáreas previas. El ultrasonido de tercer trimestre reporta una placenta previa total con pérdida de la zona de interfase entre el miometrio y la placenta, y presencia de lagunas vasculares abundantes ("aspecto en queso suizo").

Pregunta 1

¿Cómo se clasifica la invasión placentaria que llega hasta la serosa del útero e invade órganos vecinos como la vejiga?

A) Placenta percreta *

B) Placenta acreta.

C) Placenta increta.

D) Placenta previa.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo quirúrgico programado recomendado para una paciente con sospecha de placenta percreta?

A) Cesárea-Histerectomía total abdominal sin intentar despegar la placenta *

B) Parto vaginal conducido.

C) Alumbramiento manual bajo anestesia.

D) Legrado uterino post-cesárea.

Retroalimentación:

El riesgo de acretismo aumenta exponencialmente con el número de cesáreas previas y la presencia de placenta previa. Intentar despegar una placenta acreta puede provocar una hemorragia masiva de hasta 5 litros en minutos.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: RUPTURA UTERINA

Dificultad: Alta

Caso Clínico 508

Paciente en trabajo de parto con antecedente de cesárea previa. Presenta de forma súbita dolor intenso, cese de las contracciones uterinas, sangrado vaginal y se palpan partes fetales fácilmente a través de la pared abdominal. El feto presenta una pérdida de la estación (el bebé "se sube").

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el signo premonitorio clásico?

A) Ruptura uterina; Anillo de Bandl (segmento inferior muy distendido) *

B) DPPNI; Hipertonía.

C) Placenta previa; Sangrado indoloro.

D) Inversión uterina; Choque neurogénico.

Retroalimentación:

La ruptura uterina es una de las complicaciones más catastróficas. El factor de riesgo principal es la cicatriz uterina previa (cesárea o miomectomía). Requiere laparotomía inmediata para extracción fetal y reparación o histerectomía.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: VASA PREVIA

Dificultad: Alta

Caso Clínico 509

Al realizar la amniorrexis artificial (ruptura de membranas) durante el trabajo de parto, se presenta sangrado vaginal inmediato y bradicardia fetal súbita. La madre se encuentra hemodinámicamente estable.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la causa del sangrado?

A) Vasa previa; El sangrado es de origen FETAL por ruptura de vasos umbilicales desprotegidos *

B) Desprendimiento de placenta; Sangrado materno.

C) Placenta previa; Sangrado materno.

D) Laceración cervical; Sangrado materno.

Pregunta 2

¿Qué tipo de inserción del cordón umbilical se asocia frecuentemente a la vasa previa?

A) Inserción velamentosa del cordón *

B) Inserción marginal (placenta en raqueta).

C) Inserción central.

D) Cordón corto.

Retroalimentación:

En la vasa previa, los vasos fetales atraviesan las membranas por delante de la presentación. Al romperse la fuente, se rompen los vasos. Como el feto tiene muy poco volumen sanguíneo, una pérdida pequeña causa choque hipovolémico fetal rápido.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EVALUACIÓN DE BIENESTAR FETAL (PERFIL BIOFÍSICO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 510

Paciente con sospecha de restricción del crecimiento se le realiza un Perfil Biofísico de Manning.

Pregunta 1

¿Cuáles son los 5 parámetros que evalúa el Perfil Biofísico y cuál es el primero en alterarse ante la hipoxia aguda?

A) Reactividad cardíaca (NST), movimientos respiratorios, movimientos fetales, tono fetal y líquido amniótico; El NST y los movimientos respiratorios *

B) Frecuencia cardiaca, peso, talla, glucosa y pH.

C) Dilatación, borramiento, estación, posición y consistencia.

D) Solo la cantidad de líquido amniótico.

Pregunta 2

¿Qué parámetro del perfil biofísico refleja la condición de hipoxia CRÓNICA?

A) Volumen de líquido amniótico (Oligohidramnios por redistribución de flujo renal) *

B) Tono fetal.

C) Movimientos corporales.

D) Reactividad de la frecuencia cardíaca.

Retroalimentación:

Un puntaje de 8/10 o 10/10 es normal. Un puntaje de 4/10 o menos indica compromiso fetal severo y generalmente requiere la interrupción del embarazo.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: HEMORRAGIA POSPARTO (ATONÍA UTERINA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 511

Paciente de 30 años, multípara de 4, con antecedente de embarazo gemelar. Tras un parto eutócico rápido, presenta sangrado transvaginal abundante (estimado >1000 ml) con pérdida de estabilidad hemodinámica. Al palpar el abdomen, el útero se siente blando, por arriba de la cicatriz umbilical.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más común de hemorragia posparto inmediata y cuál es la primera medida farmacológica a realizar tras el masaje uterino?

A) Atonía uterina; Administración de Oxitocina IV o IM *

B) Retención de restos placentarios; Legrado.

C) Inversión uterina; Maniobra de Johnson.

D) Laceración del canal de parto; Sutura de desgarro.

Pregunta 2

Si la oxitocina falla, ¿cuál es el siguiente paso farmacológico (uterotónico) de elección, considerando que la paciente NO es hipertensa?

A) Ergonovina (Ergotamina) o Carbetocina *

B) Misoprostol rectal únicamente.

C) Gluconato de calcio.

D) Adrenalina.

Retroalimentación:

La hemorragia posparto es una de las principales causas de muerte materna. La nemotecnia de las "4 T" ayuda a recordar las causas: Tono (Atonía), Tejido (Restos), Trauma (Desgarros) y Trombina (Coagulopatía).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: HEMORRAGIA POSPARTO (MANEJO QUIRÚRGICO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 512

Paciente con hemorragia posparto refractaria a masaje uterino y fármacos uterotónicos. Se decide realizar manejo quirúrgico conservador.

Pregunta 1

¿Cuál es la técnica de sutura de compresión uterina más utilizada para controlar la atonía sin realizar histerectomía?

A) Sutura de B-Lynch *

B) Técnica de Pereyra.

C) Sutura de Hayman.

D) Cerclaje de Shirodkar.

Pregunta 2

¿Qué arterias pueden ligarse quirúrgicamente como medida heroica para disminuir el flujo pélvico en una hemorragia incoercible?

A) Arterias ilíacas internas (hipogástricas) *

B) Arterias ilíacas externas.

C) Arterias ováricas únicamente.

D) Arteria aorta abdominal.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: INVERSIÓN UTERINA

Dificultad: Alta

Caso Clínico 513

Tras el alumbramiento, se realiza tracción excesiva del cordón umbilical. De forma súbita, la paciente presenta dolor intenso y choque neurogénico. A la exploración se observa una masa carnosa que protruye por la vagina y ausencia del fondo uterino en la palpación abdominal.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la maniobra de reducción inmediata recomendada?

A) Inversión uterina; Maniobra de Johnson (reintroducir el fondo con la palma de la mano) *

B) Prolapso uterino; Histerectomía.

C) Mioma parido; Torsión del pedículo.

D) Ruptura uterina; Laparotomía.

Retroalimentación:

La inversión uterina es una urgencia rara pero fatal si no se trata. El choque suele ser desproporcionado a la pérdida hemática debido a la tracción de los ligamentos y nervios pélvicos.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID) EN OBSTETRICIA

Dificultad: Alta

Caso Clínico 514

Paciente con antecedente de desprendimiento de placenta (DPPNI) severo. Empieza a presentar sangrado por sitios de punción venosa, hematuria y equimosis espontáneas.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo por el cual el DPPNI desencadena CID?

A) Liberación masiva de tromboplastina tisular al torrente circulatorio materno *

B) Pérdida de plaquetas por hemorragia externa.

C) Destrucción mecánica de eritrocitos en la placenta.

D) Insuficiencia hepática aguda.

Pregunta 2

¿Cuál es el hallazgo de laboratorio más sensible para sospechar CID en este contexto?

A) Descenso de Fibrinógeno y elevación de Dímero D *

B) Elevación de la Hemoglobina.

C) Trombocitosis.

D) Prolongación del tiempo de sangrado únicamente.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EMBOLISMO DE LÍQUIDO AMNIÓTICO

Dificultad: Muy Alta

Caso Clínico 515

Paciente en trabajo de parto avanzado presenta de forma súbita disnea, cianosis, colapso cardiovascular y convulsiones, seguido de hemorragia masiva por coagulopatía.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable ante este cuadro catastrófico e impredecible?

A) Embolismo de líquido amniótico (Síndrome anafilactoide del embarazo) *

B) Tromboembolia pulmonar (TEP).

C) Infarto agudo al miocardio.

D) Preeclampsia severa.

Retroalimentación:

Aunque se llama "embolismo", la fisiopatología actual sugiere una respuesta inmune masiva (anafilaxia) al contacto de elementos fetales con la circulación materna. La mortalidad es cercana al 80%.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (TAMIZAJE Y BIRADS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 516

Mujer de 45 años, asintomática, acude a su primera mastografía de tamizaje. El reporte indica: "Presencia de nódulo de bordes mal definidos con microcalcificaciones pleomórficas agrupadas. BIRADS 4".

Pregunta 1

¿Qué significa la clasificación BIRADS 4 y cuál es la conducta obligatoria a seguir?

A) Hallazgos sospechosos de malignidad; Realizar biopsia histopatológica *

B) Hallazgo benigno; Mastografía en 1 año.

C) Probablemente benigno; Control en 6 meses.

D) Malignidad confirmada; Inicio de quimioterapia.

Pregunta 2

¿A partir de qué edad recomienda la GPC mexicana iniciar el tamizaje anual con mastografía en mujeres sin factores de riesgo adicionales?

A) 40 años *

B) 50 años.

C) 35 años.

D) 25 años.

Retroalimentación:

La clasificación BI-RADS estandariza los reportes radiológicos. BI-RADS 4 y 5 requieren biopsia obligatoria. BI-RADS 3 requiere seguimiento semestral.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (FACTORES DE RIESGO Y GENÉTICA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 517

Mujer de 35 años cuya madre y hermana tuvieron cáncer de mama antes de los 45 años. Ella está preocupada por su riesgo personal.

Pregunta 1

¿Qué mutaciones genéticas son las más frecuentemente asociadas a síndromes de cáncer de mama y ovario hereditario?

A) BRCA1 y BRCA2 *

B) HER2/neu.

C) p53 y RB.

D) APC y KRAS.

Pregunta 2

¿Cuál de los siguientes se considera el factor de riesgo reproductivo más importante para desarrollar cáncer de mama?

A) Nuliparidad o primer embarazo después de los 30 años *

) Uso de anticonceptivos por 1 año.

C) Lactancia materna prolongada.

D) Menarquia tardía.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (TIPOS HISTOLÓGICOS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 518

Paciente con reporte de biopsia de mama que indica: "Carcinoma con formación de túbulos, nidos de células que rompen la membrana basal e invaden el estroma circundante".

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de mama maligno?

A) Carcinoma ductal infiltrante (o no especial) *

B) Carcinoma lobulillar in situ.

C) Carcinoma medular.

D) Enfermedad de Paget del pezón.

Pregunta 2

¿Qué variante de cáncer de mama se caracteriza clínicamente por "piel de naranja", edema y eritema, simulando una mastitis, pero sin fiebre?

A) Cáncer de mama inflamatorio *

B) Carcinoma mucinoso.

C) Comedocarcinoma.

D) Tumor filodes.

Retroalimentación:

El carcinoma ductal infiltrante representa aproximadamente el 80% de los casos. El cáncer inflamatorio es la forma más agresiva (Estadio IIIB clínico de inicio) debido a la invasión de los linfáticos dérmicos.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (TRATAMIENTO Y GANGLIO CENTINELA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 519

Paciente con tumor de 1.5 cm en cuadrante superior externo de mama derecha, sin adenopatías palpables en axila.

Pregunta 1

¿Cuál es la técnica de elección para evaluar el estado axilar en tumores pequeños sin ganglios clínicamente sospechosos?

A) Biopsia de ganglio centinela *

B) Disección axilar completa (niveles I, II y III).

C) Solo observación.

D) Radioterapia axilar profiláctica.

Pregunta 2

¿Qué fármaco modulador selectivo de los receptores de estrógeno (SERM) es el pilar del tratamiento adyuvante en mujeres premenopáusicas con receptores hormonales positivos?

A) Tamoxifeno *

B) Letrozol.

C) Trastuzumab.

D) Anastrozol.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: INFECCIONES VAGINALES (TRICOMONIASIS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 520

Paciente acude por flujo vaginal abundante, amarillo-verdoso, espumoso y con mal olor. Refiere prurito intenso y dispareunia. A la colposcopia se observa el cérvix con punteado hemorrágico ("cérvix en fresa").

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y qué se observa en el examen en fresco (frotis salino)?

A) Trichomonas vaginalis; Protozoarios flagelados con movimiento activo *

B) Candida albicans; Hifas y levaduras.

C) Gardnerella vaginalis; Células clave.

D) Chlamydia trachomatis; Cuerpos de inclusión.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección y qué recomendación adicional es INDISPENSABLE?

A) Metronidazol 2g dosis única; Tratamiento obligatorio a la pareja sexual *

B) Fluconazol; No requiere tratar a la pareja.

C) Doxiciclina; Abstinencia por 1 mes.

D) Vinagre blanco local; Lavados diarios.

Retroalimentación:

La tricomoniasis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS). A diferencia de la vaginosis o candidiasis, el tratamiento de la pareja es mandatorio para evitar el efecto "ping-pong".

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (INMUNOHISTOQUÍMICA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 521

Se recibe el reporte de inmunohistoquímica de una paciente de 55 años con cáncer de mama: Receptores de Estrógeno (RE) 0%, Receptores de Progesterona (RP) 0%, HER2/neu Negativo (0), Ki-67 40%.

Pregunta 1

¿A qué subtipo molecular pertenece este tumor y cuál es su pronóstico comparativo?

A) Triple Negativo (Basal-like); Mal pronóstico debido a mayor agresividad y falta de terapias dirigidas *

B) Luminal A; Excelente pronóstico.

C) Luminal B; Pronóstico intermedio.

D) HER2 enriquecido; Pronóstico reservado pero con terapia dirigida disponible.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento sistémico de elección para un tumor con este perfil molecular?

A) Quimioterapia citotóxica convencional (p. ej. Antraciclinas y Taxanos) *

B) Hormonoterapia con Tamoxifeno.

C) Terapia dirigida con Trastuzumab.

D) Inhibidores de la aromatasa únicamente.

Retroalimentación:

Los tumores triple negativos no responden a terapia hormonal ni a Trastuzumab. Son más frecuentes en mujeres jóvenes y en portadoras de mutación BRCA1. El Ki-67 elevado indica una alta tasa de proliferación celular.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (PERFIL HER2 POSITIVO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 522

Paciente con diagnóstico de cáncer de mama cuyos estudios muestran una sobreexpresión de la proteína HER2 (3+ por inmunohistoquímica).

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo de acción del Trastuzumab y qué estudio de control es obligatorio realizar periódicamente debido a su principal efecto adverso?

A) Anticuerpo monoclonal contra el receptor HER2; Ecocardiograma para vigilar la fracción de eyección (cardiotoxicidad) *

B) Inhibidor de la tirosina quinasa; Pruebas de función hepática.

C) Antagonista de estrógenos; Mastografía bilateral.

D) Citotóxico directo; Biometría hemática por neutropenia.

Pregunta 2

¿Cuál es la diferencia entre la cardiotoxicidad inducida por Antraciclinas (Doxorrubicina) y la inducida por Trastuzumab?

A) El Trastuzumab causa una toxicidad tipo II (reversible y no dependiente de la dosis), mientras que las antraciclinas causan daño irreversible dependiente de la dosis acumulada *

B) No hay diferencia, ambas son irreversibles.

C) El Trastuzumab solo afecta el pulmón.

D) Las antraciclinas son cardioprotectoras.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (ENFERMEDAD DE PAGET)

Dificultad: Media

Caso Clínico 523

Paciente de 62 años consulta por una lesión eccematosa en el pezón derecho, con descamación y erosión persistente de 4 meses de evolución, que no ha mejorado con corticoides tópicos. Refiere prurito y quemazón.

Pregunta 1

¿Cuál es la sospecha diagnóstica principal y qué hallazgo histopatológico confirma la enfermedad?

A) Enfermedad de Paget del pezón; Células de Paget (grandes, citoplasma claro, núcleos prominentes) en la epidermis *

B) Mastitis crónica; Abscesos periductales.

C) Adenoma del pezón; Proliferación glandular benigna.

D) Eccema de contacto; Infiltrado eosinofílico.

Pregunta 2

¿Con qué patología subyacente se asocia la Enfermedad de Paget en más del 90% de los casos?

A) Carcinoma ductal (in situ o infiltrante) subyacente *

B) Fibroadenoma gigante.

C) Papiloma intraductal.

D) Mastopatía fibroquística severa.

Retroalimentación:

Toda "dermatitis" del pezón que no cura debe ser biopsiada. El Paget es una manifestación cutánea de un cáncer que viaja por los conductos galactóforos hasta la superficie.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (ESTADIFICACIÓN TNM)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 524

Paciente con tumor mamario de 4 cm (T2) que presenta ganglios axilares ipsilaterales fijos entre sí (N2). Los estudios de extensión (TAC tórax/abdomen) no muestran metástasis (M0).

Pregunta 1

¿En qué etapa clínica (simplificada) se encuentra esta paciente y cuál suele ser el abordaje inicial recomendado?

A) Etapa localmente avanzada; Quimioterapia neoadyuvante (antes de la cirugía) *

B) Etapa temprana; Cirugía conservadora inmediata.

C) Etapa metastásica; Cuidados paliativos.

D) Etapa in situ; Resección local únicamente.

Pregunta 2

¿Cuál es el objetivo principal de la quimioterapia neoadyuvante?

A) Reducir el tamaño tumoral para permitir cirugía conservadora y evaluar la respuesta in vivo al tratamiento *

B) Evitar que la paciente sea operada.

C) Tratar únicamente el dolor.

D) Sustituir a la radioterapia.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (LUMINAL A VS B)

Dificultad: Media

Caso Clínico 525

Mujer postmenopáusica con tumor de 1 cm, Receptores Hormonales positivos (90%), HER2 negativo y Ki-67 del 5%.

Pregunta 1

¿Cuál es el subtipo molecular y cuál es el tratamiento hormonal de primera elección para reducir el riesgo de recurrencia?

A) Luminal A; Inhibidores de la Aromatasa (Anastrozol o Letrozol) *

B) Luminal B; Tamoxifeno únicamente.

C) HER2 positivo; Trastuzumab.

D) Triple negativo; Observación.

Pregunta 2

¿Por qué se prefieren los Inhibidores de la Aromatasa sobre el Tamoxifeno en mujeres POSTmenopáusicas?

A) Porque en la postmenopausia la principal fuente de estrógenos es la conversión periférica de andrógenos por la aromatasa *

B) Porque el Tamoxifeno no funciona después de los 50 años.

C) Porque no tienen efectos secundarios.

D) Porque son más baratos.

Retroalimentación:

El Luminal A es el de mejor pronóstico. En postmenopáusicas, los inhibidores de la aromatasa son ligeramente superiores al tamoxifeno para prevenir recurrencias, aunque aumentan el riesgo de osteoporosis.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (SEGUIMIENTO)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 526

Paciente que terminó tratamiento exitoso por cáncer de mama etapa I hace 2 años. Acude a su cita de control anual.

Pregunta 1

¿Qué estudio de imagen es el único recomendado de forma rutinaria para el seguimiento de una paciente asintomática con antecedente de cáncer de mama?

A) Mastografía anual (de la mama remanente y contralateral) *

B) Marcadores tumorales (CA 15-3) cada 3 meses.

C) Gammagrama óseo semestral.

D) Tomografía por emisión de positrones (PET-CT).

Pregunta 2

¿Ante qué síntoma nuevo se debe sospechar inmediatamente una metástasis ósea (sitio más común de recurrencia a distancia)?

A) Dolor óseo persistente y localizado, o fracturas ante traumatismos mínimos *

B) Pérdida de cabello.

C) Visión borrosa.

D) Diarrea crónica.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ESTERILIDAD (ABORDAJE INICIAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 527

Pareja joven (ella de 28 años, él de 30) acuden porque no han logrado el embarazo tras 14 meses de relaciones sexuales regulares sin protección.

Pregunta 1

¿Cómo se define la esterilidad primaria en esta pareja y cuál es el primer estudio a solicitar al varón?

A) Incapacidad de concebir tras 12 meses; Seminograma (espermatobioscopía) *

B) Incapacidad de concebir tras 6 meses; Biopsia testicular.

C) Pérdida recurrente de gestaciones; Cariotipo.

D) Ausencia de ovulación; Testosterona total.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de elección para evaluar la permeabilidad tubárica (factor tuboperitoneal) en la mujer?

A) Histerosalpingografía (HSG) *

B) Ultrasonido pélvico.

C) Laparoscopia exploradora de inicio.

D) Resonancia magnética pélvica.

Retroalimentación:

La esterilidad afecta al 15% de las parejas. El estudio debe ser simultáneo. El seminograma es sencillo y descarta el factor masculino (responsable del 40-50% de los casos).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ESTERILIDAD (FACTOR OVÁRICO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 528

Paciente de 34 años con ciclos irregulares (oligomenorrea) que desea embarazo. Se sospecha anovulación.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de laboratorio más sencillo para confirmar que ha ocurrido la ovulación y en qué día del ciclo debe realizarse?

A) Progesterona sérica en el día 21 del ciclo (fase lútea media) *

B) FSH en el día 14.

C) Estradiol en el día 1.

D) Hormona antimülleriana en el día 10.

Pregunta 2

¿Qué hormona se utiliza como marcador de la "reserva ovárica" ya que sus niveles son independientes del día del ciclo menstrual?

A) Hormona Antimülleriana (AMH) *

B) LH.

C) Prolactina.

D) TSH.

Retroalimentación:

Niveles de progesterona >3 ng/mL en el día 21 confirman que hubo ovulación. La AMH refleja la cantidad de folículos primordiales restantes; niveles bajos sugieren una baja reserva ovárica.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: REPRODUCCIÓN ASISTIDA (INSEMINACIÓN VS FIV)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 529

Pareja con esterilidad de 2 años de evolución. Ella tiene permeabilidad tubárica bilateral confirmada. El seminograma muestra una oligozoospermia leve (concentración de 12 millones/ml, siendo lo normal >15).

Pregunta 1

¿Cuál es la técnica de reproducción asistida de baja complejidad indicada inicialmente en este caso?

A) Inseminación Artificial (IA) *

B) Fertilización In Vitro (FIV).

C) Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI).

D) Coito programado únicamente.

Pregunta 2

¿Cuál es la indicación absoluta para pasar directamente a Fertilización In Vitro (Alta complejidad)?

A) Obstrucción tubárica bilateral (factor tubárico) o fallo de 3-4 ciclos de IA *

B) Paciente joven con SOP.

C) Deseo de tener gemelos.

D) Endometriosis grado I.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: SÍNDROME DE HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA (SHEO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 530

Paciente en tratamiento para FIV que, tras la administración de hCG para la descarga folicular, presenta dolor abdominal, distensión marcada, ascitis, náuseas y oliguria. Sus ovarios se palpan aumentados de tamaño (12 cm).

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de este síndrome?

A) Aumento de la permeabilidad vascular mediado por factores como el VEGF, produciendo paso de líquido al tercer espacio *

B) Infección pélvica masiva.

C) Ruptura de quistes ováricos.

D) Trombosis de la vena cava.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación hidroelectrolítica y hematológica más grave que pone en riesgo la vida de la paciente?

A) Hemoconcentración con riesgo de tromboembolismo e insuficiencia renal prerrenal *

B) Hiponatremia severa.

C) Anemia hemolítica.

D) Trombocitopenia aguda.

Retroalimentación:

El SHEO es la complicación más grave de la inducción de la ovulación. El manejo es soporte (líquidos, control de electrolitos) y prevención de trombosis con heparina.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ESTERILIDAD (FACTOR MASCULINO - VARICOCELE)

Dificultad: Media

Caso Clínico 531

Varón de 31 años acude por incapacidad de concebir con su pareja tras 18 meses. En la exploración física se palpa una masa de aspecto "en bolsa de gusanos" en el escroto izquierdo que aumenta con la maniobra de Valsalva. El seminograma reporta oligoastenoteratozoospermia.

Pregunta 1

¿Cuál es la patología más probable y cuál es el mecanismo por el cual afecta la calidad espermática?

A) Varicocele; Aumento de la temperatura intratesticular y reflujo de metabolitos suprarrenales *

B) Hidrocele; Compresión mecánica del epidídimo.

C) Orquitis por parotiditis; Atrofia testicular post-viral.

D) Criptorquidia; Detención de la maduración de células de Sertoli.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para mejorar el potencial de fertilidad en este paciente?

A) Varicocelectomía quirúrgica (microquirúrgica o laparoscópica) *

B) Tratamiento con testosterona exógena.

C) Administración de Vitamina E y Zinc únicamente.

D) Inseminación artificial sin tratar al varón.

Retroalimentación:

El varicocele es la causa tratable más común de esterilidad masculina. Ocurre más frecuentemente del lado izquierdo debido a la anatomía de la vena espermática que desemboca en ángulo recto en la vena renal.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: INDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO (SCORE DE BISHOP)

Dificultad: Media

Caso Clínico 532

Paciente de 41 semanas de gestación (embarazo prolongado) programada para inducción del trabajo de parto. Al tacto vaginal se encuentra: cérvix con 2 cm de dilatación, 50% de borramiento, consistencia media, posición intermedia y presentación en plano -2 (estación).

Pregunta 1

De acuerdo con el Score de Bishop, ¿cuál es el puntaje de esta paciente y qué conducta es la más apropiada para iniciar la inducción?

A) Bishop de 5; Maduración cervical con prostaglandinas (Dinoprostona o Misoprostol) *

B) Bishop de 9; Conducción directa con oxitocina.

C) Bishop de 2; Cesárea inmediata.

D) Bishop de 12; Amniotomía únicamente.

Pregunta 2

¿Cuál es el puntaje de Bishop mínimo requerido para considerar que un cérvix es "favorable" y que la probabilidad de éxito de inducción con oxitocina es alta?

A) ≥6 puntos *

B) ≥10 puntos.

C) ≥3 puntos.

D) ≥8 puntos.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: TRABAJO DE PARTO (PARTOGRAMA Y FASES)

Dificultad: Media

Caso Clínico 533

Primigesta en fase activa de trabajo de parto. Se registra en el partograma una dilatación de 6 cm a las 10:00 am. A las 14:00 pm, tras una nueva evaluación, la paciente persiste con 6 cm de dilatación a pesar de tener contracciones de adecuada intensidad.

Pregunta 1

¿Cómo se define esta alteración en el partograma de la OMS y cuál es el manejo inicial recomendado?

A) Detención secundaria de la dilatación; Evaluar desproporción cefalopélvica y considerar amniotomía o refuerzo con oxitocina *

B) Fase latente prolongada; Reposo farmacológico.

C) Parto precipitado; Preparar atención del expulsivo.

D) Expulsivo prolongado; Uso de fórceps.

Pregunta 2

¿Cuál es la velocidad de dilatación mínima esperada en la fase activa para una paciente primigesta según los criterios clásicos de Friedman?

A) 1.2 cm/hora *

B) 0.5 cm/hora.

C) 2.0 cm/hora.

D) 1.5 cm/hora cada 30 minutos.

Retroalimentación:

El partograma es la herramienta legal y clínica fundamental para detectar distocias. La fase activa comienza actualmente a los 5-6 cm de dilatación (según guías recientes de la OMS/ACOG).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: INDUCCIÓN DEL PARTO (MISOPROSTOL VS OXITOCINA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 534

Paciente de 39 semanas con indicación de inducción por preeclampsia sin datos de severidad. Presenta un Bishop de 3.

Pregunta 1

¿Cuál es la contraindicación absoluta para el uso de Misoprostol (análogo de PGE1) en la maduración cervical?

A) Antecedente de cesárea previa o cirugía uterina (miomectomía) por riesgo de ruptura *

B) Diabetes gestacional.

C) Edad materna avanzada.

D) Presentación cefálica.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación más grave de la hiperestimulación uterina (taquisistolia) secundaria al uso de oxitocina o prostaglandinas?

A) Hipoxia fetal (alteración de la reserva placentaria) y ruptura uterina *

B) Inversión uterina.

C) Desprendimiento de retina materno.

D) Embolismo de líquido amniótico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: GINECOLOGÍA INFANTO-JUVENIL (VULVOVAGINITIS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 535

Niña de 5 años acude por prurito vulvar, eritema y flujo vaginal amarillento. La madre refiere que la niña ha estado explorando su cuerpo y a veces olvida lavarse las manos.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más frecuente de vulvovaginitis en la edad prepuberal?

A) Inespecífica (higiene deficiente, irritantes, contaminación fecal) *

B) Candidiasis vaginal.

C) Abuso sexual (siempre debe descartarse ante ITS).

D) Tricomoniasis.

Pregunta 2

¿Cuál es el primer paso en el manejo de una vulvovaginitis inespecífica en una niña?

A) Medidas de higiene (baños de asiento, ropa de algodón, limpieza de adelante hacia atrás) *

B) Metronidazol oral.

C) Nistatina tópica.

D) Estrógenos locales.

Retroalimentación:

En las niñas prepúberes, la mucosa vaginal es delgada y el pH es neutro por falta de estrógenos, lo que la hace muy susceptible a irritantes y bacterias fecales.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: GINECOLOGÍA INFANTO-JUVENIL (CUERPO EXTRAÑO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 536

Niña de 4 años presenta flujo vaginal fétido, crónico, sanguinolento y rebelde a tratamientos antibióticos previos.

Pregunta 1

Ante un flujo sanguinolento y fétido unilateral en una paciente pediátrica, ¿qué diagnóstico debe sospecharse obligatoriamente?

A) Cuerpo extraño endovaginal (comúnmente papel higiénico) *

B) Sarcoma botrioides (rabdomiosarcoma).

C) Pubertad precoz.

D) Infección por Shigella.

Pregunta 2

¿Cuál es el método de elección para la extracción y diagnóstico en estos casos sin dañar el himen?

A) Vaginoscopia (con otoscopio o endoscopio pediátrico) o lavado vaginal con solución salina *

B) Tacto rectal únicamente.

C) Cirugía abierta.

D) Dilatación cervical.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PUBERTAD PRECOZ

Dificultad: Alta

Caso Clínico 537

Niña de 7 años presenta aparición de telarquia (botón mamario) y pubarquia. Su edad ósea está adelantada 2 años respecto a la cronológica.

Pregunta 1

¿Cómo se define la pubertad precoz en niñas y cuál es la causa más frecuente de la variante "central"?

A) Aparición de caracteres sexuales antes de los 8 años; Idiopática (activación prematura del eje H-H-G) *

B) Antes de los 10 años; Tumor suprarrenal.

C) Antes de los 9 años; Quiste ovárico.

D) Antes de los 12 años; Hipotiroidismo.

Pregunta 2

¿Cuál es el fármaco de elección para frenar la progresión de la pubertad precoz central y evitar el cierre prematuro de las epífisis?

A) Análogos de GnRH de acción prolongada (Leuprolide) *

B) Estrógenos a dosis bajas.

C) Danazol.

D) Metformina.

Retroalimentación:

El tratamiento busca "desensibilizar" los receptores de la hipófisis mediante una estimulación constante con análogos de GnRH, lo que detiene la secreción de LH y FSH.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: MALFORMACIONES HIMENEALES (HIMEN IMPERFORADO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 538

Adolescente de 13 años acude por dolor abdominal cíclico mensual desde hace 4 meses. Refiere que no ha tenido su menarquia a pesar de tener un desarrollo mamario estadio IV de Tanner. A la exploración se observa una membrana abombada y violácea a nivel de la vulva.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cómo se denomina a la acumulación de sangre en la vagina?

A) Himen imperforado; Hematocolpos *

B) Agenesia de vagina; Síndrome de Mayer-Rokitansky.

C) Septo vaginal transverso; Hemoperitoneo.

D) Endometriosis juvenil.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección?

A) Himeneotomía en cruz o en X *

B) Histerectomía.

C) Aspiración con aguja fina únicamente.

D) Dilatadores vaginales.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: AMENORREA PRIMARIA (SÍNDROME DE ROKITANSKY)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 539

Paciente de 16 años con amenorrea primaria. A la exploración física tiene un desarrollo mamario normal (Tanner IV), vello púbico normal, pero se observa una vagina corta (fondode saco) y ausencia de útero en el ultrasonido.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el cariotipo esperado?

A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser; 46, XX *

B) Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (Morris); 46, XY.

C) Síndrome de Turner; 45, X.

D) Hiperplasia suprarrenal congénita; 46, XX.

Pregunta 2

¿Qué malformación sistémica suele asociarse frecuentemente (hasta en el 40%) a esta patología?

A) Malformaciones renales (agenesia renal unilateral o riñón en herradura) *

B) Cardiopatía congénita.

C) Sordera neurosensorial.

D) Defectos del tubo neural.

Retroalimentación:

En el síndrome de Rokitansky hay fallo en el desarrollo de los conductos de Müller. Los ovarios son funcionales (por eso los caracteres sexuales son normales), pero el útero y los 2/3 superiores de la vagina están ausentes.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: SÍNDROME DE MORRIS (INSENSIBILIDAD A ANDRÓGENOS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 540

Paciente de 17 años con amenorrea primaria, fenotipo femenino muy armónico, pechos bien desarrollados pero con ausencia casi total de vello púbico y axilar. En la ingle se palpan dos masas pequeñas.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el cariotipo de esta paciente?

A) Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (Morris); 46, XY *

B) Síndrome de Rokitansky; 46, XX.

C) Disgenesia gonadal pura; 46, XX.

D) Síndrome de Klinefelter; 47, XXY.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo quirúrgico recomendado tras alcanzar la madurez ósea y por qué?

A) Gonadectomía bilateral; Debido al alto riesgo de malignización de los testículos intraabdominales (gonadoblastoma/seminoma) *

B) Histerectomía.

C) Orquidopexia (bajar los testículos al escroto).

D) No requiere cirugía.

Retroalimentación:

En el síndrome de Morris, hay testículos que producen testosterona, pero los receptores no responden. La testosterona se aromatiza a estrógenos (feminizando), pero el vello (dependiente de andrógenos) no aparece.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: TRABAJO DE PARTO (DISTOCIAS DINÁMICAS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 541

Paciente en fase activa de trabajo de parto (6 cm). Presenta contracciones uterinas con una frecuencia de 2 en 10 minutos, de intensidad débil (20 mmHg por catéter de presión interna) y duración de 25 segundos.

Pregunta 1

¿Cómo se denomina este patrón de actividad uterina y cuál es el manejo de elección?

A) Hiposistolia / Hipodinamia; Conducción del trabajo de parto con Oxitocina *

B) Polisistolia; Administrar tocolíticos.

C) Hipertonía; Cesárea inmediata.

D) Parto precipitado; Maniobra de Ritgen.

Pregunta 2

¿Cuál es la unidad de medida utilizada en el monitoreo interno para evaluar la suficiencia de las contracciones y qué valor se considera adecuado para progresar en el parto?

A) Unidades Montevideo; 200 - 250 UM *

B) Milímetros de mercurio; 50 mmHg.

C) Escala de Bishop; >8 puntos.

D) Unidades Apgar; 7-10.

Retroalimentación:

Las Unidades Montevideo se calculan multiplicando la frecuencia de las contracciones en 10 minutos por su intensidad (promedio). Si son menores a 200 UM, se considera actividad insuficiente para dilatar.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: TRABAJO DE PARTO (MONITOREO FETAL INTRA-PARTO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 542

Durante la conducción del trabajo de parto con oxitocina, se observa en el registro cardiotocográfico la presencia de desaceleraciones periódicas que inician después del pico de la contracción y regresan a la línea de base una vez terminada esta (Desaceleraciones tardías).

Pregunta 1

¿Qué indican estas desaceleraciones (DIP II) y cuál es la patología subyacente?

A) Insuficiencia útero-placentaria (Hipoxia fetal); Acidosis fetal potencial *

B) Compresión del cordón umbilical; Reflejo vagal.

C) Compresión de la cabeza fetal; Reflejo fisiológico.

D) Bienestar fetal; Reactividad normal.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inmediata ante la presencia de DIP II persistentes o recurrentes?

A) Suspender oxitocina, colocar a la madre en decúbito lateral izquierdo, administrar oxígeno y preparar para interrupción por la vía más rápida (Cesárea si no es inminente el parto) *

B) Aumentar la dosis de oxitocina para acelerar el parto.

C) Realizar tacto vaginal únicamente.

D) Indicar a la paciente que puje con más fuerza.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (SUPLEMENTACIÓN)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 543

Paciente de 6 semanas de gestación acude a su primera consulta prenatal. No tiene antecedentes de importancia.

Pregunta 1

¿Cuál es la dosis recomendada de Ácido Fólico para la prevención de defectos del tubo neural en la población general y en pacientes con antecedentes de hijos con estos defectos?

A) 400 mcg (0.4 mg) en población general; 4 mg (4000 mcg) en pacientes de alto riesgo *

B) 5 mg para todas.

C) 1 mg diario.

D) Solo se recomienda a través de la dieta.

Pregunta 2

¿En qué momento se recomienda iniciar la suplementación con hierro en el embarazo normal para prevenir la anemia ferropénica según la GPC?

A) A partir de la semana 20 de gestación (30-60 mg de hierro elemental) *

B) Desde el primer día de la concepción.

C) Solo si la hemoglobina es <9 g/dL.

D) En el puerperio únicamente.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (VACUNACIÓN)

Dificultad: Media

Caso Clínico 544

Paciente de 24 semanas de gestación acude para seguimiento. Su esquema de vacunación previo es desconocido.

Pregunta 1

¿Qué vacuna es obligatoria administrar entre las semanas 27 y 36 de gestación, independientemente del estado previo de vacunación, para proteger al neonato contra la tos ferina?

A) Tdpa (Tétanos, Difteria y Pertussis acelular) *

B) Triple viral (SRP).

C) Sabin.

D) Varicela.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes vacunas está ABSOLUTAMENTE contraindicada durante el embarazo por ser de virus vivos atenuados?

A) Triple Viral (Sarampión, Rubéola, Parotiditis) *

B) Influenza estacional.

C) Hepatitis B.

D) Toxoide tetánico.

Retroalimentación:

Las vacunas de virus vivos tienen el riesgo teórico de infectar al feto. La influenza y el tétanos son seguras y recomendadas.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EVALUACIÓN DE SALUD FETAL (MOVIMIENTOS FETALES)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 545

Paciente de 32 semanas acude preocupada porque siente que su bebé se mueve menos que de costumbre.

Pregunta 1

¿Cuál es el método de conteo de movimientos fetales (Prueba de Cardiff) que se considera normal para asegurar el bienestar fetal?

A) Al menos 10 movimientos en un periodo de 2 horas (o 3 movimientos en 1 hora) *

B) 1 movimiento cada 6 horas.

C) 50 movimientos al día.

D) No es un método confiable.

Pregunta 2

¿Cuál es el primer estudio diagnóstico a realizar ante la percepción materna de disminución de movimientos fetales?

A) Prueba sin estrés (NST) o Registro Cardiotocográfico *

B) Cesárea de urgencia.

C) Perfil biofísico completo de inicio.

D) Doppler de arterias uterinas.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (TAMIZAJE DE ESTREPTOCOCO GRUPO B)

Dificultad: Media

Caso Clínico 546

Paciente de 35 semanas de gestación. Se discute la necesidad de realizar tamizaje para Estreptococo del grupo B (S. agalactiae).

Pregunta 1

¿En qué semanas se debe realizar el cultivo rectovaginal para detectar la colonización por EGB según las recomendaciones internacionales?

A) Entre las semanas 35 y 37 *

B) En el primer trimestre.

C) Solo si la paciente tiene fiebre.

D) Durante el trabajo de parto únicamente.

Pregunta 2

¿Cuál es la profilaxis intraparto de elección para una paciente con cultivo positivo para EGB para prevenir la sepsis neonatal temprana?

A) Penicilina G cristalina (o Ampicilina) IV al iniciar el trabajo de parto *

B) Ceftriaxona dosis única.

C) Gentamicina.

D) Tratamiento oral con Amoxicilina una semana antes del parto.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: OBSTETRICIA SOCIAL (VIOLENCIA OBSTÉTRICA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 547

Durante la atención de un parto, el médico decide realizar una episiotomía de rutina a una paciente primigesta sin indicación médica clara, no solicita su consentimiento y le indica que "debe aguantar el dolor sin quejarse por el bien de su hijo".

Pregunta 1

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿cómo se tipifican estas conductas?

A) Violencia Obstétrica *

B) Mala praxis quirúrgica únicamente.

C) Procedimiento médico estándar.

D) Negligencia administrativa.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes prácticas se considera actualmente una recomendación de la OMS para un "parto humanizado"?

A) Permitir el acompañamiento por una persona de elección de la mujer y libre posición durante el trabajo de parto *

B) Realizar enema y rasurado púbico de rutina.

C) Mantener a la paciente en ayuno estricto durante todo el proceso.

D) Realizar tactos vaginales cada hora.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ANTICONCEPCIÓN POST-EVENTO OBSTÉTRICO (APEO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 548

Paciente que acaba de tener su parto desea un método anticonceptivo de larga duración que no interfiera con la lactancia materna antes de irse a casa.

Pregunta 1

¿Cuál es el momento ideal para la colocación del DIU post-parto según la GPC?

A) Dentro de los primeros 10 a 30 minutos tras la expulsión de la placenta (DIU post-placenta) *

B) A las 6 semanas posparto.

C) Durante la siguiente menstruación.

) Solo si el parto fue por cesárea.

Pregunta 2

¿Qué método anticonceptivo hormonal está CONTRAINDICADO en las primeras 3 semanas de lactancia debido al riesgo de tromboembolismo y posible disminución de la producción de leche?

A) Anticonceptivos combinados (Estrógenos + Progestina) *

B) Implante subdérmico de progestina.

C) Inyección de solo progestina.

D) DIU de levonorgestrel.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (ALTURA UTERINA)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 549

Se evalúa a una paciente de 28 semanas. Se mide la altura del fondo uterino.

Pregunta 1

¿Cuál es la regla de McDonald para calcular la edad gestacional a partir de la altura uterina en cm?

A) (Altura uterina en cm x 8) / 7 *

B) Altura uterina + 4.

C) Altura uterina x 2.

D) No existe correlación después de la semana 20.

Pregunta 2

¿A qué nivel anatómico se espera encontrar el fondo uterino a las 20 semanas de gestación?

A) A nivel de la cicatriz umbilical *

B) A nivel de la sínfisis del pubis.

C) En el borde costal.

D) En el hueco pélvico.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (GANANCIA DE PESO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 550

Paciente con un IMC pregestacional de 22 kg/m^2 (normal) inicia su control prenatal.

Pregunta 1

¿Cuál es el rango de ganancia de peso total recomendado durante todo el embarazo para esta paciente?

A) 11.5 a 16 kg *

B) 5 a 9 kg.

C) 7 a 11.5 kg.

D) Más de 20 kg.

Pregunta 2

¿Cuál es la recomendación de ganancia de peso para una paciente que inicia el embarazo con Obesidad (IMC >30)?

A) 5 a 9 kg *

B) 11.5 a 16 kg.

C) No debe ganar peso.

D) 15 a 20 kg.

Retroalimentación:

El control del peso previene complicaciones como diabetes gestacional, preeclampsia y macrosomía fetal.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (CRITERIOS DE REFERENCIA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 551

Paciente de 19 años, primigesta, con 24 semanas de gestación. En la consulta de primer nivel se detecta por primera vez una cifra tensional de 145/95 mmHg y presencia de edema en extremidades.

Pregunta 1

De acuerdo con la GPC, ¿cuál es la conducta a seguir ante el hallazgo de hipertensión en una paciente previamente normotensa después de la semana 20?

A) Envío inmediato a segundo nivel de atención para valoración por obstetricia *

B) Citar en una semana para revaloración.

C) Iniciar Alfametildopa y mantener en primer nivel.

D) Solicitar laboratorios y esperar resultados antes de referir.

Pregunta 2

¿Cuál de los siguientes antecedentes se considera un factor de riesgo para enviar a una paciente a consulta de medicina materno-fetal de forma temprana?

A) Antecedente de preeclampsia en embarazo previo, nefropatía o enfermedad autoinmune *

B) Edad materna de 25 años.

C) Un solo aborto previo de primer trimestre.

D) Talla materna de 1.60 m.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: EVALUACIÓN DE SALUD FETAL (DOPPLER FETAL)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 552

Paciente de 34 semanas con diagnóstico de Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU) tipo 1. Se realiza Doppler de arteria umbilical.

Pregunta 1

¿Qué hallazgo en el Doppler de la arteria umbilical indica un deterioro inminente del bienestar fetal y riesgo de muerte intrauterina?

A) Flujo ausente o reverso al final de la diástole *

B) Aumento de la velocidad sistólica máxima.

C) Presencia de incisura protodiastólica (Notch).

D) Índice de pulsatilidad dentro de percentiles normales.

Pregunta 2

¿Ante qué hallazgo en el Doppler de la Arteria Cerebral Media se sospecha el fenómeno de "centralización del flujo" o ahorro de oxígeno para el cerebro fetal?

A) Vasodilatación (Disminución del índice de resistencia / pulsatilidad) *

B) Vasoconstricción extrema.

C) Ausencia de flujo sistólico.

D) Flujo retrógrado.

Retroalimentación:

El Doppler umbilical evalúa la placenta; el Doppler cerebral evalúa la respuesta fetal a la hipoxia. La vasodilatación cerebral es un mecanismo compensatorio.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (INFECCIÓN URINARIA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 553

Paciente de 12 semanas, asintomática. En su primer examen general de orina se reporta la presencia de bacterias abundantes. Se solicita urocultivo que confirma >100,000 UFC de E. coli.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el esquema de tratamiento de primera elección según la GPC?

A) Bacteriuria asintomática; Nitrofurantoína o Amoxicilina por 7 días *

B) Cistitis aguda; Fosfomicina dosis única.

C) No requiere tratamiento por ser asintomática.

D) Pielonefritis; Ceftriaxona IV.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación más grave de una bacteriuria asintomática no tratada en el embarazo?

A) Pielonefritis aguda y riesgo de parto pretérmino *

B) Diabetes gestacional.

C) Malformaciones fetales.

D) Placenta previa.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (ULTRASONIDO)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 554

Paciente de 11 semanas de gestación acude para su ultrasonido de primer trimestre.

Pregunta 1

¿Cuál es el objetivo principal del ultrasonido realizado entre las semanas 11 y 13.6?

A) Determinar edad gestacional (LCN), vitalidad y realizar tamizaje de aneuploidías (Trasnslucencia nucal) *

B) Evaluar el peso fetal estimado.

C) Realizar el perfil biofísico.

D) Ver el sexo fetal.

Pregunta 2

¿Cuál es la medida ecográfica más precisa para datar la edad gestacional en el primer trimestre?

A) Longitud Céfalo-Caudal (LCN o CRL) *

B) Diámetro biparietal.

C) Longitud del fémur.

D) Saco gestacional únicamente.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: OBSTETRICIA SOCIAL (MUERTE MATERNA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 555

Se realiza un análisis de las estadísticas de mortalidad materna en una región de México.

Pregunta 1

¿Cuál es la principal causa de muerte materna directa a nivel mundial y nacional?

A) Hemorragia obstétrica *

B) Preeclampsia/Eclampsia.

C) Sepsis.

D) Aborto inseguro.

Pregunta 2

¿Cómo se define la "Razón de Mortalidad Materna"?

A) Número de muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos *

B) Porcentaje de muertes de mujeres de 15 a 49 años.

C) Número de muertes por cada 1,000 embarazos.

D) Muertes ocurridas solo durante el parto.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: ANTICONCEPCIÓN (SALPINGOCLASIA)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 556

Paciente de 38 años con paridad satisfecha (4 hijos) solicita un método definitivo durante su próxima cesárea.

Pregunta 1

¿Cuál es el nombre técnico de la esterilización tubaria permanente y cuál es el requisito legal indispensable en México?

A) Oclusión Tubaria Bilateral (OTB); Consentimiento informado firmado *

B) Histerectomía; Carta de recomendación.

C) Salpingectomía; Aprobación del esposo.

D) Vasectomía; Evaluación psiquiátrica.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PUERPERIO (INFECCIÓN - ENDOMETRITIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 557

Paciente de 3er día de puerperio tras cesárea por ruptura prolongada de membranas. Presenta fiebre de 39°C, dolor a la palpación uterina y loquios fétidos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el tratamiento antibiótico de elección (estándar de oro)?

A) Endometritis puerperal; Clindamicina + Gentamicina IV *

B) Infección de herida quirúrgica; Dicloxacilina.

C) Mastitis; Amoxicilina.

D) Infección urinaria; Ciprofloxacino.

Pregunta 2

¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar endometritis puerperal?

A) La vía de nacimiento por cesárea *

B) El parto vaginal eutócico.

C) La lactancia materna.

D) El uso de anestesia local.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PUERPERIO (MASTITIS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 558

Paciente lactante de 2 semanas post-parto presenta fiebre, malestar general y dolor en cuadrante superior externo de la mama izquierda. A la exploración se observa zona eritematosa, endurecida y dolorosa.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más frecuente y cuál es la recomendación sobre la lactancia?

A) Staphylococcus aureus; Continuar con la lactancia (vaciamiento de la mama) y dar antibiótico *

B) Streptococcus pyogenes; Suspender lactancia de inmediato.

C) Candida albicans; Dar antimicóticos tópicos.

D) E. coli; Usar extractor de leche y desecharla.

Pregunta 2

¿Cuál es el antibiótico de primera elección para la mastitis puerperal?

A) Dicloxacilina o Cefalexina *

B) Metronidazol.

C) Ceftriaxona.

D) Penicilina G.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PUERPERIO (COMPLICACIONES PSIQUIÁTRICAS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 559

Paciente de 10 días post-parto. Refiere llanto fácil, irritabilidad, falta de apetito y sentimientos de incapacidad para cuidar a su bebé. No tiene ideación suicida ni delirios.

Pregunta 1

¿Cuál es la diferencia diagnóstica entre "Depresión Posparto" y "Tristeza Posparto" (Baby Blues)?

A) La tristeza posparto es transitoria (dura <2 semanas) y no interfiere con el cuidado del bebé; la depresión es persistente y requiere tratamiento *

B) No hay diferencia, son lo mismo.

C) La depresión solo ocurre si hay psicosis.

D) La tristeza posparto requiere internamiento.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para la Depresión Posparto moderada-severa?

A) Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina (ISRS) como Sertralina y psicoterapia *

B) Benzodiacepinas.

C) Antipsicóticos.

D) Reposo absoluto.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PUERPERIO (FISIOLOGÍA)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 560

Paciente en puerperio fisiológico pregunta sobre los cambios normales que experimentará.

Pregunta 1

¿Cómo se denomina a la secreción vaginal hemática y serosa que ocurre tras el parto y cuánto tiempo suelen durar aproximadamente?

A) Loquios; Hasta 4 a 6 semanas *

B) Menstruación post-parto; 5 días.

C) Entuertos; 24 horas.

D) Hidrorrea; 1 año.

Pregunta 2

¿Cómo se llaman las contracciones uterinas dolorosas que ocurren en los primeros días del puerperio para favorecer la involución uterina y que aumentan con la lactancia?

A) Entuertos *

B) Contracciones de Braxton-Hicks.

C) Alumbramiento.

D) Pujos.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (TAMIZAJE DE SÍFILIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 561

Paciente de 10 semanas acude a su primera cita. Se solicitan pruebas de tamizaje. El reporte de VDRL resulta reactivo (1:16). La paciente niega lesiones genitales actuales.

Pregunta 1

¿Cuál es el siguiente paso para confirmar el diagnóstico de Sífilis en el embarazo?

A) Realizar una prueba treponémica específica (FTA-ABS o TP-PA) *

B) Iniciar tratamiento con Penicilina de inmediato sin más pruebas.

C) Repetir el VDRL en un mes.

D) Solicitar ultrasonido estructural.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para la sífilis gestacional y qué reacción febril aguda debe vigilarse tras la primera dosis?

A) Penicilina G Benzatínica; Reacción de Jarisch-Herxheimer *

B) Doxiciclina; Reacción de Stevens-Johnson.

C) Ceftriaxona; Choque anafiláctico.

D) Eritromicina; Náuseas severas.

Retroalimentación:

El VDRL puede dar falsos positivos en el embarazo. La confirmación con pruebas treponémicas es vital. La reacción de Jarisch-Herxheimer ocurre por la liberación de toxinas al morir las espiroquetas y puede desencadenar contracciones o distrés fetal.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (VIH EN EL EMBARAZO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 562

Paciente con 12 semanas de gestación con prueba rápida para VIH positiva, confirmada por carga viral elevada.

Pregunta 1

¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento antirretroviral (TARAA) en la paciente embarazada?

A) Lograr una carga viral indetectable para reducir el riesgo de transmisión vertical al <1% *

B) Curar la enfermedad en la madre.

C) Evitar malformaciones congénitas.

D) Mejorar el conteo de plaquetas.

Pregunta 2

¿En qué escenario se permite el parto vaginal en una paciente con VIH según las guías internacionales y la GPC?

A) Carga viral <1,000 copias/ml cerca del momento del parto y uso de TARAA *

B) En ningún caso, siempre debe ser cesárea.

C) Solo si la paciente tiene un conteo de CD4 >500.

D) Si el bebé es pequeño para la edad gestacional.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (INFECCIÓN POR TORCH - TOXOPLASMOSIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 563

Paciente de 14 semanas con reporte de IgG positivo y IgM positivo para Toxoplasma gondii. Se realiza prueba de avidez de IgG, la cual resulta "Alta".

Pregunta 1

¿Cómo se interpreta una avidez de IgG ALTA en el primer trimestre?

A) Indica una infección antigua (ocurrida hace más de 4 meses), por lo que el riesgo de afectación fetal actual es mínimo *

B) Indica una infección reciente aguda.

C) Indica que la paciente requiere tratamiento con Espiramicina de por vida.

D) Es un falso positivo.

Pregunta 2

¿Cuál es la tríada clásica de la toxoplasmosis congénita (Tríada de Sabin)?

A) Coriorretinitis, Hidrocefalia y Calcificaciones intracraneales *

B) Microcefalia, Cardiopatía y Sordera.

C) Cataratas, Hepatoesplenomegalia y Exantema.

D) Anemia, Ictericia y Edema.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: CONTROL PRENATAL (RESUMEN DE CONSULTAS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 564

Un pasante de medicina revisa la norma oficial mexicana sobre la atención de la mujer durante el embarazo.

Pregunta 1

¿Cuál es el número mínimo de consultas de control prenatal que establece la NOM-007 para un embarazo de bajo riesgo?

A) Mínimo 5 consultas *

B) Mínimo 8 consultas.

C) Una consulta cada mes.

D) Solo 3 consultas (una por trimestre).

Pregunta 2

¿Cuál es la recomendación de la OMS (y GPC) para un control prenatal óptimo?

A) 8 consultas *

B) 12 consultas.

C) 5 consultas.

D) 10 consultas.

Retroalimentación:

La NOM establece un mínimo legal de 5, pero la evidencia clínica actual sugiere que 8 consultas reducen significativamente la mortalidad perinatal.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: EXANTEMÁTICAS (SÍNDROME DE CHOQUE TÓXICO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 585

Niño de 7 años con antecedente de varicela hace 5 días. Presenta súbitamente fiebre elevada, dolor intenso en pierna derecha, eritema difuso tipo "quemadura solar" y datos de choque (hipotensión, llenado capilar 4 seg). Se observa una zona de la pierna con flictenas y coloración violácea.

Pregunta 1

¿Cuál es la complicación grave de la piel asociada a varicela y estreptococo que debe sospecharse ante el dolor desproporcionado?

A) Fascitis necrotizante. *

B) Impétigo contagioso.

C) Erisipela simple.

D) Molusco contagioso.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inmediato de elección para la fascitis necrotizante?

A) Desbridamiento quirúrgico urgente + Antibióticos de amplio espectro (Clindamicina + Penicilina). *

B) Solo pomadas antibióticas.

C) Aciclovir IV.

D) Compresas frías y observación.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: EXANTEMÁTICAS (SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 586

Lactante de 14 meses con fiebre y eritrodermia dolorosa. Al tacto ligero, la piel se desprende fácilmente dejando una base húmeda y roja (Signo de Nikolsky positivo). No presenta afectación de mucosas.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y la toxina responsable de este cuadro?

A) Staphylococcus aureus; Toxina exfoliativa (epidermolisina). *

B) Streptococcus pyogenes; Toxina eritrogénica.

C) Virus del Herpes Simple; Citotoxina.

D) Reacción a fármacos (Sulfas).

Retroalimentación:

A diferencia del Stevens-Johnson, el Síndrome de Piel Escaldada Estafilocócica (Enfermedad de Ritter) NO suele afectar mucosas y la división de la piel es muy superficial (estrato granuloso).

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (LARINGOTRAQUEITIS / CRUP)

Dificultad: Media

Caso Clínico 587

Lactante de 2 años presenta cuadro de 48 horas de evolución con rinorrea y febrícula. Inicia súbitamente por la noche con tos "perruna" (estridor inspiratorio), disfonía y dificultad respiratoria leve.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más frecuente y qué hallazgo radiológico se espera en la placa de cuello?

A) Virus Parainfluenza tipo 1; Signo de la "punta de lápiz" o "torre de iglesia". *

B) Virus Sincitial Respiratorio; Atrapamiento aéreo.

C) Haemophilus influenzae; Signo del pulgar.

D) Bordetella pertussis; Infiltrados hiliares.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para disminuir el edema laríngeo de forma rápida según la GPC?

A) Dexametasona (0.6 mg/kg) dosis única + L-epinefrina nebulizada si hay estridor de reposo. *

B) Antibióticos orales (Amoxicilina).

C) Salbutamol nebulizado.

D) Jarabes para la tos.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (EPIGLOTITIS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 588

Niño de 4 años acude a urgencias en estado tóxico, fiebre alta, posición de "trípode", babeo constante (sialorrea) y ausencia de tos. El niño se observa muy ansioso y evita hablar.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué maniobra está ABSOLUTAMENTE contraindicada?

A) Epiglotitis; Intentar visualizar la faringe con abatelenguas (riesgo de espasmo laríngeo total). *

B) Crup viral; Nebulizar con solución salina.

C) Aspiración de cuerpo extraño; Maniobra de Heimlich.

D) Absceso retrofaríngeo; Punción diagnóstica.

Pregunta 2

¿Cuál es el agente causal principal en niños no vacunados y cuál es el signo radiológico clásico?

A) Haemophilus influenzae tipo b; Signo del "pulgar" (epiglotis edematizada). *

B) Neumococo; Bronquio de seguridad.

C) Klebsiella; Absceso.

D) Micoplasma; Infiltrado intersticial.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (BRONQUIOLITIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 589

Lactante de 4 meses acude por primer episodio de sibilancias, precedido de síntomas catarrales, con retracción xifoidea y taquipnea. Es invierno y su hermano mayor tiene gripe.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico clínico y el agente etiológico más común?

A) Bronquiolitis; Virus Sincitial Respiratorio (VSR). *

B) Asma bronquial; Alérgenos.

C) Neumonía; Streptococcus pneumoniae.

D) Tos ferina; Bordetella.

Pregunta 2

¿Cuál es el pilar del tratamiento según la GPC (y la evidencia actual) para un caso de bronquiolitis no grave?

A) Medidas de soporte (Aseo nasal, hidratación y vigilancia). *

B) Salbutamol y esteroides sistémicos.

C) Antibióticos profilácticos.

D) Fisioterapia pulmonar agresiva.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEONATOLOGÍA (REANIMACIÓN NEONATAL)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 590

Nace recién nacido de término. Al recibirlo se observa que no respira ni llora, y tiene pobre tono muscular.

Pregunta 1

Tras realizar los pasos iniciales (calentar, posicionar, aspirar si es necesario, secar y estimular) por 30 segundos, el bebé persiste con FC de 80 lpm. ¿Cuál es el siguiente paso?

A) Iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP). *

B) Iniciar compresiones cardiacas.

C) Administrar adrenalina.

D) Solo observar 30 segundos más.

Pregunta 2

¿En qué momento de la reanimación neonatal se deben iniciar las compresiones cardiacas?

A) Si después de 30 segundos de VPP efectiva la FC es < 60 lpm. *

B) Siempre que la FC sea < 100 lpm.

C) Inmediatamente al nacer si no llora.

D) Solo si el pH del cordón es < 7.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEONATOLOGÍA (TEST DE APGAR Y SILVERMAN-ANDERSON)

Dificultad: Media

Caso Clínico 591

Se evalúa a un neonato al minuto de vida. Presenta: cuerpo rosado con extremidades azules, FC de 110 lpm, gesticula ante la sonda, realiza movimientos activos de extremidades y tiene llanto vigoroso.

Pregunta 1

¿Cuál es el puntaje de APGAR para este paciente?

A) 9. *

B) 7.

C) 10.

D) 8.

Pregunta 2

Al evaluar el Test de Silverman-Anderson, se observa: aleteo nasal leve, quejido audible con estetoscopio y tiraje intercostal leve. ¿Qué indica un puntaje alto en esta escala?

A) Mayor dificultad respiratoria (a diferencia de APGAR, aquí más puntos es peor). *

B) Excelente adaptación pulmonar.

C) Pronóstico neurológico favorable.

D) Madurez gestacional.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEONATOLOGÍA (TAMIZ NEONATAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 592

Paciente de 4 días de vida es llevado para toma de tamiz metabólico neonatal.

Pregunta 1

¿Cuál es el periodo ideal para la toma de la muestra según la norma oficial mexicana?

A) Entre el 3er y 5to día de vida. *

B) En las primeras 2 horas.

C) Al mes de nacido.

D) Solo si presenta síntomas de ictericia.

Pregunta 2

¿Cuál es la patología que se busca detectar con mayor prioridad debido a que el tratamiento temprano evita el retraso mental severo?

A) Hipotiroidismo Congénito. *

B) Fibrosis Quística.

C) Fenilcetonuria.

D) Hiperplasia Suprarrenal Congénita.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEONATOLOGÍA (ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 593

Recién nacido de 30 semanas de gestación. Presenta dificultad respiratoria progresiva inmediata al nacer, con quejido y cianosis. La radiografía de tórax muestra imagen de "vidrio despulido" y bronquograma aéreo.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa fisiopatológica y cuál es el tratamiento definitivo inicial?

A) Deficiencia de surfactante; Administración de surfactante endotraqueal. *

B) Exceso de líquido pulmonar; Oxígeno en casco cefálico.

C) Aspiración de meconio; Antibióticos.

D) Hernia diafragmática; Cirugía.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEONATOLOGÍA (TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RN)

Dificultad: Media

Caso Clínico 594

Recién nacido de término, nacido por cesárea sin trabajo de parto. Inicia con taquipnea (FR 80 lpm) poco después del nacimiento. La radiografía muestra marcas vasculares prominentes, líquido en las cisuras y atrapamiento aéreo.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la evolución esperada?

A) Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN); Resolución espontánea en 24-72 horas. *

B) Membrana hialina; Requiere ventilación mecánica por semanas.

C) Sepsis neonatal; Requiere 10 días de antibiótico.

D) Persistencia del conducto arterioso.

Retroalimentación:

La TTRN ("Pulmón húmedo") se debe a la reabsorción retardada del líquido alveolar, muy común en cesáreas sin trabajo de parto previo.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEONATOLOGÍA (SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE MECONIO - SAM)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 615

Recién nacido de 42 semanas de gestación (postérmino) con antecedente de líquido amniótico teñido de meconio espeso. Al nacer presenta dificultad respiratoria grave, cianosis y tórax abombado. La radiografía muestra infiltrados algodonosos difusos, zonas de atelectasia y áreas de hiperinsuflación.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal del SAM y qué complicación hemodinámica es muy frecuente en estos pacientes?

A) Obstrucción de vías aéreas finas (efecto válvula) y neumonitis química; Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido. *

B) Deficiencia de surfactante; Conducto arterioso persistente.

C) Edema alveolar por falla cardiaca; Estenosis pulmonar.

D) Infección bacteriana ascendente; Hipotensión sistémica.

Pregunta 2

Según las guías actuales de reanimación neonatal (NRP), ¿cuál es la conducta ante un recién nacido no vigoroso con antecedente de líquido meconial?

A) Iniciar pasos iniciales de reanimación (calentar, posicionar, aspirar boca/nariz si hay obstrucción) y dar VPP si no respira. *

B) Intubación endotraqueal inmediata para succión traqueal antes de cualquier otra maniobra.

C) Realizar lavado gástrico de urgencia.

D) Administrar surfactante profiláctico en la sala de partos.

Retroalimentación:

Anteriormente se recomendaba la intubación de rutina para aspirar meconio en niños "no vigorosos", pero la evidencia actual (NRP 7ma y 8va ed) indica que esto no mejora el pronóstico y puede retrasar la ventilación. El SAM causa un atrapamiento de aire que puede llevar a neumotórax.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: CIRUGÍA PEDIÁTRICA (ONFALOCELE VS GASTROSQUISIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 616

Se asiste el parto de un recién nacido de término. Se observa un defecto en la pared abdominal de 4 cm, localizado a la derecha del cordón umbilical, con salida de asas intestinales que no están cubiertas por ninguna membrana.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la asociación con otras malformaciones?

A) Gastrosquisis; Raramente se asocia a malformaciones fuera del tracto GI (como atresias intestinales). *

B) Onfalocele; Alta asociación con malformaciones cardiacas y síndromes cromosómicos.

C) Hernia umbilical; Sin asociaciones.

D) Pentalogía de Cantrell; Defecto toracoabdominal.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial de las asas intestinales expuestas en la sala de partos?

A) Cubrirlas con apósitos estériles humedecidos con solución salina tibia y envolver con plástico (bolsa de Bogotá o silo). *

B) Intentar la reducción manual inmediata bajo presión.

C) Aplicar antibióticos tópicos y dejar al aire.

D) Colocar vaselina estéril y faja compresiva.

Retroalimentación:

Diferencia clave ENARM: El Onfalocele es un defecto en la línea media (a través del anillo umbilical), cubierto por peritoneo y amnios, y se asocia mucho a trisomías. La Gastrosquisis es paraumbilical derecha, las asas están "nudas" (irritadas por el líquido amniótico) y suele ser un evento aislado.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: CIRUGÍA PEDIÁTRICA (HERNIA INGUINAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 617

Lactante masculino de 2 meses que presenta aumento de volumen en la región inguinal derecha que llega hasta el escroto, el cual se hace más evidente cuando el niño llora y desaparece durante el sueño.

Pregunta 1

¿Cuál es el origen embriológico de la hernia inguinal en pediatría y cuál es la conducta recomendada?

A) Persistencia del conducto peritoneovaginal; Cirugía (hernioplastia) programada a la brevedad tras el diagnóstico. *

B) Debilidad de la fascia transversalis; Ejercicio y observación hasta los 2 años.

C) Cierre incompleto del anillo umbilical; Uso de bragueros.

D) Infección del conducto deferente; Antibióticos.

Retroalimentación:

A diferencia de los adultos (hernias directas por debilidad de pared), en niños casi todas son INDIRECTAS por falla en la obliteración del conducto peritoneovaginal. No se espera a que cierren solas; el riesgo de encarcelamiento es alto, especialmente en lactantes.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (MENINGITIS BACTERIANA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 618

Niño de 2 años con fiebre, irritabilidad, vómito y abombamiento de la fontanela. Se realiza punción lumbar que reporta: 1,500 leucocitos/mm^3 con 90% de PMN, glucosa de 20 mg/dL (hipoglucorraquia) y proteínas de 150 mg/dL.

Pregunta 1

¿Cuál es la interpretación del líquido cefalorraquídeo (LCR) y cuáles son los agentes más comunes en este grupo de edad (niños vacunados)?

A) Meningitis bacteriana aguda; Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. *

B) Meningitis viral; Enterovirus.

C) Meningitis tuberculosa; Mycobacterium.

D) Reacción meníngea por otitis; Sin bacterias.

Pregunta 2

¿Qué fármaco se recomienda administrar 20 minutos antes o junto con la primera dosis de antibiótico para disminuir el riesgo de secuelas auditivas (hipoacusia)?

A) Dexametasona. *

B) Manitol.

C) Fenitoína.

D) Aciclovir.

Retroalimentación:

El LCR bacteriano típico tiene: pleocitosis neutrofílica, glucosa baja (<40 mg/dL o <50% de la sérica) y proteínas elevadas. La dexametasona es crucial para reducir la inflamación y prevenir la sordera, especialmente en infecciones por H. influenzae o Neumococo.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (ARTRITIS SÉPTICA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 619

Escolar de 5 años presenta dolor agudo en cadera derecha, claudicación (cojera) y fiebre de 38.5°C. A la exploración, la cadera se encuentra en flexión y rotación externa, con dolor intenso a la movilización pasiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más común y cuál es el estudio diagnóstico inicial de elección?

A) Staphylococcus aureus; Ultrasonido de cadera (para detectar derrame articular). *

B) Kingella kingae; Radiografía simple únicamente.

C) Streptococcus pyogenes; Tomografía computarizada.

D) Borrelia burgdorferi; Prueba de Elisa.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo definitivo de una artritis séptica confirmada?

A) Drenaje quirúrgico urgente (artrotomía) + Antibióticos IV. *

B) Reposo y antiinflamatorios (AINEs).

C) Solo antibióticos orales por 7 días.

D) Inmovilización con yeso pelvipedio.

Retroalimentación:

La artritis séptica es una URGENCIA quirúrgica porque el aumento de presión intraarticular y las enzimas bacterianas pueden destruir el cartílago y causar necrosis avascular de la cabeza femoral en pocas horas.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (OSTEOMIELITIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 620

Niño de 8 años con dolor óseo localizado en la metáfisis distal del fémur, fiebre y aumento de volumen local. Refiere antecedente de herida cutánea infectada hace 10 días.

Pregunta 1

¿Cuál es la vía de infección más frecuente en la osteomielitis pediátrica y cuál es el estudio de imagen más sensible en las primeras 48-72 horas?

A) Hematógena; Resonancia Magnética. *

B) Inoculación directa; Radiografía simple.

C) Contigüidad; Gammagrama óseo.

D) Traumática; Ultrasonido Doppler.

Retroalimentación:

La radiografía inicial suele ser normal en los primeros 10-14 días de la osteomielitis (solo muestra edema de partes blandas). La RM es el estudio más sensible para detectar edema óseo temprano. El fémur y la tibia son los huesos más afectados.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (TOS FERINA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 621

Lactante de 4 meses con cuadro de accesos de tos paroxística, intensa, que termina con un "gallo" inspiratorio y cianosis peribucal. Presenta linfocitosis absoluta en la biometría hemática.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y cuál es el tratamiento de elección para el paciente y sus contactos?

A) Bordetella pertussis; Macrólidos (Azitromicina o Claritromicina). *

B) Mycoplasma pneumoniae; Amoxicilina.

C) Virus Sincitial Respiratorio; Ribavirina.

) Corynebacterium diphtheriae; Penicilina.

Retroalimentación:

La tos ferina tiene 3 fases: catarral, paroxística (la de los accesos) y de convalecencia. La linfocitosis es un dato muy sugerente. El tratamiento con macrólidos es más efectivo si se inicia en la fase catarral, pero se da en cualquier etapa para limitar el contagio.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (HELMINTIASIS - ENTEROBIASIS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 622

Niña de 4 años presenta prurito anal intenso de predominio nocturno y falta de sueño. La madre refiere haber visto "pequeños hilos blancos" moviéndose en la región perianal.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y cuál es el método diagnóstico de elección?

A) Enterobius vermicularis (Oxiuros); Prueba de Graham (cinta adhesiva en región perianal). *

B) Ascaris lumbricoides; Coproparasitoscópico de 3 muestras.

C) Giardia lamblia; Prueba de antígeno en heces.

D) Taenia solium; Observación de proglótides.

Retroalimentación:

Los oxiuros no suelen verse en los copro estándar porque la hembra deposita los huevos en la región perianal durante la noche. El tratamiento es Albendazol o Mebendazol, dosis única y repetir en 2 semanas, tratando a TODA la familia.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEFROPEDIATRÍA (SÍNDROME NEFRÍTICO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 623

Niño de 7 años presenta hematuria (orina color "refresco de cola"), edema palpebral y pretibial, e hipertensión arterial (130/90 mmHg). La madre refiere que el niño tuvo una infección faríngea hace 2 semanas que no recibió tratamiento completo.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué hallazgo en el perfil de complementos apoya esta sospecha?

A) Glomerulonefritis post-estreptocócica; Disminución de C3 con C4 normal. *

B) Síndrome de Alport; Niveles de complemento normales.

C) Nefropatía por IgA (Berger); Complemento normal.

D) Lupus eritematoso sistémico; Disminución de C3 y C4.

Pregunta 2

¿Cuál es el marcador serológico más útil para confirmar el antecedente de infección por Estreptococo del grupo A en este caso?

A) Antiestreptolisinas (ASLO). *

B) Anticuerpos antinucleares (ANA).

C) Factor reumatoide.

D) Cultivo faríngeo actual.

Retroalimentación:

La glomerulonefritis post-estreptocócica es el prototipo del síndrome nefrítico pediátrico. Se presenta tras un periodo de latencia (1-3 semanas post-faringitis o 3-6 semanas post-impétigo). El descenso selectivo de C3 es clave para el diagnóstico diferencial.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEFROPEDIATRÍA (SÍNDROME NEFRÓTICO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 624

Niño de 4 años acude por edema generalizado (anasarca) que inició en párpados y progresó a extremidades y escroto. Los laboratorios reportan: proteinuria de 24 horas >40 mg/m^2/h, albúmina sérica de 2.0 g/dL y colesterol total de 300 mg/dL.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico idiopático en la infancia y cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Enfermedad de cambios mínimos; Esteroides (Prednisona). *

B) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria; Ciclofosfamida.

C) Nefropatía membranosa; IECA únicamente.

D) Glomerulonefritis membranoproliferativa; Plasmaféresis.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación infecciosa más grave y característica en niños con síndrome nefrótico descompensado?

A) Peritonitis primaria (espontánea) por Streptococcus pneumoniae. *

B) Infección de vías urinarias por E. coli.

C) Celulitis por Staphylococcus aureus.

D) Meningitis viral.

Retroalimentación:

El síndrome nefrótico se define por la tríada: proteinuria masiva, hipoalbuminemia y edema. En pediatría, el 90% responde a esteroides (corticoproteicos), por lo que no se realiza biopsia renal de inicio a menos que haya datos atípicos (edad <1 año o >10 años, hematuria macroscópica o falla renal).

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: HEMATOPEDIATRÍA (LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA - LLA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 625

Niño de 5 años presenta palidez progresiva, astenia, fiebre persistente y aparición de petequias en extremidades. A la exploración se palpa hepatosplenomegalia y adenomegalias cervicales múltiples. La biometría muestra: Hb 7 g/dL, Leucocitos 45,000/mm^3 y Plaquetas 20,000/mm^3.

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente en la edad pediátrica y cuál es el estudio definitivo para el diagnóstico?

A) Leucemia Linfoblástica Aguda; Aspirado de médula ósea (presencia de >20-25% de blastos). *

B) Linfoma de Hodgkin; Biopsia de ganglio.

C) Neuroblastoma; Catecolaminas en orina.

D) Tumor de Wilms; Ultrasonido renal.

Pregunta 2

¿Cuál es el sitio anatómico considerado "santuario" donde las células leucémicas pueden persistir a pesar del tratamiento sistémico?

A) Sistema Nervioso Central y Testículos. *

B) Hígado y Bazo.

C) Médula espinal.

D) Pulmones.

Retroalimentación:

La LLA tiene su pico de incidencia entre los 2 y 5 años. Los síntomas derivan de la infiltración de la médula (falla medular: anemia, trombocitopenia, neutropenia) y la infiltración extramedular (organomegalia).

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: HEMATOPEDIATRÍA (PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN)

Dificultad: Media

Caso Clínico 626

Escolar de 6 años presenta exantema purpúrico palpable, simétrico, localizado en glúteos y extremidades inferiores. Se acompaña de dolor abdominal tipo cólico y artralgias en rodillas. El recuento de plaquetas es normal.

Pregunta 1

¿Cuál es la fisiopatología de esta vasculitis y cuál es el órgano cuya afectación determina el pronóstico a largo plazo?

A) Vasculitis por depósito de IgA; Riñón. *

B) Deficiencia de factor VIII; Hígado.

C) Anticuerpos anti-plaquetarios; Médula ósea.

D) Infección bacteriana directa; Piel.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación gastrointestinal aguda más importante asociada a esta púrpura?

A) Invaginación (intususcepción) intestinal. *

B) Apendicitis aguda.

C) Vólvulo gástrico.

D) Diverticulitis.

Retroalimentación:

La Púrpura de Henoch-Schönlein es la vasculitis más común en niños. A diferencia de la PTI, aquí las plaquetas son normales. El manejo suele ser soporte y AINEs, reservando los esteroides para dolor abdominal severo o afectación renal.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (MONONUCLEOSIS INFECCIOSA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 627

Adolescente de 14 años con fiebre, odinofagia severa y linfadenopatía cervical posterior. Presenta un exantema maculopapular difuso tras haber recibido Amoxicilina por sospecha de faringitis bacteriana.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico y qué prueba rápida ayuda al diagnóstico inicial?

A) Virus de Epstein-Barr (VEB); Prueba de anticuerpos heterófilos (Monospot). *

B) Citomegalovirus; Cultivo en Shell-vial.

C) Streptococcus pyogenes; Antiestreptolisinas.

D) Virus del Herpes Simple 1; PCR.

Pregunta 2

¿Cuál es la recomendación más importante para un paciente con mononucleosis que practica deportes de contacto?

A) Evitar deportes de contacto por 3 a 4 semanas debido al riesgo de ruptura esplénica. *

B) Puede jugar si no tiene fiebre.

C) Usar faja abdominal.

D) No hay restricciones.

Retroalimentación:

La tríada clásica es fiebre, faringitis y linfadenopatía. El exantema tras amoxicilina es un dato muy característico del VEB. La esplenomegalia es común, de ahí la importancia de evitar traumatismos.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (SÍNDROME DE TORCH - CITOMEGALOVIRUS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 628

Recién nacido de término con peso bajo para la edad gestacional. Presenta microcefalia, ictericia, hepatoesplenomegalia y un exantema purpúrico tipo "pastel de arándano" (blueberry muffin baby). La tomografía de cráneo muestra calcificaciones periventriculares.

Pregunta 1

¿Cuál es la infección congénita más probable y cuál es la secuela a largo plazo más frecuente?

A) Citomegalovirus (CMV); Hipoacusia neurosensorial. *

B) Toxoplasmosis; Coriorretinitis.

C) Rubéola; Persistencia del conducto arterioso.

D) Sífilis; Dientes de Hutchinson.

Retroalimentación:

El CMV es la infección viral congénita más común. Las calcificaciones periventriculares (alrededor de los ventrículos) lo distinguen de la Toxoplasmosis (donde son difusas o parenquimatosas).

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: HEMATOPEDIATRÍA (PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE - PTI)

Dificultad: Media

Caso Clínico 629

Niño de 4 años, previamente sano, que presenta súbitamente petequias, equimosis y epistaxis leve. Hace 2 semanas tuvo un cuadro gripal. A la exploración física no presenta hepatosplenomegalia ni adenomegalias. La biometría hemática reporta: Plaquetas de 15,000/mm^3, con hemoglobina y leucocitos normales.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico y el manejo inicial de elección según la GPC en un paciente con sangrado mucocutáneo leve?

A) Destrucción periférica de plaquetas mediada por anticuerpos (IgG); Observación o Corticosteroides/Inmunoglobulina IV. *

B) Falla en la producción de plaquetas en médula ósea; Transfusión inmediata de plaquetas.

C) Deficiencia de factores de coagulación; Plasma fresco congelado.

D) Vasculitis de pequeños vasos; Ácido acetilsalicílico.

Pregunta 2

¿Cuál es el pronóstico más común de la PTI en la edad pediátrica a diferencia de los adultos?

A) Resolución espontánea en más del 80% de los casos en menos de 6 meses. *

B) Evolución a cronicidad en la mayoría de los casos.

C) Evolución a leucemia aguda.

D) Necesidad de esplenectomía en el primer mes.

Retroalimentación:

La PTI infantil suele ser aguda y post-viral. El dato clave para diferenciarla de la leucemia es que en la PTI solo hay afectación de una línea celular (plaquetas) y NO hay organomegalias. La transfusión de plaquetas está contraindicada a menos que haya hemorragia con riesgo vital, ya que los anticuerpos las destruirían rápidamente.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEFROPEDIATRÍA (TUMOR DE WILMS / NEFROBLASTOMA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 630

Niño de 3 años es traído por su madre porque notó una masa en el abdomen mientras lo bañaba. El niño está asintomático. A la exploración se palpa masa abdominal firme, lisa, que no cruza la línea media. Se detecta tensión arterial en percentil 95 para la edad.

Pregunta 1

¿Cuál es el tumor renal más común en la infancia y cuál es el estudio de imagen inicial de elección?

A) Tumor de Wilms; Ultrasonido abdominal seguido de TAC. *

B) Neuroblastoma; Radiografía de abdomen.

C) Teratoma; Resonancia magnética.

D) Carcinoma de células renales; Gammagrama.

Pregunta 2

¿Cuál es la diferencia clínica fundamental entre el Tumor de Wilms y el Neuroblastoma respecto a la línea media abdominal?

A) El Tumor de Wilms habitualmente NO cruza la línea media; el Neuroblastoma suele cruzarla y es de bordes irregulares. *

B) El Wilms siempre es bilateral y cruza la línea media.

C) No hay diferencia clínica, solo patológica.

D) El Neuroblastoma nunca causa hipertensión.

Retroalimentación:

El Tumor de Wilms deriva del blastema metanéfrico. La hipertensión se debe a la activación del sistema renina-angiotensina por compresión renal. Dato ENARM: El neuroblastoma suele presentar calcificaciones en la TAC y eleva catecolaminas en orina, el Wilms no.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEFROPEDIATRÍA (REFLUJO VESICOURETERAL - RVU)

Dificultad: Media

Caso Clínico 631

Lactante de 8 meses con antecedente de dos episodios de infección de vías urinarias febriles. El ultrasonido reporta hidronefrosis leve bilateral.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de elección para el diagnóstico y clasificación del reflujo vesicoureteral?

A) Cistouretrografía miccional cistoscópica (Cistograma). *

B) Urografía excretora.

C) Gammagrama renal con DMSA.

D) Tomografía computarizada con contraste.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación a largo plazo más importante del RVU no tratado (Nefropatía por reflujo)?

A) Cicatrices renales, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. *

B) Litiasis renal recurrente.

C) Cáncer de vejiga.

D) Diabetes insípida.

Retroalimentación:

El RVU se clasifica de I a V. Los grados I-II suelen resolver espontáneamente con vigilancia y profilaxis; los grados IV-V suelen requerir corrección quirúrgica (reimplante ureteral).

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ENDOCRINOPEDIATRÍA (CETOACIDOSIS DIABÉTICA - CAD)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 632

Paciente de 8 años con diagnóstico reciente de Diabetes Mellitus tipo 1. Acude a urgencias por náuseas, vómito, dolor abdominal y somnolencia. Presenta respiración profunda y rápida (Kussmaul) y aliento con olor a frutas. Glucemia: 450 mg/dL, pH: 7.15, HCO3: 10 mEq/L y cetonuria (+++).

Pregunta 1

¿Cuál es el pilar del tratamiento inicial en la CAD pediátrica y qué complicación neurológica se asocia a una rehidratación demasiado agresiva?

A) Rehidratación con solución salina al 0.9% e infusión de insulina; Edema cerebral. *

B) Administración de bicarbonato IV; Hemorragia subaracnoidea.

C) Insulina en bolo de 1 U/kg; Hipoglucemia severa.

D) Glucosa al 50%; Encefalopatía de Wernicke.

Pregunta 2

¿Cuál es el signo clínico más temprano que sugiere el desarrollo de edema cerebral durante el tratamiento de la CAD?

A) Cefalea, bradicardia y alteración del estado de conciencia. *

B) Hipertermia.

C) Poliuria masiva.

D) Diarrea.

Retroalimentación:

En pediatría, NO se recomiendan los bolos de insulina (aumentan riesgo de edema cerebral); se prefiere infusión continua de 0.1 U/kg/hr tras la primera hora de hidratación. El edema cerebral es la principal causa de muerte por CAD en niños.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ENDOCRINOPEDIATRÍA (TALLA BAJA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 633

Niño de 9 años acude por talla baja. Se encuentra por debajo del percentil 3 para su edad. Sus padres son de estatura promedio. La velocidad de crecimiento es normal (5 cm/año). Al realizar radiografía de mano, la edad ósea reporta 7 años (retraso de 2 años respecto a edad cronológica).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable ante este patrón de crecimiento?

A) Retraso constitucional del crecimiento y la pubertad. *

B) Talla baja familiar.

C) Deficiencia de hormona de crecimiento.

D) Síndrome de Turner.

Pregunta 2

¿Cuál es la diferencia clave entre el retraso constitucional y la talla baja familiar?

A) En la talla baja familiar la edad ósea coincide con la edad cronológica; en el retraso constitucional la edad ósea está retrasada. *

B) El retraso constitucional nunca llega a la talla final normal.

C) La talla baja familiar tiene velocidad de crecimiento lenta.

D) No hay diferencias en la edad ósea.

Retroalimentación:

El "Retraso Constitucional" es el clásico "niño que madura tarde": su talla final será acorde a su potencial genético, pero su pubertad y estirón se retrasan. La Talla Baja

Familiar son niños que crecen acorde a su genética (padres bajos) con edad ósea normal.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (HERPES SIMPLE - GINGIVOESTOMATITIS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 634

Lactante de 18 meses con fiebre, irritabilidad, sialorrea y rechazo al alimento. A la exploración se observan múltiples vesículas y úlceras dolorosas en encías, lengua y mucosa yugal, que sangran con facilidad. Presenta adenopatías submandibulares.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y el tratamiento de elección?

A) Virus del Herpes Simple tipo 1 (VHS-1); Aciclovir oral y manejo del dolor. *

B) Virus de Coxsackie (Herpangina); Solo hidratación.

C) Candida albicans; Nistatina.

D) Estreptococo; Penicilina.

Retroalimentación:

La gingivoestomatitis herpética es la manifestación primaria más común del VHS-1 en niños. Se diferencia de la herpangina (Coxsackie) porque las lesiones herpéticas son anteriores (boca, encías), mientras que la herpangina suele ser posterior (paladar blando, úvula).

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEFROPEDIATRÍA (SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO - SHU)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 635

Niño de 3 años presenta palidez súbita, irritabilidad y disminución del volumen urinario (oligoanuria). Hace una semana presentó un cuadro de diarrea con sangre (disentería). Los laboratorios reportan: Hemoglobina 6 g/dL, Plaquetas 40,000/mm^3, Creatinina elevada y en el frotis de sangre periférica se observan esquistocitos (eritrocitos fragmentados).

Pregunta 1

¿Cuál es la tríada diagnóstica del SHU y cuál es el agente etiológico más común?

A) Anemia hemolítica microangiopática, Trombocitopenia y Lesión Renal Aguda; E. coli productora de toxina Shiga (O157:H7). *

B) Hematuria, Hipertensión y Edema; Estreptococo.

C) Fiebre, Dolor abdominal y Púrpura; Salmonella.

D) Ictericia, Esplenomegalia y Anemia; Giardia.

Pregunta 2

¿Cuál es la recomendación terapéutica respecto al uso de antibióticos en la fase de diarrea por E. coli O157:H7 para prevenir el SHU?

A) Están contraindicados (pueden aumentar la liberación de toxinas y el riesgo de SHU). *

B) Deben iniciarse de inmediato (Ciprofloxacino).

C) Solo se indican si hay fiebre alta.

D) Se prefiere el uso de antidiarreicos como loperamida.

Retroalimentación:

El SHU es la causa más común de lesión renal aguda en niños pequeños. La presencia de esquistocitos confirma que la hemólisis es por daño mecánico al pasar

por microtrombos en los vasos renales. El manejo es de soporte (diálisis si es necesario), NO antibióticos ni plaquetas (salvo sangrado grave).

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: HEMATOPEDIATRÍA (HEMOFILIA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 636

Niño de 2 años presenta aumento de volumen, dolor y limitación funcional en la rodilla derecha tras una caída leve. Refiere antecedente de sangrado prolongado tras la circuncisión. Se sospecha de hemartrosis. El TTPa está prolongado y el TP es normal.

Pregunta 1

¿Cuál es la herencia característica de la Hemofilia A y B, y qué factor falta en la Hemofilia A?

A) Ligada al cromosoma X recesiva; Deficiencia de Factor VIII. *

B) Autosómica dominante; Deficiencia de Factor IX.

C) Ligada al X dominante; Deficiencia de Factor VII.

D) Autosómica recesiva; Deficiencia de Factor Von Willebrand.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para un episodio agudo de sangrado en un paciente con Hemofilia A?

A) Concentrado de Factor VIII liofilizado (recombinante o derivado plasmático). *

B) Plasma fresco congelado únicamente.

C) Vitamina K y Sulfato de Protamina.

D) Crioprecipitados (solo si no hay factor disponible).

Retroalimentación:

Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX, enfermedad de Christmas). Al ser ligadas al X, afectan casi exclusivamente a varones. El TTPa evalúa la vía intrínseca, donde participan estos factores.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ENDOCRINOPEDIATRÍA (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 637

Lactante de 2 meses que no recibió tamiz neonatal. Presenta ictericia prolongada, estreñimiento, macroglosia (lengua grande), piel seca y fontanela posterior amplia (>1 cm). Se observa una hernia umbilical.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito en México y cuál es la meta del tratamiento para prevenir retraso mental?

A) Disgenesia tiroidea (ectopia o agenesia); Iniciar Levotiroxina antes de los 15 días de vida. *

B) Deficiencia de yodo; Iniciar tratamiento al año.

C) Tiroiditis de Hashimoto; Iniciar esteroides.

D) Exceso de hormona tiroidea materna; Observación.

Retroalimentación:

La mayoría de los neonatos con hipotiroidismo son asintomáticos al nacer por el paso de hormona materna, por ello el TAMIZ es vital. Los signos clínicos aparecen cuando el daño neurológico puede ser ya irreversible.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: URGENCIAS PEDIÁTRICAS (INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 638

Niño de 3 años ingiere accidentalmente un frasco de paracetamol en suspensión. Es traído a urgencias 2 horas después del evento. Se encuentra asintomático.

Pregunta 1

¿Cuál es el metabolito tóxico del paracetamol y cuál es el antídoto específico?

A) NAPQI (N-acetil-p-benzoquinoneimina); N-acetilcisteína. *

B) Ácido acético; Bicarbonato.

C) Glutatión; Vitamina K.

D) Formaldehído; Etanol.

Pregunta 2

¿Qué herramienta clínica se utiliza para decidir el inicio del antídoto basándose en los niveles séricos de paracetamol y las horas tras la ingesta?

A) Nomograma de Rumack-Matthew. *

B) Escala de Glasgow.

C) Criterios de Jones.

D) Regla de los nueves.

Retroalimentación:

La N-acetilcisteína es más efectiva si se administra dentro de las primeras 8 horas post-ingesta, ya que restaura los depósitos de glutatión hepático para neutralizar al NAPQI.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: URGENCIAS PEDIÁTRICAS (INTOXICACIÓN POR HIERRO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 639

Escolar que ingiere tabletas de sulfato ferroso de la abuela. Presenta vómitos hemorrágicos, dolor abdominal y diarrea. Posteriormente entra en una fase de "estabilidad aparente" antes de desarrollar falla hepática y choque.

Pregunta 1

¿Cuál es el antídoto específico para la intoxicación grave por hierro?

A) Deferoxamina. *

B) Penicilamina.

C) Edetato de calcio (EDTA).

D) Azul de metileno.

Retroalimentación:

La deferoxamina es un quelante que forma ferrioxamina, la cual se excreta por orina dándole un color característico a "vino rosado".

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ENDOCRINOPEDIATRÍA (PUBERTAD PRECOZ)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 640

Niña de 7 años presenta telarquia (desarrollo mamario) bilateral y aparición de vello púbico. Se observa aceleración de la velocidad de crecimiento y una edad ósea de 9 años.

Pregunta 1

¿Cómo se define la pubertad precoz en niñas y cuál es el estudio inicial para diferenciar el origen central del periférico?

A) Aparición de caracteres sexuales antes de los 8 años; Medición de LH y FSH (basal y tras estimulación con GnRH). *

B) Aparición de vello antes de los 10 años; Solo ultrasonido pélvico.

C) Menarquia antes de los 9 años; Cariotipo.

D) Crecimiento rápido; Prueba de tolerancia a la glucosa.

Retroalimentación:

La pubertad precoz CENTRAL es dependiente de gonadotropinas (eje activado), mientras que la periférica es independiente (quistes ováricos, tumores suprarrenales). El tratamiento de la central es con análogos de GnRH de acción prolongada para "frenar" el eje y evitar el cierre prematuro de las epífisis.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ENDOCRINOPEDIATRÍA (HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA - HSC)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 641

Recién nacido de 10 días de vida, asignado con sexo femenino al nacer, presenta vómitos persistentes, deshidratación grave e hipotensión. A la exploración física se observa virilización de genitales externos (clitoromegalia y fusión de labios mayores). Los laboratorios reportan: Sodio 120 mEq/L (hiponatremia), Potasio 7.5 mEq/L (hiperkalemia) y glucosa 50 mg/dL.

Pregunta 1

¿Cuál es la deficiencia enzimática más frecuente en la HSC y qué metabolito se encuentra elevado para confirmar el diagnóstico?

A) Deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa; 17-hidroxiprogesterona. *

B) Deficiencia de 11-beta-hidroxilasa; 11-desoxicortisol.

C) Deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa; Pregnenolona.

D) Deficiencia de aromatasa; Estrógenos.

Pregunta 2

¿Cuál es la causa de la crisis "perdedora de sal" en estos pacientes y cuál es el tratamiento de urgencia?

A) Deficiencia de mineralocorticoides (aldosterona); Hidrocortisona y reposición hídrica/electrolítica. *

B) Exceso de andrógenos; Antiandrógenos.

C) Resistencia a la insulina; Insulina.

D) Falla renal primaria; Diálisis.

Retroalimentación:

La deficiencia de 21-hidroxilasa causa un "bloqueo" en la síntesis de cortisol y aldosterona, desviando los precursores hacia la vía de los andrógenos (lo que causa la virilización). La falta de aldosterona provoca la pérdida masiva de sodio y la retención de potasio.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: HEMATOPEDIATRÍA (ANEMIA APLÁSICA - ANEMIA DE FANCONI)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 642

Niño de 7 años acude por presentar manchas café con leche en la piel, talla baja y ausencia bilateral de pulgares. La biometría hemática revela pancitopenia (anemia, leucopenia y trombocitopenia). Se sospecha de una anemia aplásica hereditaria.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la prueba diagnóstica de elección para esta patología?

A) Anemia de Fanconi; Prueba de rotura cromosómica con diepoxibutano (DEB) o mitomicina C. *

B) Anemia de Diamond-Blackfan; Aspirado de médula ósea.

C) Síndrome de Shwachman-Diamond; Prueba de grasa en heces.

D) Disqueratosis congénita; Longitud de telómeros.

Retroalimentación:

La Anemia de Fanconi es un trastorno de reparación del ADN. Los niños presentan malformaciones óseas (ausencia de pulgar o radio), manchas café con leche y evolucionan inevitablemente a falla medular y alto riesgo de leucemia.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: URGENCIAS (ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 643

Niño de 2 años que se encontraba comiendo cacahuates presenta súbitamente cuadro de tos cianozante, estridor inspiratorio y posteriormente sibilancias localizadas en el hemitórax derecho. A la auscultación hay disminución del murmullo vesicular en dicho lado.

Pregunta 1

¿Cuál es el sitio anatómico donde se alojan con mayor frecuencia los cuerpos extraños aspirados y cuál es el estudio diagnóstico/terapéutico de elección?

A) Bronquio principal derecho; Broncoscopia rígida. *

B) Laringe; Radiografía de cuello.

C) Bronquio principal izquierdo; Maniobra de Heimlich persistente.

D) Esófago superior; Endoscopia digestiva.

Pregunta 2

¿Cuál es el hallazgo radiológico indirecto más común en una fase inicial de aspiración bronquial?

A) Enfisema obstructivo (hiperclaridad del pulmón afectado por atrapamiento de aire). *

B) Atelectasia total.

C) Neumotórax a tensión.

D) Infiltrado intersticial difuso.

Retroalimentación:

En niños, el bronquio derecho es más vertical y ancho, facilitando el paso de objetos. La broncoscopia rígida es preferible sobre la flexible en pediatría para la extracción de cuerpos extraños por el mejor control de la vía aérea y el instrumental.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: URGENCIAS (INGESTA DE CUERPO EXTRAÑO - MONEDAS Y BATERÍAS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 644

Lactante de 18 meses es traído a urgencias tras ingerir una "pila de botón" hace 1 hora. El niño se encuentra asintomático, pero la madre está muy preocupada. Se realiza radiografía y se observa el objeto en el esófago medio.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta inmediata ante una batería de botón alojada en el esófago?

A) Extracción endoscópica urgente (riesgo de quemadura cáustica y perforación en pocas horas). *

B) Observación por 24 horas para ver si progresa al estómago.

C) Administrar laxantes para acelerar el tránsito.

D) Inducir el vómito.

Pregunta 2

Si el cuerpo extraño fuera una moneda y se encontrara ya en el estómago de un niño asintomático, ¿cuál sería la conducta?

A) Observación y vigilancia de las evacuaciones por 2 a 4 semanas. *

B) Cirugía abdominal inmediata.

C) Endoscopia de urgencia.

D) Lavado gástrico.

Retroalimentación:

Las baterías de botón son una urgencia verdadera si están en esófago debido a la generación de corriente eléctrica y liberación de hidróxido de potasio, que causa necrosis por licuefacción. Las monedas en estómago suelen pasar sin problemas.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (PARASITOSIS - GIARDIASIS)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 645

Preescolar que acude a guardería presenta diarrea crónica, esteatorrea (evacuaciones grasosas, fétidas y flotantes), distensión abdominal y falta de ganancia de peso. No presenta sangre en heces.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico y cuál es el tratamiento de elección?

A) Giardia lamblia; Metronidazol o Tinidazol. *

B) Entamoeba histolytica; Ceftriaxona.

C) Ascaris lumbricoides; Albendazol.

D) Cryptosporidium; Nitazoxanida.

Retroalimentación:

Giardia afecta la absorción de grasas al "tapizar" la mucosa del duodeno y yeyuno proximal. Es la causa parasitaria más común de diarrea prolongada en niños en centros de cuidado infantil.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (PARASITOSIS - AMIBIASIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 646

Niño de 6 años presenta dolor abdominal tipo cólico, tenesmo rectal y evacuaciones con moco y sangre (disentería). En el examen de heces se reportan trofozoítos con eritrocitos fagocitados en su interior.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento indicado?

A) Amibiasis intestinal (Entamoeba histolytica); Metronidazol seguido de un amebicida luminal (como Paromomicina o Yodoquinol). *

B) Shigellosis; Trimetoprima/Sulfametoxazol.

C) Salmonelosis; Ciprofloxacino.

D) Cólera; Doxiciclina.

Retroalimentación:

La presencia de eritrocitos dentro de los trofozoítos confirma la invasividad de *E. histolytica*. Se requiere el amebicida luminal tras el metronidazol para eliminar los quistes persistentes en la luz intestinal y prevenir recaídas o estado de portador.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: URGENCIAS (QUEMADURAS EN PEDIATRÍA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 647

Lactante de 18 meses con peso de 12 kg que sufre quemadura por escaldadura (agua hirviendo) en todo el brazo derecho y la cara anterior del tronco. Presenta ampollas y dolor intenso (2do grado).

Pregunta 1

¿Qué herramienta es la más precisa para calcular la superficie corporal quemada (SCQ) en niños y cuál es el porcentaje aproximado en este paciente?

A) Gráfica de Lund-Browder; 27% (Tronco anterior 18% + Brazo 9%). *

B) Regla de los 9 de Wallace; 15%.

C) Regla de la palma de la mano; 5%.

D) Escala de Parkland; 50%.

Pregunta 2

Según la fórmula de Parkland, ¿cuál es el volumen de solución Hartmann a administrar en las primeras 24 horas (sin contar basales) y cómo se distribuye?

A) 1,296 ml (4 ml x kg x SCQ); La mitad en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. *

B) 500 ml; En infusión constante.

C) 2,000 ml; Todo en la primera hora.

D) 100 ml/kg; Según la regla de Holliday-Segar.

Retroalimentación:

En pediatría, la cabeza es proporcionalmente más grande y las piernas más pequeñas que en adultos, por lo que la "Regla de los 9" falla; se prefiere Lund-Browder. El manejo de líquidos es crítico para evitar el choque hipovolémico y la falla renal.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (ASCARIASIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 648

Niño de 5 años con antecedente de geofagia (comer tierra) presenta cuadro de tos, sibilancias y fiebre leve. La radiografía de tórax muestra infiltrados migratorios (Síndrome de Löffler). Semanas después, presenta dolor abdominal y expulsa un parásito cilíndrico de 20 cm por la boca.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y cuál es la complicación mecánica más grave en el intestino?

A) Ascaris lumbricoides; Obstrucción o suboclusión intestinal por bolo de parásitos. *

B) Necator americanus; Anemia ferropénica.

C) Strongyloides stercoralis; Choque séptico.

D) Trichuris trichiura; Prolapso rectal.

Retroalimentación:

El ciclo de Loos explica la fase pulmonar (Löffler) cuando las larvas atraviesan los alvéolos. El tratamiento de elección es Albendazol o Mebendazol. En caso de obstrucción intestinal por Ascaris, se puede usar citrato de piperazina (que los paraliza) o manejo quirúrgico.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 649

Niño de 4 años con contacto estrecho con abuelo diagnosticado con TB pulmonar activa. El niño está asintomático, pero la prueba de PPD (tuberculina) reporta una induración de 12 mm a las 72 horas. La radiografía de tórax es normal.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta recomendada según la GPC en un niño con PPD positivo pero sin evidencia clínica ni radiográfica de enfermedad (Infección latente)?

A) Quimioprofilaxis con Isoniacida por 6 a 9 meses. *

B) Iniciar tratamiento acortado estrictamente supervisado (DOTS).

C) Repetir el PPD en un año.

D) No requiere manejo por ser asintomático.

Retroalimentación:

En pediatría, el riesgo de progresión de infección latente a enfermedad grave (como meningitis TB o TB miliar) es muy alto. El PPD se considera positivo con ≥ 5 mm en contactos directos o inmunocomprometidos, y ≥ 10 mm en niños menores de 4 años sin otros riesgos.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ORTOPEDIA PEDIÁTRICA (DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA - DDC)

Dificultad: Media

Caso Clínico 650

Recién nacida femenina, producto de primera gesta, con presentación pélvica. A la exploración física se percibe un "clic" al realizar la abducción de la cadera derecha.

Pregunta 1

¿Cómo se llaman las maniobras de exploración física para detectar inestabilidad de la cadera y cuál es el estudio de imagen de elección en menores de 4 meses?

A) Maniobras de Barlow (luxa) y Ortolani (reduce); Ultrasonido de cadera. *

B) Signo de Trendelenburg; Radiografía AP de pelvis.

C) Prueba de Adams; Tomografía.

D) Signo de Galeazzi; Resonancia magnética.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para la DDC en un lactante menor de 6 meses?

A) Arnés de Pavlik. *

B) Yeso pelvipedio inmediato.

C) Reducción quirúrgica abierta.

D) Doble pañal (no recomendado actualmente).

Retroalimentación:

El ultrasonido es superior a la radiografía antes de los 4 meses porque el núcleo de oscificación de la cabeza femoral aún no aparece. El arnés de Pavlik mantiene la cadera en flexión y abducción para permitir el desarrollo del acetábulo.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ORTOPEDIA PEDIÁTRICA (ENFERMEDAD DE LEGG-CALVÉ-PERTHES)

Dificultad: Media

Caso Clínico 651

Niño de 6 años presenta cojera (claudicación) de inicio insidioso y dolor leve en la región de la ingle y el muslo que aumenta con la actividad física. A la exploración hay limitación de la rotación interna y la abducción de la cadera izquierda.

Pregunta 1

¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad y cuál es el hallazgo radiológico inicial más común?

A) Necrosis avascular idiopática de la cabeza femoral; Aumento de la densidad o aplanamiento de la epífisis femoral. *

B) Infección bacteriana del hueso; Reacción perióstica.

C) Deslizamiento de la epífisis; Línea de Klein alterada.

D) Inflamación sinovial transitoria; Derrame articular.

Retroalimentación:

El Perthes afecta típicamente a niños varones de entre 4 y 10 años. Se diferencia de la sinovitis transitoria porque los síntomas son crónicos y progresivos, y de la epifisiolistesis porque esta última es más común en adolescentes obesos.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ORTOPEDIA PEDIÁTRICA (EPIFISIOLISTESIS FEMORAL PROXIMAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 652

Adolescente de 13 años con obesidad grado I acude por dolor en rodilla derecha y cojera de 2 meses de evolución. Al caminar, mantiene el pie hacia afuera (rotación externa). No hay antecedente de trauma.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el manejo indicado?

A) Epifisiolistesis femoral proximal; Fijación quirúrgica in situ con tornillo percutáneo. *

B) Osgood-Schlatter; Reposo y hielo.

C) Artritis idiopática juvenil; Metotrexato.

D) Fractura de fémur; Tracción esquelética.

Retroalimentación:

Es clásico que el paciente refiera dolor en la **rodilla** (dolor referido), pero la patología esté en la cadera. El sobrepeso y los cambios hormonales de la pubertad debilitan la fisis, provocando el desplazamiento. Es una urgencia ortopédica para evitar la necrosis avascular.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (BRUCELOSIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 653

Escolar de 8 años con fiebre ondulante de 3 semanas de evolución, diaforesis nocturna con olor a "paja mojada", artralgias y hepatosplenomegalia. Refiere haber consumido queso artesanal no pasteurizado durante las vacaciones.

Pregunta 1

¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico y qué prueba de tamizaje se utiliza inicialmente?

A) Mielocultivo (estándar de oro) y Rosa de Bengala (tamizaje). *

B) Hemocultivo y PCR.

C) Reacciones febriles únicamente.

D) Urocultivo y Elutest.

Pregunta 2

¿Cuál es el esquema de tratamiento de elección según la GPC en niños mayores de 8 años?

A) Doxiciclina + Rifampicina por 6 semanas. *

B) TMP/SMX + Estreptomicina.

C) Amoxicilina por 7 días.

D) Penicilina G Benzatínica.

Retroalimentación:

La brucelosis es una zoonosis común en México. El mielocultivo tiene mayor sensibilidad que el hemocultivo, especialmente en casos crónicos. En menores de 8 años se evita la doxiciclina (por riesgo de tinción dental) y se usa el esquema con TMP/SMX + Rifampicina.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: INFECTOPEDIATRÍA (RICKETTSIOSIS / FIEBRE MANCHADA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 654

Niño de 6 años residente de zona urbana en el norte de México. Inicia con fiebre alta, cefalea intensa y mialgias. Al cuarto día aparece un exantema maculopapular que inició en muñecas y tobillos, progresando de forma centrípeta hacia el tronco, afectando palmas y plantas. Refiere convivencia con perros con garrapatas.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y cuál es el tratamiento de elección, incluso en pacientes pediátricos pequeños?

A) Rickettsia rickettsii; Doxiciclina. *

B) Borrelia burgdorferi; Penicilina.

C) Ehrlichia; Ceftriaxona.

D) Coxiella burnetii; Claritromicina.

Retroalimentación:

Dato ENARM de Oro: En Rickettsiosis, la DOXICICLINA es el tratamiento de elección sin importar la edad del niño, ya que el riesgo de muerte por la enfermedad supera por mucho el riesgo teórico de tinción dental por esquemas cortos.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ORTOPEDIA PEDIÁTRICA (FRACTURA SUPRACONDÍLEA DE HÚMERO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 655

Niño de 5 años sufre caída desde su propia altura con el codo en extensión. Presenta dolor intenso, deformidad en "S" itálica y aumento de volumen en el codo.

Pregunta 1

¿Cuál es la complicación neurovascular más frecuente que debe evaluarse de inmediato?

A) Lesión del nervio mediano (o interóseo anterior) y de la arteria humeral. *

B) Lesión del nervio cubital.

C) Lesión del plexo braquial.

D) Rotura del tendón del tríceps.

Pregunta 2

¿Cómo se denomina la contractura isquémica permanente de la mano y muñeca resultante de un síndrome compartimental no tratado tras esta fractura?

A) Contractura de Volkmann. *

B) Deformidad de Madelung.

C) Mano en garra.

D) Enfermedad de Dupuytren.

Retroalimentación:

La fractura supracondílea es la fractura de codo más común en niños. El desplazamiento posterior del fragmento distal puede comprometer el paquete vascular. Si hay ausencia de pulso o dolor desproporcionado al estirar los dedos, debe sospecharse síndrome compartimental.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: ORTOPEDIA PEDIÁTRICA (FRACTURA EN TALLO VERDE Y RODETE)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 656

Niño de 4 años cae sobre su mano extendida. La radiografía de antebrazo muestra una interrupción de la cortical en un solo lado del hueso, mientras que el lado opuesto permanece intacto pero angulado.

Pregunta 1

¿Cuál es el nombre de este tipo de fractura y por qué es exclusiva de la edad pediátrica?

A) Fractura en tallo verde; Debido a que el periostio es grueso y el hueso es más flexible (menos mineralizado). *

B) Fractura en rodete; Por compresión axial.

C) Fractura de Colles; Por osteoporosis.

D) Fractura de Monteggia; Por luxación asociada.

Retroalimentación:

Los huesos de los niños tienen una gran capacidad de deformación elástica. En la "tallo verde" el hueso se dobla y se rompe parcialmente; en la fractura "en rodete" o "torus", el hueso se impacta sobre sí mismo creando un pequeño abombamiento cortical.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEUROPEDIATRÍA (CRISIS DE AUSENCIA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 658

Escolar de 7 años es referido por su maestra porque "se queda ido" varias veces al día durante 5 a 10 segundos, interrumpiendo su actividad y sin recordar el evento después. No presenta movimientos tónicos ni pérdida del tono postural.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo clásico en el Electroencefalograma (EEG) para esta patología y cuál es el tratamiento de elección?

A) Punta-onda lenta a 3 Hz (ciclos por segundo); Etosuximida o Valproato de magnesio. *

B) Hipsarritmia; Vigabatrina.

C) Puntas centrotemporales; Carbamazepina.

D) Complejos de ondas agudas; Fenobarbital.

Retroalimentación:

Las crisis de ausencia suelen ser provocadas por la hiperventilación. Es fundamental no confundirlas con el TDAH, ya que el tratamiento es completamente distinto. La etosuximida es el fármaco más específico.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUROLOGÍA (EVC ISQUÉMICO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 660

Paciente masculino de 65 años con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular no anticoagulada. Es traído a urgencias por presentar súbitamente desviación de la comisura labial, hemiparesia derecha y afasia de 2 horas de evolución. TA: 160/95 mmHg.

Pregunta 1

¿Cuál es la escala clínica inicial para evaluar la gravedad del EVC y cuál es el estudio de imagen de elección para diferenciar entre un evento isquémico y uno hemorrágico?

A) Escala de NIHSS; Tomografía Axial Computarizada (TAC) de cráneo simple. *

B) Escala de Glasgow; Resonancia Magnética.

C) Escala de Rankin; Radiografía de cráneo.

D) Escala de Cincinnati; Ultrasonido Doppler carotídeo.

Pregunta 2

Si la TAC descarta hemorragia, ¿cuál es el tratamiento de elección considerando el tiempo de evolución (ventana terapéutica)?

A) Trombólisis intravenosa con r-tPA (alteplase). *

B) Administración de Ácido Acetilsalicílico 325 mg.

C) Heparina no fraccionada en bolo.

D) Vigilancia en UCI sin fármacos.

Retroalimentación:

El EVC isquémico es una emergencia tiempo-dependiente. La ventana para trombólisis es de 4.5 horas. La TAC simple es suficiente para descartar sangre

(hemorragia), que es la principal contraindicación para el activador del plasminógeno tisular.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUROLOGÍA (CEFALEAS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 661

Mujer de 28 años refiere episodios recurrentes de cefalea hemicraneal, pulsátil, de intensidad moderada-severa, que dura entre 12 y 24 horas. Se acompaña de náuseas, fotofobia y fonofobia. Refiere que antes del dolor ve "luces brillantes" durante 20 minutos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el tratamiento de elección para el ataque agudo?

A) Migraña con aura; Triptanos (Sumatriptán). *

B) Cefalea tensional; Paracetamol.

C) Cefalea en racimos; Oxígeno al 100%.

D) Arteritis de la temporal; Esteroides.

Retroalimentación:

La migraña es más común en mujeres jóvenes. El aura (síntomas neurológicos reversibles) precede al dolor. Los triptanos son agonistas 5-HT1B/1D y son el estándar para crisis moderadas a graves que no ceden con AINEs.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUROLOGÍA (ENFERMEDAD DE PARKINSON)

Dificultad: Media

Caso Clínico 662

Paciente de 70 años presenta temblor en reposo en la mano derecha ("cuenta-monedas"), lentitud de movimientos (bradicinesia) e inestabilidad postural. Al caminar, no balancea el brazo derecho y tiene una facies inexpresiva (facies de máscara).

Pregunta 1

¿Cuál es la alteración fisiopatológica subyacente y cuál es el tratamiento de elección (estándar de oro)?

A) Degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta; Levodopa/Carbidopa. *

B) Placas de amiloide en el hipocampo; Donepezilo.

C) Atrofia del núcleo caudado; Haloperidol.

D) Desmielinización central; Interferón beta.

Retroalimentación:

El Parkinson se define por la tríada: temblor en reposo, rigidez ("rueda dentada") y bradicinesia. La levodopa es el precursor de la dopamina, y la carbidopa evita su degradación periférica.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: DERMATOLOGÍA (CÁNCER DE PIEL - BASOCELULAR)

Dificultad: Media

Caso Clínico 663

Hombre de 72 años, campesino, presenta una lesión en el ala nasal de 1 año de evolución. Es una pápula perlada de 0.8 cm, con bordes elevados y telangiectasias en la superficie. Presenta una pequeña ulceración central (ulcus rodens).

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo de cáncer de piel más frecuente y cuál es su principal factor de riesgo?

A) Carcinoma Basocelular; Exposición crónica a radiación ultravioleta (solar). *

B) Carcinoma Espinocelular; Infección por VPH.

C) Melanoma Maligno; Antecedentes genéticos únicamente.

D) Sarcoma de Kaposi; Inmunosupresión por VIH.

Retroalimentación:

El carcinoma basocelular tiene un crecimiento lento y casi nunca da metástasis, pero es localmente invasivo. El aspecto "perlado" y las telangiectasias son datos patognomónicos en el examen.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA / DERMATOLOGÍA (ERIPESELA VS CELULITIS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 664

Paciente femenina de 50 años, diabética, presenta súbitamente fiebre de 39°C y una placa eritematosa en la pierna derecha. La placa es brillante, caliente, muy dolorosa y tiene bordes bien definidos, elevados respecto a la piel sana.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y el agente etiológico principal?

A) Erisipela; Streptococcus pyogenes (Grupo A). *

B) Celulitis; Staphylococcus aureus.

C) Fascitis necrotizante; Clostridium.

D) Dermatitis de contacto; Alérgenos.

Retroalimentación:

La clave diagnóstica es el **borde bien definido**. La erisipela afecta la dermis superficial y linfáticos, mientras que la celulitis es más profunda y sus bordes son difusos.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: PSIQUIATRÍA (TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR)

Dificultad: Media

Caso Clínico 665

Mujer de 34 años refiere que desde hace 3 meses presenta tristeza la mayor parte del día, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba (anhedonia), insomnio de despertar temprano y sentimientos de culpa excesivos. Ha perdido 5 kg de peso sin hacer dieta. Niega ideas suicidas.

Pregunta 1

¿Cuál es el criterio temporal mínimo para el diagnóstico de Episodio Depresivo Mayor y cuál es el tratamiento farmacológico de primera elección?

A) 2 semanas; Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina (ISRS) como Sertralina. *

B) 1 mes; Benzodiacepinas.

C) 6 meses; Antidepresivos tricíclicos.

D) 1 año; Litio.

Pregunta 2

¿Cuál es el efecto adverso más común de los ISRS por el cual los pacientes suelen abandonar el tratamiento inicialmente?

A) Gastrointestinales (náuseas, diarrea) y disfunción sexual. *

B) Prolongación del intervalo QT.

C) Sedación profunda.

D) Crisis hipertensivas.

Retroalimentación:

El diagnóstico de depresión mayor requiere al menos 5 síntomas de la lista del DSM-5 (donde uno debe ser ánimo deprimido o anhedonia) por un periodo de 2 semanas.
Los ISRS son la primera línea por su perfil de seguridad.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUROLOGÍA (TÉTANOS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 666

Hombre de 45 años, trabajador de la construcción, acude por rigidez mandibular que le impide abrir la boca (trismus) y espasmos musculares dolorosos en el tronco tras

sufrir una herida punzante con un clavo oxidado en el pie hace 10 días. No cuenta con esquema de vacunación recordable.

Pregunta 1

¿Cuál es la toxina responsable del cuadro clínico y cuál es su mecanismo de acción?

A) Tetanospasmina; Inhibe la liberación de neurotransmisores inhibitorios (GABA y glicina). *

B) Toxina botulínica; Bloquea la liberación de acetilcolina.

C) Toxina eritrogénica; Daño endotelial.

D) Endotoxina lipopolisacárida; Choque séptico.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial de elección para neutralizar la toxina no fijada y controlar los espasmos?

A) Inmunoglobulina humana tetánica + Benzodiacepinas (Diazepam). *

B) Vacuna DPT únicamente.

C) Penicilina G a dosis altas únicamente.

D) Relajantes musculares periféricos (vecuronio).

Retroalimentación:

El tétanos es un diagnóstico clínico. El tratamiento incluye: 1. Limpieza de la herida, 2. Antibiótico (Metronidazol de elección o Penicilina), 3. Neutralización (Gammaglobulina) y 4. Vacunación (el padecer la enfermedad no confiere inmunidad).

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUROLOGÍA (EPILEPSIA EN ADULTOS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 667

Hombre de 22 años es traído a urgencias tras presentar un evento de pérdida del estado de alerta, movimientos tónico-clónicos generalizados de 2 minutos de duración, con mordedura de lengua y relajación de esfínteres. Se encuentra en periodo posictal (confuso y somnoliento).

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de elección para clasificar el tipo de crisis y cuál es el fármaco de primera línea para crisis tónico-clónicas generalizadas en adultos?

A) Electroencefalograma (EEG); Valproato de magnesio. *

B) TAC de cráneo; Fenitoína.

C) Punción lumbar; Carbamazepina.

D) Resonancia Magnética; Etosuximida.

Retroalimentación:

El Valproato es el fármaco de amplio espectro por excelencia. En mujeres en edad fértil se debe tener precaución por su teratogenicidad (defectos del tubo neural).

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: GERIATRÍA (SÍNDROME DE CAÍDAS Y FRAGILIDAD)

Dificultad: Media

Caso Clínico 668

Paciente masculino de 82 años con antecedente de hipertensión y artrosis. Refiere haber presentado 3 caídas en el último año, una de ellas con fractura de radio distal. Camina con pasos cortos y base de sustentación amplia.

Pregunta 1

¿Cómo se define el "Síndrome de Caídas" en el adulto mayor?

A) Presencia de 2 o más caídas en un periodo de 12 meses. *

B) Una caída con fractura.

C) Cualquier caída que requiera hospitalización.

D) Tres caídas en toda la vida senil.

Pregunta 2

¿Cuál es el factor de riesgo intrínseco más importante para caídas en este grupo de edad que debe evaluarse sistemáticamente?

A) Polifarmacia (uso de >5 medicamentos). *

B) Mala iluminación en el hogar.

C) Uso de alfombras.

D) Falta de pasamanos.

Retroalimentación:

Las caídas en el anciano son un marcador de fragilidad y pérdida de autonomía. La polifarmacia (especialmente benzodiacepinas y antihipertensivos) es la causa reversible más frecuente.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: PSIQUIATRÍA (TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA - TAG)

Dificultad: Media

Caso Clínico 669

Mujer de 29 años refiere preocupación excesiva por "todo" (trabajo, salud, dinero) durante los últimos 8 meses. Presenta tensión muscular, irritabilidad, dificultad para concentrarse y fatiga constante. Los síntomas le causan un malestar significativo en su vida diaria.

Pregunta 1

¿Cuál es el periodo de tiempo requerido para el diagnóstico de TAG y cuál es el tratamiento de mantenimiento de elección?

A) 6 meses; ISRS (como Escitalopram o Paroxetina). *

B) 2 semanas; Alprazolam de por vida.

C) 1 mes; Terapia electroconvulsiva.

D) 1 año; Propanolol únicamente.

Retroalimentación:

A diferencia del trastorno de pánico (ataques agudos), el TAG es una ansiedad "flotante" y crónica. Las benzodiacepinas solo se usan para el control agudo (máximo 4-8 semanas) mientras los ISRS alcanzan su efecto terapéutico.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA (VIH / SIDA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 670

Hombre de 35 años con diagnóstico de VIH hace 5 años, sin tratamiento actual. Acude por cefalea, fiebre y confusión de 1 semana. A la exploración presenta signos meníngeos. Se realiza punción lumbar con presión de apertura elevada y la tinción con Tinta China reporta estructuras levaduriformes encapsuladas.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal más probable y qué cifra de CD4 suele asociarse a esta infección oportunista?

A) Cryptococcus neoformans; CD4 < 100 células/mm^3. *

B) Toxoplasma gondii; CD4 < 200 células/mm^3.

C) Mycobacterium tuberculosis; CD4 > 500 células/mm^3.

D) Virus JC; CD4 < 50 células/mm^3.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de inducción de elección para la meningitis criptocócica según la GPC?

A) Anfotericina B liposomal + Flucitosina por 2 semanas. *

B) Fluconazol oral únicamente.

C) Trimetoprima/Sulfametoxazol IV.

D) Ceftriaxona + Vancomicina.

Retroalimentación:

La criptococosis es la infección fúngica meníngea más común en SIDA. La Tinta China es el examen rápido clásico, aunque el antígeno criptocócico en LCR es más sensible. Es vital controlar la presión intracraneal.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEFROLOGÍA (LESIÓN RENAL AGUDA - LRA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 671

Paciente masculino de 70 años con antecedente de insuficiencia cardiaca. Ingresa por neumonía y desarrolla deshidratación por pobre ingesta de líquidos. Sus laboratorios muestran Elevación de Creatinina (de 0.9 a 2.1 mg/dL) y el examen de orina muestra Sodio Urinario < 20 mEq/L y Fracción Excretada de Sodio (FeNa) < 1%.

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo de Lesión Renal Aguda que presenta el paciente y cuál es el manejo inicial?

A) LRA Prerrenal; Reposición hídrica con soluciones isotónicas y tratamiento de la causa base. *

B) Necrosis Tubular Aguda (Intrínseca); Diuréticos de asa a dosis altas.

C) LRA Posrenal; Colocación de sonda Foley.

D) Nefritis intersticial; Esteroides sistémicos.

Retroalimentación:

La LRA prerrenal es la más común y se debe a hipoperfusión. El dato clave es el FeNa < 1%, que indica que el riñón aún tiene capacidad de reabsorber sodio (túbulos intactos). Si no se corrige, puede progresar a daño intrínseco (Necrosis Tubular Aguda).

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUMOLOGÍA (EPOC - EXACERBACIÓN AGUDA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 672

Hombre de 68 años, fumador de 40 paquetes/año, con diagnóstico de EPOC. Acude por aumento de la disnea habitual, incremento en la purulencia del esputo y aumento en el volumen del mismo (Criterios de Anthonisen).

Pregunta 1

¿Cuál es el pilar del tratamiento farmacológico para una exacerbación aguda de EPOC según la guía GOLD?

A) Broncodilatadores de acción corta (SABA/SAMA) + Esteroides sistémicos + Antibióticos. *

B) Solo oxígeno suplementario.

C) Antibióticos profilácticos únicamente.

D) Teofilina IV y mucolíticos.

Pregunta 2

¿Cuál es el objetivo de saturación de oxígeno (SpO2) recomendado en un paciente con EPOC exacerbado para evitar la hipercapnia?

A) 88% - 92%. *

B) 95% - 100%.

C) > 98%.

D) < 85%.

Retroalimentación:

Las exacerbaciones de EPOC suelen ser infecciosas. Los antibióticos se indican si se cumplen los 3 criterios de Anthonisen o si requiere ventilación mecánica. El exceso de oxígeno puede suprimir el impulso respiratorio hipóxico en estos pacientes.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: GASTROENTEROLOGÍA (CIRROSIS HEPÁTICA - PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 673

Paciente de 55 años con cirrosis por alcohol acude por dolor abdominal difuso y fiebre. Se realiza paracentesis diagnóstica que reporta un conteo de polimorfonucleares (PMN) en líquido ascítico de 450 células/mm^3.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento antibiótico empírico de elección?

A) Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE); Cefalosporinas de 3ra generación (Cefotaxima o Ceftriaxona). *

B) Ascitis quilosa; Dieta baja en grasas.

C) Peritonitis secundaria (perforación); Cirugía inmediata.

D) Insuficiencia hepática aguda; Trasplante.

Retroalimentación:

La PBE se define por > 250 PMN/mm^3 en líquido ascítico. El patógeno más común es E. coli. Es fundamental administrar albúmina IV (días 1 y 3) para reducir el riesgo de síndrome hepatorrenal.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: CARDIOLOGÍA (INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA - EDEMA AGUDO DE PULMÓN)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 674

Mujer de 72 años con antecedente de infarto previo. Acude por disnea súbita en reposo, ortopnea y expectoración asalmonada. A la exploración: TA 160/100, estertores crepitantes bilaterales "en marea ascendente" y tercer ruido cardiaco (S3).

Pregunta 1

¿Cuál es el manejo farmacológico inmediato de elección para disminuir la precarga y postcarga?

A) Nitroglicerina (o nitritos) + Diuréticos de asa (Furosemida) + Oxígeno. *

B) Betabloqueadores y Digoxina.

C) Aspirina y Clopidogrel únicamente.

D) Líquidos IV agresivos.

Retroalimentación:

El edema agudo de pulmón es una urgencia. Los nitratos son potentes vasodilatadores que ayudan a "descargar" el corazón rápidamente, mientras que los diuréticos eliminan el exceso de volumen. El S3 es un signo clásico de sobrecarga ventricular.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: REUMATOLOGÍA (ARTRITIS REUMATOIDE)

Dificultad: Media

Caso Clínico 675

Mujer de 45 años presenta dolor y aumento de volumen en articulaciones metacarpo-falángicas e interfalángicas proximales de ambas manos de 6 meses de evolución. Refiere rigidez matutina que dura más de 1 hora y mejora con la actividad.

Pregunta 1

¿Cuál es el marcador serológico más específico para el diagnóstico y cuál es el tratamiento modificador de la enfermedad (FARME) de primera elección?

A) Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (anti-CCP); Metotrexato. *

B) Factor Reumatoide; Prednisona sola.

C) Anticuerpos antinucleares (ANA); Cloroquina.

D) HLA-B27; Infliximab.

Pregunta 2

¿Qué hallazgo radiológico es característico de la AR establecida en las manos?

A) Erosiones óseas marginales y disminución del espacio articular simétrico. *

B) Osteofitos y esclerosis subcondral.

C) Imagen en "sacabocado" con tofos.

D) Sindesmofitos marginales.

Retroalimentación:

La AR es una enfermedad inflamatoria crónica, simétrica y erosiva. El Metotrexato es el "estándar de oro" de los FARME. Los anti-CCP tienen un valor predictivo positivo muy alto para daño erosivo.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: REUMATOLOGÍA (LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO - LES)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 676

Mujer de 25 años acude por fatiga, artralgias y una lesión eritematosa en mejillas y dorso de la nariz que respeta los surcos nasogenianos tras exposición solar. Laboratorios: Anemia normocítica, leucopenia y proteinuria de 1 g en 24 horas.

Pregunta 1

¿Cuál es la prueba de tamizaje inicial más sensible y cuál es el anticuerpo más específico asociado a actividad de nefritis lúpica?

A) Anticuerpos Antinucleares (ANA); Anti-DNA de doble cadena (dsDNA). *

B) Anti-Smith (anti-Sm); Anti-Ro.

C) Anti-histonas; Complemento C3 elevado.

D) Anticuerpos anticardiolipina; Factor reumatoide.

Retroalimentación:

Los ANA positivos están presentes en >95% de los casos (muy sensibles), pero el anti-Sm es el más específico. El anti-dsDNA se correlaciona con el grado de actividad de la enfermedad y el compromiso renal.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: ENDOCRINOLOGÍA (HIPOTIROIDISMO PRIMARIO)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 677

Mujer de 52 años refiere intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca y aumento de peso a pesar de hiporexia. A la exploración presenta bradicardia y retraso en la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos.

Pregunta 1

¿Cuál es el perfil tiroideo esperado para confirmar un hipotiroidismo primario y cuál es la causa más frecuente en zonas con suficiencia de yodo?

A) TSH elevada con T4 libre baja; Tiroiditis de Hashimoto (Autoinmune). *

B) TSH baja con T4 libre baja; Hipotiroidismo secundario.

C) TSH elevada con T4 libre normal; Hipotiroidismo subclínico.

D) TSH normal con T4 libre alta; Tirotoxicosis.

Pregunta 2

¿Cuál es el anticuerpo que se encuentra positivo en la mayoría de los casos de Tiroiditis de Hashimoto?

A) Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (anti-TPO). *

B) Anticuerpos contra el receptor de TSH (TSI).

C) Anticuerpos antitiroglobulina únicamente.

D) Anticuerpos antimicrosomales negativos.

Retroalimentación:

El tratamiento de elección es la Levotiroxina sódica. En adultos mayores o pacientes con cardiopatía, se debe iniciar a dosis bajas para evitar eventos isquémicos cardiacos.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: ENDOCRINOLOGÍA (SÍNDROME DE CUSHING)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 678

Paciente masculino de 40 años presenta hipertensión de difícil control, obesidad central, "giba dorsal", cara de "luna llena" y estrías violáceas en abdomen de más de 1 cm de ancho.

Pregunta 1

¿Cuál es la primera prueba diagnóstica para confirmar el hipercortisolismo y cuál es la causa más frecuente de origen ENDÓGENO?

A) Cortisol libre en orina de 24 horas; Enfermedad de Cushing (Adenoma hipofisario). *

B) Cortisol sérico matutino; Tumor suprarrenal.

C) Prueba de supresión con dexametasona dosis altas; Carcinoma pulmonar de células pequeñas.

D) Niveles de ACTH; Consumo de glucocorticoides exógenos. * (Nota: El consumo exógeno es la causa más común general, pero el adenoma hipofisario es la causa endógena más común).

Retroalimentación:

El ENARM suele preguntar por la distinción entre "Síndrome" (manifestaciones de exceso de cortisol) y "Enfermedad" (específicamente el adenoma productor de ACTH en la hipófisis).

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: HEMATOLOGÍA (ANEMIA MEGALOBLÁSTICA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 679

Hombre de 60 años con antecedente de alcoholismo crónico y desnutrición. Acude por palidez, glositis (lengua depapilada y roja) y parestesias en miembros inferiores. La biometría muestra: Hb 8.5 g/dL, VCM 115 fL (Macrocítica) y neutrófilos hipersegmentados.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable de los síntomas neurológicos y qué deficiencia vitamínica la produce?

A) Degeneración combinada subaguda de la médula espinal; Deficiencia de Vitamina B12 (Cobalamina). *

B) Neuropatía periférica simple; Deficiencia de Folatos (B9).

C) Anemia ferropénica; Deficiencia de Hierro.

D) Saturnismo; Intoxicación por plomo.

Retroalimentación:

Dato clave: La deficiencia de **Folatos NO da síntomas neurológicos**, mientras que la de **B12 SÍ**. Ambas dan anemia macrocítica con neutrófilos hipersegmentados. En pacientes con anemia perniciosa, el mecanismo es la falta de factor intrínseco.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: CARDIOLOGÍA (HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA - HAS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 680

Hombre de 55 años, con IMC de 31 kg/m^2, acude a revisión. En tres ocasiones distintas presenta cifras de TA promedio de 145/95 mmHg. Niega síntomas. El examen de orina y creatinina son normales.

Pregunta 1

Según la GPC, ¿cuál es el diagnóstico y el tratamiento farmacológico inicial de elección en este paciente sin comorbilidades?

A) HAS Grado 1; Iniciar con un IECA (Enalapril) o una Tiazida (Clortalidona). *

B) HAS Grado 2; Iniciar con Calcioantagonistas.

C) Hipertensión de bata blanca; Solo cambios en el estilo de vida.

D) Urgencia hipertensiva; Nifedipino sublingual.

Pregunta 2

¿Cuál es la meta de control tensional para la mayoría de los pacientes menores de 60 años según las guías actuales?

A) < 130/80 mmHg. *

B) < 140/90 mmHg.

C) < 150/95 mmHg.

D) < 120/70 mmHg.

Retroalimentación:

La Clortalidona es preferida sobre la Hidroclorotiazida por su mayor vida media. El Nifedipino sublingual está PROSCRITO en el ENARM por riesgo de isquemia cerebral/cardiaca por descenso brusco.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA (TUBERCULOSIS PULMONAR)

Dificultad: Media

Caso Clínico 681

Hombre de 40 años presenta tos productiva de 4 semanas, hemoptisis ocasional, pérdida de peso y sudoración nocturna. La baciloscopia (BAAR) en expectoración reporta (+++).

Pregunta 1

¿Cuál es el esquema de tratamiento primario acortado (DOTS) y cuánto tiempo dura la fase intensiva?

A) Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol (IRPE); 2 meses (60 dosis). *

B) Isoniacida y Rifampicina; 6 meses.

C) Estreptomicina y Etambutol; 4 meses.

D) Levofloxacino y Claritromicina; 1 mes.

Pregunta 2

¿Cuál de los fármacos del esquema primario se asocia con mayor frecuencia a la aparición de NEURITIS ÓPTICA (alteración en la discriminación de colores)?

A) Etambutol. *

B) Isoniacida.

C) Rifampicina.

D) Pirazinamida.

Retroalimentación:

Mnemotecnia de efectos adversos: **E**tambutol (**E**ye/Ojo - Neuritis), **I**soniacida (**I**nterrumpe nervios - Neuritis periférica, se evita con B6), **R**ifampicina (**R**ojo - orina naranja), **P**irazinamida (**P**urinas - hiperuricemia/gota).

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (ELIMINANDO CEROS)

Subtema: CICLO GENITAL Y ANTICONCEPCIÓN

Dificultad: Media

Caso Clínico 682

Mujer de 24 años, sana, solicita método anticonceptivo de larga duración. Refiere que suele olvidar la toma de pastillas diarias. No tiene antecedentes de importancia.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los anticonceptivos hormonales combinados (AHC)?

A) Inhibición de la ovulación mediante la supresión de la liberación de GnRH, FSH y LH. *

B) Espesamiento del moco cervical únicamente.

C) Atrofia del endometrio exclusivamente.

D) Efecto espermicida directo.

Pregunta 2

¿Cuál es el método anticonceptivo con mayor tasa de eficacia (menor índice de Pearl) entre los siguientes?

A) Implante subdérmico de etonogestrel. *

B) Dispositivo intrauterino de cobre (DIU).

C) Condón masculino.

D) Anticonceptivos orales.

Retroalimentación:

El implante es el método más eficaz actualmente (incluso más que la vasectomía en algunos reportes), ya que no depende del cumplimiento del paciente. El índice de Pearl mide el número de embarazos en 100 mujeres tras un año de uso.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (ELIMINANDO CEROS)

Subtema: FISIOLOGÍA DEL CICLO GENITAL

Dificultad: Alta

Caso Clínico 683

En una mujer con ciclos regulares de 28 días, se analiza la fase del ciclo menstrual.

Pregunta 1

¿Cuál es la hormona responsable de la fase proliferativa del endometrio y cuál es el evento que desencadena la ovulación?

A) Estrógenos; Pico de Hormona Luteinizante (LH). *

B) Progesterona; Caída de FSH.

C) Inhibina; Pico de Estradiol.

D) Prolactina; Inicio de la menstruación.

Pregunta 2

¿Qué hormona predomina en la fase lútea (secretora) y es producida por el cuerpo lúteo?

A) Progesterona. *

B) Estrógenos.

C) Testosterona.

D) hCG.

Retroalimentación:

La ovulación ocurre aproximadamente 36 horas después del inicio del pico de LH. La fase lútea siempre es constante (14 días), lo que varía en los ciclos irregulares es la fase folicular.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA (TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 690

Hombre de 32 años con antecedente de VIH sin apego a tratamiento. Acude por fiebre, cefalea intensa, náuseas y rigidez de nuca de 2 semanas de evolución. Se realiza punción lumbar que reporta: presión de apertura 30 cmH2O, proteínas 250 mg/dL, glucosa 30 mg/dL y pleocitosis de 300 células a expensas de linfocitos (80%).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el estudio de laboratorio con mayor sensibilidad para confirmar este agente en LCR?

A) Meningitis por Mycobacterium tuberculosis; PCR para M. tuberculosis (GeneXpert). *

B) Meningitis por Criptococo; Tinta china.

C) Meningitis viral; Cultivo viral.

D) Neurosífilis; VDRL en LCR.

Pregunta 2

¿Qué fármaco adyuvante es fundamental iniciar en la meningitis tuberculosa para reducir la mortalidad y las secuelas neurológicas?

A) Dexametasona (u otro corticoide) por 4 a 8 semanas. *

B) Manitol al 20%.

C) Fenitoína profiláctica.

D) Infliximab.

Retroalimentación:

La meningitis tuberculosa es la forma más grave de TB extrapulmonar. El perfil de LCR típico es: hipoglucorraquia severa, hiperproteinorraquia marcada y pleocitosis linfocítica. El uso de esteroides es una recomendación Grado A para disminuir la inflamación meníngea y el riesgo de hidrocefalia o vasculitis.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEFROLOGÍA (TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS - HIPONATREMIA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 691

Mujer de 74 años es traída por confusión y debilidad extrema. Antecedente de HAS tratada con hidroclorotiazida. Laboratorios: Sodio sérico 118 mEq/L, Osmolaridad sérica 250 mOsm/kg (baja). Se diagnostica hiponatremia hipotónica euvolémica.

Pregunta 1

¿Cuál es la complicación neurológica más grave que puede ocurrir si se corrige el sodio de forma demasiado rápida (>10-12 mEq/L en 24 horas)?

A) Síndrome de desmielinización osmótica (mielinolisis pontina). *

B) Edema cerebral agudo.

C) Hemorragia subaracnoidea.

D) Encefalopatía de Wernicke.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento inicial de elección para una hiponatremia SEVERA SINTOMÁTICA (convulsiones o coma)?

A) Solución salina hipertónica al 3%. *

B) Restricción de líquidos únicamente.

C) Solución salina al 0.9%.

D) Furosemida IV.

Retroalimentación:

La corrección rápida del sodio provoca que el agua salga bruscamente de las células cerebrales, causando daño en la mielina (especialmente en el puente). El ritmo de corrección ideal es de 0.5 a 1 mEq/L por hora, con un límite de 8 a 10 mEq/L en el primer día.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: GASTROENTEROLOGÍA (ENFERMEDAD ÁCIDO-PÉPTICA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 692

Hombre de 45 años con antecedente de consumo crónico de AINEs por lumbalgia. Acude por dolor en epigastrio tipo ardoroso que mejora con la ingesta de alimentos pero reaparece 2-3 horas después. Presenta melena ocasional.

Pregunta 1

¿Cuál es la localización más probable de la úlcera y cuál es el estudio de elección para el diagnóstico?

A) Úlcera duodenal; Endoscopia de tubo digestivo alto (Panendoscopia). *

B) Úlcera gástrica; Serie esófago-gastro-duodenal.

C) Úlcera esofágica; pH-metría.

D) Divertículo de Meckel; Gammagrama.

Pregunta 2

¿Cuál es la causa más frecuente de úlcera péptica a nivel mundial y qué esquema de tratamiento se recomienda para su erradicación?

A) Helicobacter pylori; Terapia triple (Claritromicina + Amoxicilina + IBP). *

B) Estrés; Ayuno prolongado.

C) Tabaquismo; Vareniclina.

D) Zollinger-Ellison; Octreótide.

Retroalimentación:

Dato clave: El dolor de la úlcera duodenal "mejora con la comida" (el alimento cierra el píloro y el bicarbonato neutraliza), mientras que la gástrica suele empeorar. El estándar para detectar H. pylori durante la endoscopia es la prueba rápida de ureasa o la biopsia.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA (NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 693

Paciente de 28 años con VIH y conteo de CD4 de 80 células/mm^3. Presenta disnea progresiva de 2 semanas, tos seca y fiebre. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales "en vidrio despulido" que respetan los ápices. La gasometría reporta hipoxemia severa.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento de primera elección para esta infección oportunista?

A) Trimetoprima / Sulfametoxazol (TMP/SMX) a dosis altas. *

B) Levofloxacino.

C) Anfotericina B.

D) Pentamidina inhalada únicamente.

Pregunta 2

¿Cuál es el criterio clínico o gasométrico para añadir prednisona al tratamiento de este paciente?

A) Presión parcial de oxígeno (PaO2) < 70 mmHg o Gradiente alvéolo-arterial de O2 > 35 mmHg. *

B) Fiebre > 39°C.

C) Presencia de tos productiva.

D) Candidiasis oral asociada.

Retroalimentación:

La neumonía por Pneumocystis es la infección oportunista definitoria de SIDA más común. El uso de esteroides en casos moderados-graves disminuye la respuesta inflamatoria exacerbada que ocurre al morir los microorganismos por el antibiótico, mejorando la supervivencia.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: HEMATOLOGÍA (LINFOMA DE HODGKIN)

Dificultad: Media

Caso Clínico 694

Hombre de 25 años acude por notar crecimiento de un ganglio cervical derecho, no doloroso, de consistencia elástica. Refiere fiebre vespertina, sudoración nocturna profusa y pérdida del 10% de su peso en los últimos 4 meses (Síntomas B).

Pregunta 1

¿Qué hallazgo histopatológico es característico y diagnóstico en la biopsia de ganglio linfático?

A) Células de Reed-Sternberg (en "ojos de búho"). *

B) Células en "cielo estrellado".

C) Bastones de Auer.

D) Sombras de Gumprecht.

Retroalimentación:

El linfoma de Hodgkin tiene una distribución bimodal (picos en jóvenes y adultos mayores). El síntoma de "dolor en los ganglios tras la ingesta de alcohol" (Signo de Hoster) es muy sugerente de esta patología aunque poco frecuente.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: CARDIOLOGÍA (ESTENOSIS MITRAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 695

Mujer de 48 años con antecedente de fiebre reumática en la infancia. Acude por disnea de medianos esfuerzos y palpitaciones. A la exploración física se ausculta un

chasquido de apertura seguido de un retumbo diastólico en el ápex. Presenta un primer ruido (S1) brillante.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más frecuente de esta valvulopatía y qué hallazgo se esperaría encontrar en el electrocardiograma?

A) Fiebre Reumática; Crecimiento de la aurícula izquierda (onda P ancha y con muesca en DII). *

B) Degeneración senil; Bloqueo de rama derecha.

C) Endocarditis bacteriana; Elevación del segmento ST.

D) Miocardiopatía hipertrófica; Ondas Q patológicas.

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación arrítmica más frecuente asociada a la dilatación auricular en esta patología?

A) Fibrilación auricular. *

B) Taquicardia supraventricular paroxística.

C) Bloqueo AV de tercer grado.

D) Ritmo idioventricular acelerado.

Retroalimentación:

La estenosis mitral "reumática" es el clásico del ENARM. El aumento de presión en la aurícula izquierda se transmite retrógradamente a los pulmones, causando disnea. La dilatación de la aurícula izquierda es el sustrato perfecto para la fibrilación auricular y la formación de trombos.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUMOLOGÍA (DERRAME PLEURAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 700

Hombre de 62 años con antecedente de insuficiencia cardiaca congestiva acude por disnea progresiva. A la exploración se observa abolición del murmullo vesicular y matidez a la percusión en la base derecha. Se realiza toracocentesis diagnóstica.

Pregunta 1

¿Qué criterios se utilizan para diferenciar un trasudado de un exudado y cuál es el hallazgo esperado en este paciente?

A) Criterios de Light; Trasudado (Relación Proteínas pleura/suero <0.5). *

B) Criterios de Jones; Exudado.

C) Criterios de Wells; Trasudado.

D) Criterios de Duke; Empiema.

Pregunta 2

Si el líquido pleural presentara un aspecto hemático, pH <7.2 y glucosa <60 mg/dL en un paciente fumador, ¿cuál sería la principal sospecha?

A) Derrame paraneoplásico (Cáncer). *

B) Insuficiencia renal.

C) Cirrosis hepática.

D) Insuficiencia cardiaca compensada.

Retroalimentación:

Los criterios de Light son la regla de oro: el trasudado ocurre por desequilibrio de presiones hidrostáticas/oncóticas (como en la ICC), mientras que el exudado implica daño capilar o inflamación (neumonía, cáncer, TB).

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUROLOGÍA (ESCLEROSIS MÚLTIPLE)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 705

Mujer de 26 años presenta pérdida súbita de la visión en el ojo izquierdo y dolor al mover el globo ocular (neuritis óptica). Refiere que hace un año tuvo un episodio de debilidad en la pierna derecha que resolvió solo en dos semanas. A la exploración presenta el fenómeno de Uhthoff (empeoramiento de síntomas con el calor).

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de imagen de elección para el diagnóstico y qué hallazgo se esperaría encontrar?

A) Resonancia Magnética (RM); Placas de desmielinización periventriculares (dedos de Dawson). *

B) Tomografía Axial Computarizada (TAC); Infartos lacunares.

C) Ultrasonido Doppler carotídeo; Estenosis arterial.

D) Radiografía de cráneo; Calcificaciones.

Retroalimentación Pregunta 1:

La RM es la prueba más sensible para detectar las lesiones desmielinizantes en el sistema nervioso central. Los "dedos de Dawson" son lesiones ovoides perpendiculares a los ventrículos laterales, características de la Esclerosis Múltiple (EM).

Pregunta 2

¿Qué hallazgo en el análisis del Líquido Cefalorraquídeo (LCR) apoyaría el diagnóstico de EM?

A) Bandas oligoclonales de IgG. *

B) Disociación albúmino-citológica.

C) Pleocitosis neutrofílica severa.

D) Glucosa disminuida y proteínas normales.

Retroalimentación Pregunta 2:

La presencia de bandas oligoclonales de IgG en el LCR (que no están presentes en el suero) indica una síntesis intratecal de anticuerpos, presente en el 85-95% de los pacientes con EM.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA (ENFERMEDAD DE LYME)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 706

Hombre de 30 años que recientemente viajó a una zona boscosa en el noreste de EE. UU. Presenta una lesión cutánea eritematosa de expansión centrífuga con un centro claro ("ojo de buey") en el muslo, acompañada de malestar general y mialgias.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y cuál es el vector responsable de la transmisión?

A) Borrelia burgdorferi; Garrapata del género Ixodes. *

B) Rickettsia rickettsii; Garrapata Dermacentor.

C) Leptospira interrogans; Orina de rata.

D) Francisella tularensis; Moscas de los ciervos.

Retroalimentación Pregunta 1:

La enfermedad de Lyme es causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi. El signo patognomónico de la etapa temprana es el eritema migratorio (la lesión en "ojo de buey").

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección para la etapa temprana de la enfermedad de Lyme?

A) Doxiciclina por 10 a 14 días. *

B) Penicilina G benzatínica dosis única.

C) Ciprofloxacino.

D) Metronidazol.

Retroalimentación Pregunta 2:

La doxiciclina es el estándar de oro para adultos. En niños menores de 8 años o mujeres embarazadas, la alternativa de elección es la Amoxicilina.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: GASTROENTEROLOGÍA (ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL - CUCI)

Dificultad: Media

Caso Clínico 707

Hombre de 28 años presenta diarrea crónica con moco y sangre (hasta 8 evacuaciones al día), dolor abdominal tipo cólico y tenesmo rectal. La colonoscopia muestra una mucosa rectal granular, eritematosa, que sangra al contacto, con afectación continua y presencia de pseudopólipos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el marcador serológico más frecuentemente asociado?

A) Colitis Ulcerativa Crónica Idiopática (CUCI); p-ANCA positivo. *

B) Enfermedad de Crohn; ASCA positivo.

C) Síndrome de Intestino Irritable; Marcadores negativos.

D) Amibiasis intestinal; Trofozoítos.

Retroalimentación Pregunta 1:

El CUCI afecta de forma continua la mucosa y submucosa, iniciando siempre en el recto y extendiéndose proximalmente. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos con patrón perinuclear (p-ANCA) se asocian frecuentemente al CUCI (60-70%).

Pregunta 2

¿Cuál es la complicación aguda más grave y potencialmente mortal del CUCI?

A) Megacolon tóxico. *

B) Fístulas perianales.

C) Adenocarcinoma de colon.

D) Estenosis esofágica.

Retroalimentación Pregunta 2:

El megacolon tóxico es una dilatación no obstructiva del colon (>6 cm) asociada a signos de toxicidad sistémica. Es una urgencia médica que puede requerir colectomía total si no responde al tratamiento.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA (LEPRA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 708

Hombre de 50 años residente de zona rural. Presenta una placa cutánea hipopigmentada, de bordes elevados, bien definidos, con pérdida de la sensibilidad (anestesia) y ausencia de vello en la lesión. A la exploración se palpa engrosamiento del nervio cubital.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y cómo se clasifica esta variante de la enfermedad según la respuesta inmune?

A) Mycobacterium leprae; Lepra Tuberculoide (respuesta Th1 fuerte). *

B) Mycobacterium avium; Lepra Lepromatosa.

C) Bacillus anthracis; Ántrax cutáneo.

D) Treponema pallidum; Sífilis secundaria.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Lepra Tuberculoide se caracteriza por pocas lesiones, bien delimitadas y con anestesia debido a una buena respuesta celular que limita la diseminación del bacilo pero causa daño neural local.

Pregunta 2

¿Cuál es el esquema de tratamiento recomendado por la OMS para la lepra paucibacilar (tuberculoide)?

A) Rifampicina y Dapsona por 6 meses. *

B) Rifampicina, Dapsona y Clofazimina por 12 meses.

C) Solo Isoniacida por 9 meses.

D) Estreptomicina y Etambutol.

Retroalimentación Pregunta 2:

Para casos paucibacilares (1 a 5 lesiones) se usa el esquema doble (Rifampicina/Dapsona). Los casos multibacilares requieren el esquema triple incluyendo Clofazimina por un año.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: GASTROENTEROLOGÍA (ENFERMEDAD DE CROHN)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 709

Mujer de 30 años presenta dolor abdominal en fosa iliaca derecha, pérdida de peso, fiebre y diarrea no sanguinolenta. Refiere antecedentes de fístulas perianales recurrentes. La colonoscopia muestra áreas de mucosa sana alternadas con áreas de inflamación ("empedrado") y afectación transmural.

Pregunta 1

¿Cuál es la localización más frecuente de la enfermedad de Crohn y qué hallazgo histopatológico es característico?

A) Íleon terminal y ciego; Granulomas no caseificantes. *

B) Recto y sigmoides; Criptitis.

C) Esófago; Células de Barrett.

D) Estómago; Atrofia glandular.

Retroalimentación Pregunta 1:

A diferencia del CUCI, el Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo (desde la boca al ano), es segmentaria (lesiones salteadas) y afecta todas las capas de la pared intestinal (transmural), lo que explica la formación de fístulas.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de inducción de elección para un brote moderado-grave de enfermedad de Crohn?

A) Glucocorticoides (Prednisona o Budesonida) y/o terapia biológica (Anti-TNF). *

B) Sulfasalazina únicamente.

C) Loperamida a dosis altas.

D) Cirugía inmediata (proctocolectomía).

Retroalimentación Pregunta 2:

Los esteroides son eficaces para inducir la remisión, pero no para mantenerla. En pacientes con enfermedad refractaria o fistulizante, los fármacos anti-TNF (como Infliximab) han revolucionado el manejo.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: REUMATOLOGÍA (ESPONDILITIS ANQUILOSANTE)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 710

Varón de 24 años presenta dolor lumbar de inicio insidioso de 8 meses de evolución. El dolor es peor por las mañanas, se acompaña de rigidez matutina de 2 horas y, a diferencia del dolor mecánico, MEJORA con el ejercicio y empeora con el reposo. A la exploración se observa limitación de la movilidad de la columna lumbar (Prueba de Schöber positiva).

Pregunta 1

¿Cuál es el marcador genético asociado en más del 90% de los casos y cuál es el hallazgo radiológico inicial más importante para el diagnóstico?

A) HLA-B27; Sacroilitis bilateral. *

B) HLA-DR4; Erosiones en carpo.

C) Factor Reumatoide; Sindesmofitos marginales.

D) ANA; Vértebras en "marfil".

Retroalimentación Pregunta 1:

La espondilitis anquilostante es la espondiloartropatía seronegativa prototípica. El diagnóstico requiere la presencia de sacroilitis (inflamación de las articulaciones sacroiliacas) demostrada por imagen, frecuentemente asociada al antígeno HLA-B27.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea para el control del dolor y la rigidez en pacientes con enfermedad axial activa?

A) Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs) a dosis plenas. *

B) Glucocorticoides sistémicos a dosis altas.

C) Metotrexato.

D) Ciclofosfamida.

Retroalimentación Pregunta 2:

A diferencia de la Artritis Reumatoide, los AINEs son la piedra angular del tratamiento inicial en la espondilitis y pueden frenar la progresión radiológica. Si no hay respuesta, se escala directamente a terapia biológica (Anti-TNF), ya que los FARME convencionales como el Metotrexato no tienen eficacia probada en la enfermedad axial.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: REUMATOLOGÍA (GOTA / ARTRITIS POR MICROCRISTALES)

Dificultad: Media

Caso Clínico 711

Hombre de 52 años, con antecedente de HAS tratada con tiazidas y consumo frecuente de carnes rojas. Acude por dolor insoportable, eritema y tumefacción de inicio súbito en la primera articulación metatarsofalángica (podagra).

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo patognomónico en el análisis del líquido sinovial mediante microscopía de luz polarizada?

A) Cristales de urato monosódico con forma de aguja y birrefringencia negativa. *

B) Cristales de pirofosfato cálcico con forma de rombo y birrefringencia positiva.

C) Cristales de oxalato cálcico en forma de sobre.

D) Presencia de abundantes piocitos sin cristales.

Retroalimentación Pregunta 1:

La gota es causada por el depósito de cristales de urato. La birrefringencia negativa significa que los cristales se ven amarillos cuando están paralelos al eje del compensador de luz, lo cual confirma el diagnóstico de forma definitiva.

Pregunta 2

¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo del ataque agudo de gota y qué fármaco está contraindicado iniciar durante la crisis aguda si el paciente no lo tomaba previamente?

A) Colchicina o AINEs; Alopurinol. *

B) Alopurinol; Colchicina.

C) Febuxostat; Prednisona.

D) Aspirina a dosis bajas; Naproxeno.

Retroalimentación Pregunta 2:

Durante el ataque agudo, el objetivo es desinflamar. No se debe iniciar Alopurinol porque el descenso brusco de ácido úrico sérico puede movilizar los depósitos articulares y prolongar o exacerbar la crisis. La aspirina a dosis bajas también se evita porque compite con la excreción de ácido úrico.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: ENDOCRINOLOGÍA (FEOCROMOCITOMA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 712

Mujer de 35 años presenta crisis paroxísticas de cefalea intensa, sudoración profusa y palpitaciones (tríada clásica). Durante los episodios, se documentan cifras tensionales de 190/110 mmHg. Entre las crisis, la paciente se encuentra asintomática.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio inicial más sensible para el tamizaje de este tumor productor de catecolaminas?

A) Medición de metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas o en plasma. *

B) Cortisol libre urinario.

C) Ácido vanilmandélico en orina únicamente.

D) Ultrasonido renal.

Retroalimentación Pregunta 1:

Las metanefrinas (metabolitos de la adrenalina y noradrenalina) tienen una sensibilidad superior al 95%. El ácido vanilmandélico es menos sensible y suele dar más falsos negativos.

Pregunta 2

¿Cuál es el orden correcto del bloqueo farmacológico previo a la cirugía para evitar una crisis hipertensiva intraoperatoria?

A) Primero alfa-bloqueo (Fenoxibenzamina o Prazosina) y después beta-bloqueo (Propanolol). *

B) Primero beta-bloqueo y después alfa-bloqueo.

C) Solo beta-bloqueadores.

D) Nitroprusiato de sodio como único fármaco.

Retroalimentación Pregunta 2:

Es vital bloquear primero los receptores ALFA. Si se bloquean primero los beta, la estimulación alfa sin oposición causaría una vasoconstricción masiva y una crisis hipertensiva potencialmente mortal.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA (FIEBRE TIFOIDEA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 713

Hombre de 28 años presenta fiebre que ha ido aumentando de forma escalonada hasta 39.5°C, dolor abdominal, estreñimiento inicial seguido de diarrea "en puré de guisantes" y bradicardia relativa (Signo de Faget). A la exploración se observan manchas rosáceas en el tronco (roséola tifoídica).

Pregunta 1

¿Cuál es el agente causal y cuál es el estudio diagnóstico con mayor sensibilidad durante la primera semana de la enfermedad?

A) Salmonella typhi; Hemocultivo. *

B) Salmonella enteritidis; Coprocultivo.

C) Rickettsia typhi; Reacciones febriles.

D) Shigella sonnei; Mielocultivo.

Retroalimentación Pregunta 1:

En la primera semana, el hemocultivo es positivo en el 90% de los casos. Las reacciones febriles (Widal) no se recomiendan actualmente por su baja especificidad en zonas endémicas. El mielocultivo es el más sensible de todos (95%), pero es invasivo.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea según la GPC para casos de fiebre tifoidea no complicada?

A) Ciprofloxacino o Cefixima. *

B) Cloranfenicol únicamente.

C) Amoxicilina.

D) Trimetoprima/Sulfametoxazol.

Retroalimentación Pregunta 2:

Las fluoroquinolonas son los fármacos de elección por su excelente penetración intracelular y efectividad contra S. typhi, aunque se debe vigilar la resistencia creciente.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: INFECTOLOGÍA (CÓLERA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 714

Paciente masculino de 40 años presenta evacuaciones líquidas abundantes, súbitas, sin dolor, con aspecto de "agua de arroz" y olor a pescado. Presenta signos de deshidratación grave (ojos hundidos, signo del lienzo, anuria).

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la toxina del Vibrio cholerae?

A) Aumento de los niveles intracelulares de AMP cíclico (AMPc), provocando secreción activa de cloro y agua. *

B) Destrucción directa de los enterocitos (invasión).

C) Inhibición de la síntesis de proteínas.

D) Bloqueo de los receptores de acetilcolina.

Retroalimentación Pregunta 1:

La toxina colérica activa de forma permanente la adenilato ciclasa, lo que lleva a una salida masiva de electrolitos y agua hacia la luz intestinal sin daño estructural a la mucosa.

Pregunta 2

¿Cuál es la medida más importante en el manejo del cólera y qué antibiótico se recomienda para reducir la duración de la diarrea y la excreción del bacilo?

A) Rehidratación agresiva (Plan C de la OMS); Doxiciclina (dosis única). *

B) Antibióticos IV; Loperamida.

C) Ayuno absoluto; Metronidazol.

D) Soluciones glucosas únicamente; Eritromicina.

Retroalimentación Pregunta 2:

La muerte en el cólera ocurre por choque hipovolémico, por lo que la hidratación es la prioridad absoluta. La doxiciclina en dosis única es el tratamiento de elección para acortar el cuadro y disminuir la carga ambiental del patógeno.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: HEMATOLOGÍA (LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA - LMA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 715

Hombre de 45 años acude por fatiga, fiebre, equimosis espontáneas y sangrado gingival. La biometría hemática reporta: Hemoglobina 7.5 g/dL, Plaquetas 20,000/mm^3 y Leucocitos 45,000/mm^3 con 40% de blastos. En el frotis de sangre periférica se observan inclusiones citoplasmáticas en forma de aguja (Bastones de Auer).

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la variante (clasificación FAB) que se asocia con la translocación t(15;17) y riesgo elevado de Coagulación Intravascular Diseminada (CID)?

A) Leucemia Mieloide Aguda; Variante M3 (Promielocítica). *

B) Leucemia Linfoide Aguda; Variante L1.

C) Leucemia Mieloide Crónica; Cromosoma Filadelfia.

D) Leucemia Monocítica; Variante M5.

Retroalimentación Pregunta 1:

La presencia de Bastones de Auer es patognomónica de la línea mieloide. La variante M3 (Promielocítica) es una urgencia médica porque los gránulos de los promielocitos liberan sustancias procoagulantes que desencadenan CID.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento específico de elección para la Leucemia Promielocítica Aguda (M3) que induce la diferenciación de los blastos?

A) Ácido holo-trans-retinoico (ATRA) + Trióxido de arsénico. *

B) Citarabina + Idarubicina (Esquema 7+3).

C) Imatinib.

D) Rituximab.

Retroalimentación Pregunta 2:

El ATRA logra "forzar" a los promielocitos a madurar, controlando rápidamente el riesgo de sangrado y CID, lo que ha cambiado drásticamente el pronóstico de esta variante.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUROLOGÍA (MIASTENIA GRAVIS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 719

Mujer de 28 años refiere caída de ambos párpados (ptosis palpebral) y visión doble (diplopía) que empeoran al final del día o tras lectura prolongada. Niega dolor o alteraciones sensitivas. Al examen físico, la ptosis mejora notablemente tras la aplicación de hielo local sobre los párpados por 2 minutos.

Pregunta 1

¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad y cuál es el estudio serológico de primera elección?

A) Anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (anti-AChR) en la unión neuromuscular. *

B) Destrucción de la mielina por linfocitos T.

C) Déficit de producción de dopamina en la sustancia negra.

D) Anticuerpos contra canales de calcio presinápticos.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Miastenia Gravis es un trastorno autoinmune postsináptico. Los anticuerpos bloquean o destruyen los receptores de acetilcolina, causando fatiga muscular patológica. La prueba del hielo es útil porque el frío inhibe la acetilcolinesterasa, aumentando la disponibilidad del neurotransmisor.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico sintomático de primera línea y qué estudio de imagen es obligatorio realizar tras el diagnóstico?

A) Piridostigmina; TAC de tórax para buscar Timoma. *

B) Prednisona; Resonancia Magnética de cráneo.

C) Neostigmina; Ultrasonido de tiroides.

D) Plasmaféresis; Gammagrama óseo.

Retroalimentación Pregunta 2:

La piridostigmina (inhibidor de la colinesterasa) mejora la fuerza muscular. Es obligatorio descartar patología tímica (hiperplasia o timoma), ya que el timo juega un papel central en la patogenia y su resección puede inducir remisión.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUMOLOGÍA (SARCOIDOSIS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 720

Mujer de 34 años de edad acude por tos seca, disnea de esfuerzo y lesiones eritematosas dolorosas en la región pretibial (eritema nodoso). La radiografía de tórax muestra linfadenopatía hiliar bilateral simétrica.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo histopatológico característico en la biopsia de los ganglios afectados?

A) Granulomas no caseificantes. *

B) Granulomas con necrosis de licuefacción (caseificantes).

C) Células de Reed-Sternberg.

D) Infiltrado de eosinófilos masivo.

Retroalimentación Pregunta 1:

La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida. El hallazgo de granulomas "limpios" (sin necrosis) es la clave diagnóstica, diferenciándola de la tuberculosis.

Pregunta 2

¿Cómo se denomina el síndrome caracterizado por la tríada de eritema nodoso, linfadenopatía hiliar y artralgias, el cual sugiere un pronóstico favorable?

A) Síndrome de Löfgren. *

B) Síndrome de Heerfordt.

C) Síndrome de Goodpasture.

D) Síndrome de Kartagener.

Retroalimentación Pregunta 2:

El síndrome de Löfgren es una forma aguda de sarcoidosis con excelente pronóstico, que generalmente no requiere tratamiento agresivo a largo plazo ya que suele remitir espontáneamente.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: ENDOCRINOLOGÍA (INSUFICIENCIA SUPRARRENAL / ADDISON)

Dificultad: Media

Caso Clínico 721

Hombre de 42 años con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada. Acude por debilidad crónica, pérdida de peso, náuseas y una coloración oscura en la piel (hiperpigmentación), especialmente en encías y cicatrices. Laboratorios: Na+ 130 mEq/L (bajo), K+ 5.8 mEq/L (alto).

Pregunta 1

¿Cuál es la prueba diagnóstica estándar para confirmar la insuficiencia suprarrenal primaria?

A) Prueba de estimulación con ACTH (Cosintropina). *

B) Medición de cortisol matutino únicamente.

C) Prueba de supresión con dexametasona.

D) Niveles de aldosterona en bipedestación.

Retroalimentación Pregunta 1:

En la enfermedad de Addison (primaria), la glándula suprarrenal no responde al estímulo de la ACTH. Si tras administrar ACTH sintética el cortisol no se eleva por encima de 18 mcg/dL, se confirma el diagnóstico.

Pregunta 2

¿Cuál es la causa de la hiperpigmentación cutánea en estos pacientes?

A) Elevación de ACTH que estimula los receptores de melanocitos debido a la homología con la MSH. *

B) Depósito de hierro en la piel.

C) Deficiencia de Vitamina B12.

D) Exceso de producción de bilirrubina.

Retroalimentación Pregunta 2:

La falta de retroalimentación negativa por el cortisol eleva masivamente la proopiomelanocortina (POMC), precursora de la ACTH y de la hormona estimulante de melanocitos (MSH), lo que produce el tinte "broncíneo" característico.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: NEUMOLOGÍA (FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA - FPI)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 722

Hombre de 68 años, ex-fumador, con disnea progresiva de 1 año de evolución y tos seca. A la auscultación presenta estertores tipo "velcro" en ambas bases pulmonares. Presenta acropaquia (dedos en palillo de tambor).

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo característico en la Tomografía de Alta Resolución (TACAR) que define el patrón de Neumonía Intersticial Usual (NIU)?

A) Opacidades en "panal de abeja" y bronquiectasias por tracción. *

B) Vidrio despulido difuso sin fibrosis.

C) Nódulos centrolobulillares.

D) Consolidaciones migratorias.

Retroalimentación Pregunta 1:

El patrón de panal de abeja (honeycombing) representa el estadio final de la fibrosis pulmonar y es esencial para el diagnóstico de FPI en el contexto clínico adecuado, evitando a menudo la biopsia quirúrgica.

Pregunta 2

¿Cuál es el patrón funcional respiratorio esperado en la espirometría de este paciente?

A) Patrón restrictivo (FVC disminuida, FEV1/FVC normal o elevada). *

B) Patrón obstructivo (FEV1/FVC < 0.7).

C) Patrón mixto con respuesta a broncodilatador.

D) Espirometría normal con capacidad de difusión de CO (DLCO) elevada.

Retroalimentación Pregunta 2:

Las enfermedades intersticiales reducen los volúmenes pulmonares pero no obstruyen el flujo, por lo que el cociente FEV1/FVC se mantiene preservado o incluso aumenta debido a la retracción elástica aumentada del pulmón fibroso.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: CARDIOLOGÍA (PERICARDITIS AGUDA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 723

Hombre de 32 años presenta dolor torácico punzante que aumenta con la inspiración profunda y al toser. El dolor mejora notablemente cuando el paciente se inclina hacia adelante (posición mahometana). Antecedente de cuadro gripal hace 1 semana.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo característico en el electrocardiograma durante la fase inicial de esta patología?

A) Elevación difusa del segmento ST con concavidad superior y depresión del segmento PR. *

B) Descenso del segmento ST en derivaciones precordiales.

C) Presencia de ondas Q patológicas.

D) Bloqueo de rama izquierda de nueva aparición.

Retroalimentación Pregunta 1:

La elevación del ST en la pericarditis es "difusa" (no sigue un territorio vascular coronario) y tiene forma de "silla de montar". La depresión del segmento PR es un signo muy específico de inflamación pericárdica atrial inicial.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea para prevenir las recurrencias en la pericarditis aguda idiopática o viral?

A) AINEs (Aspirina o Ibuprofeno) + Colchicina. *

B) Glucocorticoides a dosis altas de inicio.

C) Antibióticos de amplio espectro.

D) Pericardiocentesis inmediata.

Retroalimentación Pregunta 2:

La colchicina añadida a los AINEs ha demostrado reducir a la mitad la tasa de recurrencias. Los esteroides se reservan solo si hay contraindicación para AINEs o en causas autoinmunes específicas, ya que aumentan el riesgo de que la pericarditis se vuelva crónica.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: HEMATOLOGÍA (MIELOMA MÚLTIPLE)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 727

Hombre de 68 años acude por dolor óseo persistente en columna lumbar y fatiga. Laboratorios: Hemoglobina 9.2 g/dL, Creatinina 2.1 mg/dL, Calcio sérico 11.5 mg/dL. La radiografía de cráneo muestra múltiples lesiones osteolíticas en "sacabocado".

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo esperado en la electroforesis de proteínas y qué se observaría en el frotis de sangre periférica?

A) Pico monoclonal (Proteína M); Fenómeno de Rouleaux (pilas de monedas). *

B) Disminución de gammaglobulinas; Blastos con bastones de Auer.

C) Elevación de ferritina; Esquistocitos.

D) Pancitopenia severa; Células en diana.

Retroalimentación Pregunta 1:

El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal. El exceso de esta proteína altera la carga de los eritrocitos, provocando que se agreguen en "pilas de monedas" (Rouleaux). La

mnemotecnia para el daño de órgano blanco es CRAB: Calcio alto, Renal (falla), Anemia y Bone (hueso/lesiones).

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio definitivo para confirmar el diagnóstico y qué hallazgo se considera diagnóstico?

A) Aspirado y biopsia de médula ósea; >10% de células plasmáticas clonales. *

B) Biopsia de ganglio linfático; Células de Reed-Sternberg.

C) Gamagrama óseo con tecnecio 99.

D) Niveles de eritropoyetina elevados.

Retroalimentación Pregunta 2:

El aspirado de médula ósea es esencial. Nota importante para el ENARM: El gamagrama óseo suele ser NORMAL en el mieloma porque detecta actividad osteoblástica y el mieloma es puramente osteolítico; por ello, se prefieren las radiografías simples (serie ósea) o TAC.

Tema: MEDICINA INTERNA

Subtema: HEMATOLOGÍA (ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 731

Mujer de 32 años con antecedente de Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Acude por ictericia, fatiga y orina oscura. Laboratorios: Hb 7.0 g/dL, Reticulocitos 12% (elevados), Bilirrubina indirecta elevada y Haptoglobina muy baja. En el frotis se observan esferocitos.

Pregunta 1

¿Cuál es la prueba inmunológica de elección para confirmar el diagnóstico y qué resultado se espera encontrar?

A) Prueba de Coombs Directo; Positivo para IgG y/o C3. *

B) Prueba de Coombs Indirecto; Positivo para anticuerpos circulantes.

C) Prueba de fragilidad osmótica; Aumentada.

D) Electroforesis de hemoglobina; Presencia de HbS.

Retroalimentación Pregunta 1:

La prueba de Coombs directo detecta anticuerpos o complemento ya fijados a la membrana del eritrocito "in vivo". En el contexto de una enfermedad autoinmune como el LES, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes (IgG) es la más frecuente.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea para inducir la remisión en esta paciente?

A) Glucocorticoides (Prednisona). *

B) Esplenectomía inmediata.

C) Transfusión de concentrado eritrocitario de urgencia únicamente.

D) Rituximab como primera opción.

Retroalimentación Pregunta 2:

Los esteroides son la base del tratamiento inicial ya que disminuyen la producción de anticuerpos y la depuración esplénica de los eritrocitos sensibilizados. La transfusión debe evitarse a menos que haya compromiso hemodinámico, debido a la dificultad para encontrar pruebas cruzadas compatibles.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA CERVICAL (VPH Y DISPLASIAS)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 736

Mujer de 28 años acude a su revisión anual. El reporte de citología cervical (Papanicolaou) informa: Lesión Intraepitelial Escamosa de Bajo Grado (LIEBG / NIC 1). La paciente se encuentra asintomática y no tiene antecedentes de importancia.

Pregunta 1

Según la GPC, ¿cuál es la conducta a seguir en una paciente de esta edad con reporte de LIEBG?

A) Realizar Colposcopia de forma inmediata. *

B) Repetir citología en 3 meses.

C) Histerectomía total abdominal.

D) Criocirugía inmediata sin más estudios.

Retroalimentación Pregunta 1:

Ante cualquier reporte de lesión intraepitelial (ya sea de bajo o alto grado), el siguiente paso estándar es la colposcopia para localizar la lesión y realizar una biopsia dirigida si es necesario. El tratamiento definitivo depende del resultado histopatológico (biopsia), no solo de la citología.

Pregunta 2

¿Cuáles son los serotipos de Virus del Papiloma Humano (VPH) considerados de alto riesgo oncogénico más frecuentemente asociados al cáncer cervicouterino?

A) 16 y 18. *

B) 6 y 11.

C) 1 y 2.

D) 31 y 33 (aunque son de alto riesgo, el 16 y 18 son los principales).

Retroalimentación Pregunta 2:

Los serotipos 16 y 18 son responsables de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cérvix a nivel mundial. Por el contrario, los tipos 6 y 11 son de bajo riesgo y se asocian principalmente a verrugas genitales (condilomas).

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: PATOLOGÍA VESICULAR (COLECITITIS AGUDA)

Dificultad: Media

Caso Clínico 740

Mujer de 42 años, con obesidad e ingesta reciente de alimentos colecistoquinéticos (grasas). Acude por dolor intenso en hipocondrio derecho, náuseas y fiebre de 38.2°C. A la exploración presenta signo de Murphy positivo. Laboratorios: Leucocitosis de 14,000 cel/mm^3.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de imagen inicial de elección y qué hallazgos confirmarían el diagnóstico?

A) Ultrasonido de hígado y vías biliares; Pared vesicular >4 mm, lito encarcelado y líquido perivesicular. *

B) Tomografía Axial Computarizada (TAC); Presencia de gas en la pared.

C) Radiografía simple de abdomen; Niveles hidroaéreos.

D) Gammagrama con HIDA.

Retroalimentación Pregunta 1:

El ultrasonido tiene una sensibilidad >90% para colecystitis. Los criterios diagnósticos de Tokio (2018) consideran el Murphy, la fiebre/leucocitosis y los hallazgos ecográficos como los pilares del diagnóstico.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección según la GPC y cuál es el momento ideal para realizarlo en un Grado I (leve)?

A) Colecistectomía laparoscópica; En las primeras 72 horas. *

B) Colecistectomía abierta; Después de 6 semanas de antibiótico.

C) CPRE (Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica).

D) Litotricia extracorpórea.

Retroalimentación Pregunta 2:

La tendencia actual y la GPC dictan que la cirugía temprana (laparoscópica) reduce los días de estancia hospitalaria y las complicaciones en comparación con el manejo diferido, siempre que las condiciones del paciente lo permitan.

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: OCLUSIÓN INTESTINAL (INTESTINO DELGADO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 743

Mujer de 65 años con antecedente de histerectomía hace 10 años. Acude por dolor abdominal tipo cólico, vómitos de contenido biliar y ausencia de evacuaciones y flatulencias de 24 horas. A la exploración: abdomen distendido, ruidos peristálticos aumentados (de lucha) y timpanismo.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa número uno de obstrucción de intestino delgado en pacientes con cirugía previa y qué hallazgo radiológico esperaría encontrar?

A) Adherencias (Bridas); Niveles hidroaéreos y ausencia de gas en colon. *

B) Hernias incarceradas; Imagen en "grano de café".

C) Íleo biliar; Neumobilia.

D) Vólvulo de sigmoides; Imagen en "U" invertida.

Retroalimentación Pregunta 1:

Las bridas son la causa más frecuente (60-70%) tras cirugías abdominales. Radiológicamente, las "asas en niveles" y el signo de "pila de monedas" (edema de válvulas conviventes) confirman la obstrucción mecánica.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial recomendado en una obstrucción parcial o completa sin signos de estrangulamiento (fiebre, taquicardia, irritación peritoneal)?

A) Ayuno, descompresión con sonda nasogástrica (SNG) y rehidratación IV. *

B) Laparotomía exploradora inmediata.

C) Administración de laxantes osmóticos.

D) Colonoscopia descompresiva.

Retroalimentación Pregunta 2:

Hasta el 80% de las obstrucciones por bridas resuelven con manejo conservador. El uso de la SNG disminuye la distensión y el riesgo de broncoaspiración. Si tras 48-72 horas no hay mejoría, se indica cirugía.

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: ENFERMEDAD DIVERTICULAR (DIVERTICULITIS AGUDA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 747

Hombre de 62 años presenta dolor intenso en fosa iliaca izquierda ("la apendicitis del lado izquierdo"), fiebre de 38.5°C y estreñimiento. La tomografía abdominal muestra inflamación del sigmoides y una colección de pus de 5 cm adyacente al colon.

Pregunta 1

Según la clasificación de Hinchey modificada, ¿en qué estadio se encuentra este paciente y cuál es el manejo de elección para la colección?

A) Estadio Ib (Absceso pericólico distante o pélvico); Drenaje percutáneo guiado por imagen + Antibióticos. *

B) Estadio Ia (Inflamación pericólica); Dieta líquida y antibióticos orales.

C) Estadio III (Peritonitis purulenta); Cirugía de Harttman.

D) Estadio IV (Peritonitis fecaloide); Resección y anastomosis primaria.

Retroalimentación Pregunta 1:

La escala de Hinchey es vital: Ia es solo inflamación; Ib es absceso cercano (<5 cm); II es absceso pélvico o distante (>5 cm); III es peritonitis purulenta y IV es fecaloide. Los abscesos >5 cm o que no responden a antibióticos requieren drenaje percutáneo antes de pensar en cirugía.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de imagen estándar de oro para el diagnóstico de diverticulitis aguda y qué estudio está CONTRAINDICADO en la fase aguda por riesgo de perforación?

A) TAC de abdomen con contraste; Colonoscopia y Enema opaco. *

B) Ultrasonido abdominal; Radiografía simple.

C) Resonancia Magnética; Marcadores tumorales.

D) Laparoscopia diagnóstica; Tacto rectal.

Retroalimentación Pregunta 2:

La TAC permite ver la extensión de la inflamación y clasificar con Hinchey. La colonoscopia está prohibida en el episodio agudo debido a que la insuflación de aire puede convertir una microperforación en una perforación libre. Se recomienda realizarla 6 semanas después.

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: PATOLOGÍA ESOFÁGICA (ACALASIA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 750

Mujer de 35 años presenta disfagia progresiva a sólidos y líquidos de un año de evolución, regurgitación de alimentos no digeridos y pérdida de peso de 5 kg. La serie esófago-gastro-duodenal muestra una dilatación del cuerpo esofágico con estrechez distal en "punta de lápiz" o "pico de pájaro".

Pregunta 1

¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de Acalasia y qué hallazgo se considera patognomónico?

A) Manometría esofágica de alta resolución; Ausencia de peristalsis y falta de relajación del esfínter esofágico inferior (EEI). *

B) Endoscopia de tubo digestivo alto; Presencia de divertículo de Zenker.

C) pH-metría de 24 horas; Exposición ácida prolongada.

D) TAC de tórax; Engrosamiento de la pared gástrica.

Retroalimentación Pregunta 1:

La acalasia es un trastorno motor caracterizado por la falla en la relajación del EEI debido a la pérdida de plexos mientéricos (Auerbach). Aunque la radiografía es sugerente, la manometría es la que confirma el diagnóstico de certeza.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección (Estándar de Oro) para la acalasia en pacientes aptos para cirugía?

A) Cardiomiotomía de Heller laparoscópica asociada a una técnica antirreflujo (como la de Dor). *

B) Dilatación neumática con balón.

C) Inyección de toxina botulínica.

D) Esofaguectomía total.

Retroalimentación Pregunta 2:

La miotomía de Heller ofrece los mejores resultados a largo plazo. Se acompaña de una funduplicatura parcial (técnica antirreflujo) para evitar la esofagitis postoperatoria, ya que al seccionar el esfínter se pierde la barrera natural contra el ácido.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: PATOLOGÍA RESPIRATORIA (LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS - CRUP)

Dificultad: Media

Caso Clínico 753

Lactante de 18 meses es traído a urgencias a las 2:00 AM por presentar tos ronca ("perruna"), estridor inspiratorio y disfonía. Antecedente de rinorrea y febrícula hace 2 días. A la exploración presenta estridor solo en agitación y retracción supraesternal leve.

Pregunta 1

¿Cuál es el agente etiológico más frecuente y qué signo radiológico se esperaría encontrar en una proyección AP de cuello?

A) Virus Parainfluenza tipo 1; Signo de la "torre" o "punta de lápiz". *

B) Virus Sincitial Respiratorio; Atrapamiento aéreo.

C) Haemophilus influenzae tipo b; Signo del "pulgar".

D) Staphylococcus aureus; Infiltrados algodonosos.

Retroalimentación Pregunta 1:

El Crup es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior en niños de 6 meses a 3 años. La imagen de "punta de lápiz" refleja el estrechamiento subglótico característico.

Pregunta 2

Según la Escala de Westley, el paciente tiene un Crup leve-moderado. ¿Cuál es el tratamiento de elección inicial que ha demostrado reducir la necesidad de hospitalización?

A) Dexametasona (dosis única, oral o IM). *

B) Antibióticos de amplio espectro.

C) Nebulización con solución salina únicamente.

D) Jarabe para la tos con dextrometorfano.

Retroalimentación Pregunta 2:

Los corticoides son el pilar del tratamiento en todos los niveles de severidad del Crup. En casos con estridor en reposo (moderado-grave), se añade epinefrina racémica nebulizada para un efecto rápido mientras el corticoide actúa.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: PATOLOGÍA RESPIRATORIA (ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 757

Niño de 2 años se encontraba jugando con piezas de construcción pequeñas. De forma súbita, presenta cuadro de cianosis, tos irritativa y estridor. Al llegar a urgencias, se ausculta una disminución de la entrada de aire y sibilancias localizadas en el hemitórax derecho.

Pregunta 1

¿Cuál es la localización anatómica más frecuente donde se alojan los cuerpos extraños aspirados y qué hallazgo radiológico esperaría encontrar?

A) Bronquio principal derecho; Atrapamiento aéreo (hiperclaridad) e hipoventilación. *

B) Bronquio principal izquierdo; Consolidación neumónica.

C) Tráquea superior; Signo de la torre.

D) Esófago medio; Estrechamiento mediastínico.

Retroalimentación Pregunta 1:

El bronquio derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo, lo que facilita el paso de objetos. En la radiografía (especialmente en espiración), el pulmón afectado se ve más claro (insuflado) debido al mecanismo de válvula que permite la entrada de aire pero no su salida.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de elección, tanto diagnóstico como terapéutico, ante la sospecha de aspiración de cuerpo extraño?

A) Broncoscopia rígida. *

B) Broncoscopia flexible.

C) TAC de tórax de alta resolución.

D) Serie esófago-gastro-duodenal.

Retroalimentación Pregunta 2:

La broncoscopia rígida es el estándar de oro ya que permite una mejor visualización, control de la vía aérea y el uso de pinzas especiales para la extracción del objeto, superando a la flexible en este escenario de urgencia.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: NEONATOLOGÍA (TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO - RN)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 760

Recién nacido a término (38 semanas) obtenido mediante cesárea electiva sin trabajo de parto previo. Presenta taquipnea (FR 85 rpm) y cianosis leve que resuelve con oxígeno al 40%. A la exploración: tórax ligeramente distendido, sin ruidos agregados. La radiografía muestra congestión hiliar, líquido en las cisuras (cisuritis) y rectificación de las costillas.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa fisiopatológica de esta entidad?

A) Retraso en la reabsorción del líquido alveolar por los canales de sodio epiteliales. *

B) Destrucción del surfactante por la presencia de sangre.

C) Invasión bacteriana del parénquima pulmonar.

D) Hipoplasia pulmonar severa.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Taquipnea Transitoria (o Síndrome de Pulmón Húmedo) es típica del RN a término nacido por cesárea, ya que no se produce el "exprimido" torácico del canal de parto ni el pico de catecolaminas/esteroides que activa la reabsorción de líquido.

Pregunta 2

¿Cuál es el pronóstico habitual y el tratamiento recomendado para esta patología?

A) Resolución espontánea en 24 a 72 horas; Soporte con oxígeno y alimentación por sonda si la FR es >60 rpm. *

B) Necesidad de ventilación mecánica prolongada; Antibióticos.

C) Desarrollo de hipertensión pulmonar crónica.

D) Requiere administración de surfactante de rescate.

Retroalimentación Pregunta 2:

Es un cuadro benigno y autolimitado. El manejo es conservador. Es vital recordar que si la frecuencia respiratoria es >80 rpm, se debe suspender la vía oral para evitar la broncoaspiración, optando por alimentación por sonda o ayuno con líquidos IV.

Tema: PEDIATRÍA

Subtema: PATOLOGÍA RESPIRATORIA (HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA)

Dificultad: Alta

Caso Clínico 763

Recién nacido de término presenta dificultad respiratoria grave de forma inmediata al nacimiento, abdomen excavado (en batea) y ruidos cardiacos desplazados a la derecha. A la auscultación se detectan ruidos peristálticos en el hemitórax izquierdo.

Pregunta 1

¿Cuál es la localización más frecuente de este defecto (nombre de la hernia) y cuál es la principal causa de mortalidad asociada?

A) Posterior izquierda (Bochdalek); Hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar. *

B) Anterior derecha (Morgagni); Neumonía recurrente.

C) Hiatal; Reflujo gastroesofágico.

D) Paraesofágica; Estrangulación gástrica.

Retroalimentación Pregunta 1:

La hernia de Bochdalek (posterior e izquierda) es la más común (80-90%). El problema no es el defecto diafragmático en sí, sino que las vísceras en el tórax impiden el desarrollo normal del pulmón ipsilateral (y a veces el contralateral), causando una hipoplasia que lleva a hipertensión pulmonar severa.

Pregunta 2

¿Cuál es la medida de manejo inicial contraindicada en la sala de partos para este paciente?

A) Ventilación con bolsa-válvula-mascarilla (ambú). *

B) Intubación endotraqueal inmediata.

C) Colocación de sonda orogástrica para descompresión.

D) Monitorización de saturación pre y post-ductal.

Retroalimentación Pregunta 2:

La ventilación con mascarilla introduce aire en el estómago y las asas intestinales que están dentro del tórax, lo que aumenta la compresión del pulmón y empeora el distrés respiratorio. El paciente debe ser intubado de inmediato para proteger la vía aérea sin distender el abdomen.

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: PARED ABDOMINAL (HERNIAS VENTRALES Y EPIGÁSTRICAS)

Dificultad: Media

Caso Clínico 766

Varón de 45 años, con antecedente de tabaquismo y obesidad (IMC 32). Acude por presentar una tumoración dolorosa de 2 cm en la línea media, por arriba del ombligo, que no se reduce por completo. Refiere que el dolor aumenta al realizar esfuerzos físicos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el componente anatómico que protruye a través del defecto de la línea alba?

A) Hernia Epigástrica; Grasa preperitoneal. *

B) Hernia Umbilical; Omento mayor.

C) Diástasis de rectos; No hay protrusión de saco.

D) Hernia de Spiegel; Asas de intestino delgado.

Retroalimentación Pregunta 1:

La hernia epigástrica ocurre por defectos en la decusación de las fibras de la línea alba. Generalmente contienen grasa preperitoneal y, debido a que el anillo herniario suele ser pequeño y rígido, tienen un alto riesgo de encarcelamiento y dolor desproporcionado a su tamaño.

Pregunta 2

¿Cuál es la diferencia principal entre una hernia incisional y una eventración?

A) No hay diferencia técnica; ambos términos se refieren a la protrusión a través de una cicatriz quirúrgica previa. *

B) La hernia incisional tiene saco y la eventración no.

C) La eventración es siempre de origen congénito.

D) La hernia incisional solo ocurre en la línea media.

Retroalimentación Pregunta 2:

Clínicamente se usan como sinónimos. El factor de riesgo más importante para su aparición es la infección de la herida quirúrgica previa. El tratamiento de elección en defectos mayores a 2 cm es la plastia con colocación de malla (técnica sublay o supra-aponeurótica).

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: ESÓFAGO (ERGE Y HERNIA HIATAL)

Dificultad: Media

Caso Clínico 769

Hombre de 48 años con pirosis crónica y regurgitación ácida de 5 años de evolución que no mejora del todo con IBP. La serie esófago-gastro-duodenal muestra que la unión esofagogástrica y el fondo gástrico se encuentran desplazados por arriba del hiato diafragmático.

Pregunta 1

¿Cómo se clasifica esta hernia hiatal y cuál es el estudio funcional más importante antes de decidir un abordaje quirúrgico?

A) Hernia Hiatal Tipo II (Paraesofágica); Manometría esofágica.

B) Hernia Hiatal Tipo I (Por deslizamiento); Manometría esofágica. *

C) Hernia Hiatal Tipo III (Mixta); Endoscopia únicamente.

D) Hernia de Morgagni; pH-metría de 24 horas.

Retroalimentación Pregunta 1:

La hernia tipo I (deslizamiento) es la más común (90%) y se asocia típicamente a ERGE. La manometría es obligatoria antes de la cirugía para descartar trastornos motores (como acalasia) que contraindicarían una funduplicatura total.

Pregunta 2

¿Cuál es la técnica quirúrgica considerada el estándar de oro para el tratamiento de la ERGE con hernia hiatal y en qué consiste?

A) Funduplicatura tipo Nissen (360°); El fondo gástrico rodea completamente al esófago. *

B) Funduplicatura tipo Toupet (270°); Es una plicatura posterior parcial.

C) Técnica de Thal.

D) Esofagectomía distal.

Retroalimentación Pregunta 2:

La técnica de Nissen laparoscópica es el procedimiento de elección. Si la manometría reporta una motilidad esofágica muy pobre, se prefiere una técnica parcial (Toupet) para evitar la disfagia postoperatoria severa.

Tema: CIRUGÍA GENERAL / UROLOGÍA

Subtema: LITIASIS RENAL (CÓLICO NEFRÍTICO)

Dificultad: Media

Caso Clínico 772

Hombre de 35 años acude por dolor súbito, intenso, en flanco derecho que se irradia a región inguinal y testículo ipsilateral. Presenta náuseas, vómito y agitación psicomotriz (no encuentra posición antiálgica). El examen de orina muestra hematuria microscópica.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de imagen inicial de elección ("estándar de oro") para el diagnóstico de litiasis urinaria en el servicio de urgencias?

A) Tomografía Computarizada Helicoidal no contrastada (Urotac). *

B) Radiografía simple de abdomen (KUB).

C) Ultrasonido renal y vesical.

D) Urografía excretora.

Retroalimentación Pregunta 1:

La Urotac es el estudio más sensible y específico (casi 100%) para detectar litos, permitiendo conocer su tamaño, ubicación y densidad (unidades Hounsfield), lo cual es crucial para planear el tratamiento.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para un lito ureteral de 12 mm situado en el uréter proximal que causa hidronefrosis severa?

A) Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque (LEOCH) o Ureteroscopia. *

B) Manejo conservador con tamsulosina y analgésicos.

C) Nefrolitotomía percutánea.

D) Cistoscopia simple.

Retroalimentación Pregunta 2:

Litos menores a 5 mm suelen expulsarse solos. Entre 5 y 10 mm se intenta manejo médico expulsivo. Litos >10 mm o con complicaciones (dolor refractario, falla renal) requieren intervención activa.

Tema: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Subtema: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA (MASTOPATÍA FIBROQUÍSTICA)

Dificultad: Baja

Caso Clínico 775

Mujer de 32 años refiere dolor mamario bilateral (mastalgia) que aumenta de intensidad durante la fase lútea del ciclo menstrual y disminuye tras la menstruación. A la exploración física se palpan zonas de consistencia nodular, difusas, en cuadrantes superiores externos de ambas mamas, sin ganglios axilares sospechosos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el manejo inicial recomendado?

A) Mastopatía fibroquística; Medidas generales (soporte mamario firme, disminución de cafeína) y seguimiento. *

B) Cáncer de mama lobulillar; Biopsia por aspiración inmediata.

C) Mastitis granulomatosa; Corticosteroides sistémicos.

D) Necrosis grasa; Compresas calientes y drenaje.

Retroalimentación Pregunta 1:

La condición fibroquística es la patología benigna más frecuente. Su característica patognomónica es el dolor cíclico (mastodinia) relacionado con las fluctuaciones hormonales. No se considera una lesión premaligna en su forma simple.

Pregunta 2

¿Qué estudio de imagen es el de primera elección para evaluar la mama en esta paciente dada su edad?

A) Ultrasonido mamario. *

B) Mastografía bilateral.

C) Resonancia Magnética con contraste.

D) Galactografía.

Retroalimentación Pregunta 2:

En mujeres menores de 35 años, el tejido mamario es denso, lo que limita la sensibilidad de la mastografía. El ultrasonido es el estándar para caracterizar nódulos y diferenciar quistes de lesiones sólidas en este grupo de edad.